



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 jomada II 1428 – 19 juin 2007

150^{ème} année

N° 49

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

- Décret n° 2007-1398 du 11 juin 2007**, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements 2075
- Décret n° 2007-1399 du 11 juin 2007**, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs..... 2075
- Décret n° 2007-1400 du 11 juin 2007**, modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise 2076

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

- Décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007**, relatif à la détermination du barème d'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine 2077
- Décret n° 2007-1402 du 18 juin 2007**, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2007-2008 2087
- Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier de certaines périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Zaghouan et Kairouan 2094

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

- Décret n° 2007-1403 du 11 juin 2007**, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence nationale de protection de l'environnement..... 2095

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2007-1404 du 11 juin 2007, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.....	2098
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêtés de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain dans quelques communes des gouvernorats de Zaghouan, Mahdia, Monastir et Sfax	2100
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Décret n° 2007-1405 du 11 juin 2007, portant approbation du statut particulier du personnel du centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme	2103
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 11 juin 2007, portant approbation du barème des incapacités permanentes.....	2104
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d'assurance maladie et ses étapes d'application.....	2154

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Décret n° 2007-1398 du 11 juin 2007, complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajoutée au point 14 « Services d'études, de conseils, d'expertise d'assistance » de la liste des activités des services prévue par les listes des activités relevant des secteurs annexées au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, l'activité suivante :

- Bureaux de conseils à la création des entreprises.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1399 du 11 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-586 du 1^{er} mars 2006,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 7 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 7 (nouveau). - Les primes d'investissement, telles que fixées par les articles 4, 6 et le premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 (nouveau) du présent décret, sont octroyées en trois tranches comme suit :

- 40% lors du démarrage de la réalisation du projet,
- 40% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,
- 20% à l'entrée en production du projet.

La prime, telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 5 (nouveau) du présent décret, est octroyée comme suit :

- en une seule tranche et dès l'obtention de la décision d'octroi d'avantages quant à la prime d'étude,
- sous forme de « chèque service » quant à la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières années à partir de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages et englobe les opérations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.

Les primes, telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

- à l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activités de services prévus à l'article 2 du présent décret,

- aux articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. - Est ajouté à la liste « A » relative aux investissements immatériels et annexée au décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé, ce qui suit :

- Opérations de pilotage des projets.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1400 du 11 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié

et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-586 du 1er mars 2006,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-165 du 26 janvier 2005,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté à l'article 3 (nouveau) du décret n° 99-484 du 1er mars 1999 susvisé, un troisième paragraphe dont la teneur est la suivante :

Article 3 (nouveau) paragraphe 3 (nouveau). - Les primes, telles que fixées par le paragraphe 2 du présent article, sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Art. 2. - Est ajouté à la liste « A » relative aux investissements immatériels et annexée au décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé, ce qui suit :

- Opérations de pilotage des projets.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine.

*Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat,*

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu le décret-loi n°62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, modifié et complété par le décret-loi n°70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n°62-18 du 24 mai 1962 et n°70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986.

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date, la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.

Vu le décret n° 2001-864 du 18 avril 2001 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2000-2001.

Vu le décret n° 2005-1983 du 11 juillet 2005 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2005-2006.

Vu l'avis du ministre des finances ,

Vu l'avis du tribunal administratif,

DECRETE :

Article premier : Le présent décret fixe les critères techniques devant être appliqués pour l'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat.

Article 2 : Le blé dur et le blé tendre, objet de l'agrèage, doivent être saines, loyales et marchandes.

Article 3 : Le prix final d'achat du blé dur et du blé tendre produits localement et le prix final de vente du blé dur et du blé tendre produits localement et importés sont fixés successivement sur la base des prix de base à la production et des prix de rétrocessions à la vente du blé dur et du blé tendre, tels que fixés par la législation et la réglementation en vigueur additionnés aux bonifications et réfections calculées sur la base du barème d'agrèage fixé par les tableaux objet de l'annexe I pour le blé dur et l'annexe II pour le blé tendre, du présent décret.

Article 4 : L'opération de prélèvement d'échantillons doit être conforme aux normes techniques tunisiennes approuvées par la réglementation en vigueur. Le prélèvement d'échantillons s'effectue dans les silos et les centres de collecte des établissements de collecte ainsi que dans les ports tunisiens.

Article 5 : Le prélèvement d'échantillons doit être effectué en présence de l'acheteur et du vendeur. Chacun d'eux reçoit obligatoirement un échantillon représentatif de la marchandise. Un troisième échantillon est adressé au laboratoire d'analyse. Les échantillons doivent être fermés, scellés et doivent comporter l'étiquette d'identification. La réception d'un exemplaire d'échantillon par les parties est considérée comme une reconnaissance de la conformité de l'opération d'échantillonnage.

Article 6 : Les analyses physiques, chimiques et rhéologiques doivent être conformes aux procédures et normes techniques fixées dans les annexes I et II du présent décret et notamment dans les barèmes objet des tableaux y figurant .

Article 7 : En cas d'opposition de l'une des parties aux résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la constitution d'un échantillon de synthèse composé de l'échantillon revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses.

Les frais de l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition et ce indépendamment des résultats des nouvelles analyses.

Article 8 : L'opération de reprise des analyses physiques, chimiques et rhéologiques doit être conforme aux mêmes procédures et prescriptions techniques prévues à l'article 6 du présent décret. Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.

Article 9 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 10 : Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Tunis, le 18 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe I

SPECIFICITES TECHNIQUES ET CALCUL DES BONIFICATIONS ET DES REFACTIONS RELATIFS A L'ACHAT DU BLE DUR PRODUIT LOCALEMENT ET A LA VENTE DU BLE DUR PRODUIT LOCALEMENT ET IMPORTE

A. SPECIFICITES TECHNIQUES

Spécificités physiques : Ce sont des critères applicables à l'achat et à la vente

Les spécificités physiques comportent le poids spécifique, l'humidité et les impuretés totales.

Les impuretés totales

Les impuretés totales comprennent les impuretés grains, les impuretés diverses, les grains cassés, les grains germés, et les grains mouchetés.

Les impuretés grains

Les impuretés grains comprennent les grains échaudés, les autres céréales, le blé tendre dans le blé dur, les grains présentant des colorations du germe, les grains chauffés, les grains punaisés et/ou les grains attaqués par les déprédateurs.

Les impuretés diverses

Les impuretés diverses comprennent les impuretés proprement dites, les graines étrangères, les graines nuisibles (l'ail, le mélilot, le fenugrec, l'ivraie), l'ergot, les grains cariés, les grains avariés, les grains brûlés, les insectes morts et les fragments d'insectes.

○ Matériel utilisé et normes appliquées

L'analyse des spécificités figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cet annexe du blé dur à l'achat et à la vente se fait conformément au matériel et aux normes suivantes :

- La détermination du poids spécifique se fait à l'aide de la trémie conique de 50 litres ou le Nilemalitre conformément au décret n°864/2001.
- Le taux des grains cassés est défini par les éléments qui passent à travers les mailles du tamis (2x20) mm selon la norme tunisienne NT 8413/2001.
- La détermination des grains mitadinés se fait selon la norme internationale ISO 11051/1994 correspondant à la norme tunisienne NT 5180/1994.

• Spécificité chimique : Le taux des protéines : applicable uniquement à la vente

L'analyse du taux des protéines est faite uniquement à la vente du blé dur aux minoteries. Elle se fait sur matière sèche et selon la norme NF V03-750/1999.

B. CALCUL DES BONIFICATIONS ET DES REFACTIONS

Le calcul des bonifications et des réfections relatif à chaque critère de qualité du blé dur se fait en se basant sur la linéarité conformément au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe et selon ce qui suit :

- Si un grain présente plusieurs défauts à la fois faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés et mitadinés) le grain sera classé parmi ceux qui présentent le défaut le plus important.
- Pour l'Humidité, la bonification est de valeur maximale lorsque sa mesure est inférieure ou égale à 10%.
- Pour le mitadin, la réfaction est maximale lorsque sa mesure est supérieure ou égale à 54%.
- Les réfections seront doublées pour tout point au dessous de la limite inférieure de la plage normale relatif au poids spécifique et au taux des protéines et pour tout point au dessus de la limite supérieure de la plage normale pour le reste des critères ou groupes de critères mentionnés au paragraphe (c) conformément au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe. Ces réfections doublées seront ajoutées aux réfections calculées à l'intérieur des plages normales. Toutefois, le prix final à l'achat ou à la vente ne doit pas descendre par suite de ces réfections au dessous d'un prix minimal égal au prix officiel du son.

C. ANALYSES DES CRITERES DEPASSANT LES PLAGES NORMALES DE REFACTION DU BAREME D'AGREAGE

1. L'humidité

Lorsque le taux d'humidité dépasse 14%, le blé sera considéré comme non marchand et de ce fait, il est refusé.

2. Le poids spécifique

Lorsque le poids spécifique d'un lot de blé dur est au dessous de 72kg/hl, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

3. Les impuretés totales

Lorsque le taux des impuretés totales d'un lot de blé dur est au dessus de 14%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

4. Les grains cassés

Lorsque le taux des grains cassés d'un lot de blé dur est au dessus de 6%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

5. Les grains germés

Lorsque le taux des grains germés d'un lot de blé dur est au dessus de 4%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

6. Les impuretés grains

Lorsque le taux des impuretés grains d'un lot de blé dur est au dessus de 8%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau n° 1.

Dans le cas où le critère Autres céréales est au dessus de 3%, ou bien les grains chauffés sont au dessus de 0,5%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

7. Les impuretés diverses

Lorsque le taux des impuretés diverses d'un lot de blé dur est au dessus de 5%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

Dans le cas où l'un des grains nuisibles sont au dessus de 0,1%, ou les grains brûlés sont au dessus de 0,05%, et l'Ergot est au dessus de 0,05%, on applique une réfaction double pour le critère en question selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

8. Les grains mouchetés

Lorsque le taux des grains mouchetés dont les grains fusariés d'un lot de blé dur est au dessus de 5%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau n° 1.

Et dans le cas où le taux des grains fusariés est au dessus de 1,5%, on applique une réfaction double selon la formulation appliquée figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

9. Le taux des protéines

Pour la vente du blé dur aux minoteries, lorsque le taux des protéines est au dessous de 11,5% on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

D. BAREME DE BLE DUR A L'ACHAT ET A LA VENTE

Le barème de blé dur à l'achat et à la vente est fixé conformément au tableau suivant :

BAREME UNIFIE DE BLE DUR (appliqué à l'achat et à la vente)

Les plages normales										Hors plages normales	
N°	Critère	Bonification (+)			Plage neutre	Réfaction (-) (A)			limite inférieure	Réfaction double par point au dessous de la limite inférieure normale (-) (B)	
		limite supérieure	Plage	Formule		Plage	Formule			((Prix du blé x 10%) x (72 - Ps mesuré)) x 2	
1	Poids spécifique kg/hl				≥ 80 kg/hl	79,9 - 72,0	(Prix du blé x 10%) x (80 - Ps mesuré)		72		
N°	Critères	Bonification (+)			Plage neutre	Réfaction (-) (A)			limite supérieure	Réfaction double par point au dessous de la limite supérieure normale (-) (B)	
2	Humidité %	10	10,0 - 11,9	(Prix du blé x 10%) x (12 - taux)	12 - 14	Rien			14	REFUS	
3	Impuretés %										
3-1	G. casés %	Rien			0 - 2,5	2,6 - 6,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2,5)		6	((Prix du blé x 5%) x (taux - 6)) x 2	
3-2	G. maligrés								3	((Prix du blé x 5%) x (taux - 3)) x 2	
	Autres céréales								8		
	Blé tendre				0 - 2	2,1 - 8,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2)		0,5	((Prix du blé x 5%) x (taux - 8)) x 2	
	Coloration du germe										
3-3	G. chauffés										
	G. attaq/depredateurs G. punaisés										
3-4	G. mouchetés %	Rien							5	((Prix du blé x 10%) x (taux - 1,5)) x 2	
3-5	G. fusariés %								1, 5		
	G. étrangers				0 - 2,5	2,6 - 4,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2,5)		4	((Prix du blé x 5%) x (taux - 4)) x 2	
	Graines nuisibles										
	Graines avariées								0,1	((Prix du blé x 10%) x (taux - 0,1)) x 2	
4	G. brûlés								0,1	Idem	
	Imp. proprement dites								0,1	Idem	
	Erget								0,1	Idem	
	Grains cariés								0,05	((Prix du blé x 10%) x (taux - 0,05)) x 2	
5	Insectes ou fragments d'insectes morts								0,05	REFUS	
6	Impuretés totales %										
7	Grains mitadinés %								14	((Prix du blé x 10%) x (taux - 14)) x 2	
8	Grains mitadinés %								54	Au delà de 54%, on applique le même taux de réfaction appliqué pour 54%	
N°	Critère	Bonification (+)			Plage neutre	Réfaction (-) (A)			limite inférieure	Réfaction double par point au dessous de la limite inférieure normale (-) (B)	
9	Proteines % ⁽¹⁾								11,5	((Prix du blé x 10%) x (11,5 - taux)) x 2	

⁽¹⁾ Pour les taux d'humidité au dessous de 10% on applique la même bonification appliquée pour 10%.

Le taux des protéines est pris en compte uniquement dans la valorisation des céréales vendues aux minoteries.

Le total des réfections = Σ des réfections des plages normales + Σ des réfections doublées pour hors plages normales : (A) + (B)
Prix du blé= Prix de base à l'achat ou prix de retrocession à la vente

Annexe II

SPECIFICITES TECHNIQUES ET CALCUL DES BONIFICATIONS ET DES REFRACTIONS RELATIFS A L'ACHAT DU BLE TENDRE PRODUIT LOCALEMENT ET A LA VENTE DU BLE TENDRE PRODUIT LOCALEMENT ET IMPORTE

A. SPECIFICITES TECHNIQUES

Spécificités physiques : Ce sont des critères applicables à l'achat et à la vente

Les spécificités physiques comportent le poids spécifique, l'humidité et les impuretés totales.

Les impuretés totales

Les impuretés totales comprennent les grains cassés, les grains germés, les impuretés grains, les impuretés diverses et les grains mouchetés.

Les impuretés grains

Les impuretés grains comprennent les grains échaudés, les autres céréales, les grains présentant des colorations du germe, les grains chauffés, les grains punaisés et les grains attaqués par les déprédateurs.

Les impuretés diverses

Les impuretés diverses comprennent les impuretés proprement dites, les graines étrangères, les graines nuisibles (l'ail, le mélilot, le fenugrec, l'ivraie), l'ergot, les grains cariés, les grains avariés, les grains brûlés, les insectes morts et les fragments d'insectes.

○ Matériel utilisé et normes appliquées

L'analyse des spécificités figurant au tableau n°2 du blé tendre à l'achat et à la vente se fait conformément au matériel et aux normes suivantes :

La détermination du poids spécifique se fait à l'aide de la trémie conique de 50 litres ou le Nilemalitre conformément au décret n°864/2001.

Le taux des grains cassés est déterminé par les éléments qui passent à travers les mailles du tamis (2x20mm) selon la norme tunisienne NT 8413/2001 .

• Spécificité rhéologique : La force boulangère : applicable uniquement à la vente

La détermination de la force boulangère est faite uniquement à la vente du blé tendre aux minoteries. Elle se fait selon la norme tunisienne NT 5119/1995.

B. CALCUL DES BONIFICATIONS ET DES REFLECTIONS

Le calcul des bonifications et des réflexions relatif à chaque critère de qualité du blé tendre se fait en se basant sur la linéarité conformément au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe et selon ce qui suit :

- Si un grain présente plusieurs défauts à la fois faisant l'objet de réflexions (exemple grains à la fois cassés et germés), le grain sera classé parmi ceux qui présentent le défaut le plus important.
- Pour l'Humidité, la bonification est de valeur maximale lorsque sa mesure est inférieure ou égale à 10%.
- Les réflexions seront doublées pour tout point au dessous de la limite inférieure de la plage normale des réflexions relatif au poids spécifique et à la force boulangère et pour tout point au dessus de la limite supérieure de la plage normale des réflexions pour le reste des critères ou groupes de critères mentionnés au paragraphe (c) conformément au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe. Ces réflexions doubles viennent s'ajouter aux réflexions calculées dans la plage normale des réflexions sans, toutefois, que le prix final à l'achat ou à la vente descend au dessous d'un prix minimal égal au prix officiel du son.

C. ANALYSES DES CRITERES DEPASSANT LES PLAGES NORMALES DE REFLECTION DU BAREME D'AGREAGE

1. L'humidité

Lorsque le taux d'humidité dépasse 15%, le blé sera considéré comme non marchand et de ce fait, il est refusé.

2. Le poids spécifique

Lorsque le poids spécifique d'un lot de blé tendre est au dessous de 70kg/hl, on applique une réflexion double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe

3. Les impuretés totales

Lorsque le taux des impuretés totales d'un lot de blé tendre est au dessus de 14%, on applique une réflexion double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

4. Les grains cassés

Lorsque le taux des grains cassés d'un lot de blé tendre est au dessus de 5%, on applique une réflexion double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

5. Les grains germés

Lorsque le taux des grains germés d'un lot de blé tendre est au dessus de 4%, on applique une réfaction double selon la formulation faite pour les impuretés diverses figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

6. Les impuretés grains

Lorsque le taux des impuretés grains d'un lot de blé tendre est au dessus de 7%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cet annexe.

Lorsque le taux des grains chauffés dépasse 0,5%, on applique pour ce critère une réfaction double selon la formulation des impuretés grains figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

7. Les impuretés diverses

Lorsque le taux des impuretés diverses d'un lot de blé tendre est au dessus de 5%, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau n° 2.

Dans le cas où l'un des grains nuisibles est au dessus de 0,1%, ou les grains brûlés sont au dessus de 0,05% et l'Ergot est au dessus de 0,05%, on applique une réfaction double pour le critère en question selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

8. La force boulangère

Pour la vente du blé tendre aux minoteries, lorsque l'analyse de la force boulangère est au dessous de 110×10^4 joules, on applique une réfaction double selon la formulation figurant au tableau objet du paragraphe (d) de cette annexe.

D. BAREME DE BLE TENDRE A L'ACHAT ET A LA VENTE

Le barème de blé tendre à l'achat et à la vente est fixé conformément au tableau suivant :

BAREME UNIFIE DE BLE TENDRE (appliqué à l'achat et à la vente)

		Les plages normales				Hors plages normales			
N°	Critère	Bonification (+)		Plage neutre	Réfaction(-) (A)		Réfaction double par point au dessous de la limite inférieure normale (-) (B)		
		limite supérieure	Plage		Formule	Plage	Formule	limite inférieure	
1	Poids spécifique Kg/hl	Rien		≥ 78 kg/hl	77,9 - 70,0	(Prix du blé x 10%) x (78- Ps mesuré)	70	((Prix du blé x 10%) x (Ps mesuré - 70)) x 2	
N°	Critères	Bonification (+)		Plage neutre	Plage	Réfaction (-) (A)	limite supérieure	Réfaction double par point au dessus de la limite supérieure normale (-) (B)	
		limite inférieure	Formule				Formule	15	REFUS
2	Humidité %	10	10,0 -11,9	12 -15	Rien		15	REFUS	
3	Impuretés %								
3-1	G. cassés %	Rien		0 - 2,5	2,6 - 5,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2,5)	5	((Prix du blé x 5%) x (taux - 5)) x 2	
3-2	G. malgres	Rien		0 - 2	2,1 - 7,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2)	0,5	7	((Prix du blé x 5%) x (taux - 0,5)) x 2
	Autres céréales	Rien							
	G chauffés	Rien							
	G. punaisés	Rien							
	G. attaqué/deprédateurs	Rien							
3-3	Coloration du germe	Rien		0 - 2,5	2,6 - 4,0	(Prix du blé x 5%) x (taux - 2,5)	4		((Prix du blé x 5%) x (taux - 4)) x 2
	G. fusariés	Rien							
3-4	Grains germés %	Rien		0 - 1,4	1,5 - 5,0	(Prix du blé x 10%) x (taux - 1,4)	5		((Prix du blé x 10%) x (taux - 5)) x 2
	G. étrangères	Rien							
	Graines nuisibles	Rien							
	- All	Rien							
	- Fénu grec	Rien							
	- Ivraie	Rien							
	- Méillet	Rien							
G. avariés	Rien								
G. brûlés	Rien								
Imp proprement dites	Rien								
Ergot	Rien								
Grains cariés	Rien								
Insectes ou fragments d'insectes morts	Rien								
4	Impuretés totales %	Rien		Rien			14		((Prix du blé x 10%) x (taux - 14)) x 2
N°	Critère	Bonification (+)		Plage neutre	Plage	Réfaction (-) (A)	limite inférieure	Réfaction double par point au dessous de la limite inférieure normale (-) (B)	
		limite supérieure	Plage	Formule		Formule			
5	F.boulangère (w x10 ⁻⁴)	Rien		Rien			110	((Prix du blé x 10%) x (110 - W mesurée)) x 2	

B : (1) Pour les taux d'humidité au dessous de 10% on applique le même taux appliqué pour 10%

(*) La force boulangère est pris en compte uniquement dans la valorisation des céréales vendues aux minoteries

Le total des réfections = Σ des réfections des plages normales + Σ des réfections doublées pour hors plages normales : (A) + (B)

Prix de blé= Prix de base à l'achat ou prix de retrocession à la vente

Décret n° 2007-1402 du 18 juin 2007, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2007-2008.

Le Président de la république,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8.

Vu le décret du 31 mai 1956 relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n°81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n°62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, modifié et complété par le décret-loi n°70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n°62-18 du 24 mai 1962 et n°70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n°86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu le décret n°90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu le décret n°2001-864 du 18 Avril 2001, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales pour la campagne 2000-2001,

Vu le décret n°2005-1983 du 11 Juillet 2005, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales pour la campagne 2005-2006,

Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrégé du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

DECRETE :

Titre premier : Prix à la production et fermages

Article premier : Les prix de base à la production des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2007 sont fixés comme suit :

blé dur	: 32,782 D/ql
blé tendre	: 28,732 D/ql
triticale	: 20,000 D/ql

La commercialisation de l'orge est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 20,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stokeurs au titre de l'acquisition d'orge qui leur sera livrée par les producteurs.

Article 2 : Les prix de base à la production fixés à l'article 1^{er} du présent décret s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les spécificités techniques sont arrêtées au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrégation du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine.

Article 3 : Le prix de base à la production fixé à l'article 1^{er} du présent décret s'entendent pour l'orge et le triticale dont les spécificités techniques sont arrêtées à l'annexe I du présent décret.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe 1 du présent décret.

La réfaction à appliquer est fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, chacune des deux parties peut demander l'arbitrage de l'office des céréales.

Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

La partie concernée, présente l'objet du désaccord à un laboratoire relevant de l'office des céréales ou du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, selon le cas. Le règlement du désaccord doit s'effectuer sur la base des résultats de l'expertise. Le résultat de l'arbitrage oblige l'acheteur et le vendeur.

Article 4 : Les prix de fermage servis aux producteurs sont les prix de base prévus à l'article 1^{er} du présent décret, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 5 du présent décret.

Titre deux : paiement, rétrocession et stockage

Article 5 : La taxe de statistique instituée par le décret-loi n°62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,280 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales de la récolte 2007.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de Finances pour l'année 2000.

Article 6 : La marge brute de rétrocession des céréales des organismes collecteurs et stockeurs comprend :

a) une prime de magasinage prévue à l'article 11 du présent décret,

b) une marge nette de rétrocession : 1,987 D/ql

c) une péréquation de transport : 1,261 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution.

d) une somme de 0,100 D par ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

Article 7 : Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticales par les organismes collecteurs et stockeurs comprennent :

a - le prix de base fixé par l'article premier du présent décret,

b - la marge brute de rétrocession des organismes collecteurs et stockeurs prévue par l'article 6 du présent décret.

Ainsi, les prix normaux de rétrocession s'établissent comme

- blé dur	: 38,230 D/ql
- blé tendre	: 34,012 D/ql
- orge	: 24,908 D/ql
- triticales	: 24,908 D/ql

Article 8 : La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2007 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticales sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 9 : Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréege du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine et conformément aux conditions prévues à l'annexe I du présent décret pour l'orge et le triticales

**Titre trois :
Obligations des collecteurs**

Article 10 : Les collecteurs agréés versent à l'office des céréales :

1 - la taxe de statistique fixée par l'article 4 du présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs,

2 - par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales rétrocedé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix normaux de rétrocession tels que prévus par l'article 7 du présent décret :

- une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 11 du présent décret fixée comme suit :

- blé dur : 2,100 D/ql
- blé tendre : 1,932 D/ql
- orge : 1,560 D/ql
- triticales : 1,560 D/ql

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez les organismes concernés.

b- une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

3 - par quintal de blé dur et de blé tendre, livrés directement de la culture aux semouleries ou minoteries, une somme de 0,075 D/ql à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds spécial de l'office des céréales ».

Article 11 : Les organismes collecteurs et stockeurs bénéficient d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2007.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

- blé dur : 0,350D/ql
- blé tendre : 0,322 D/ql
- orge : 0,260 D/ql
- triticale : 0,260 D/ql

Cette prime bimensuelle est calculée sur la base des stocks au magasin à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Les modalités de règlement de la prime de magasinage sont fixées dans l'annexe II du présent décret.

Article 12 : Les organismes collecteurs et stockeurs qui livrent des blés, orge et triticale de la récolte 2007 à un prix de rétrocession réduit conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus reçoivent une prime de compensation telle que définie par l'article 13 du présent décret.

Article 13 : Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 7 ci-dessus, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par décision du ministre du commerce et de l'artisanat après ajustements des dits prix par l'application du barème d'agrèage à l'achat et à la vente.

Article 14 : Les montants des primes de magasinage prévues à l'article 11 ci-dessous ainsi que les différences de barème sont imputés sur le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « soutien du marché des céréales ».

Article 15 : Sont applicables à la campagne 2006/2007, les dispositions du décret n°2005-1983 du 11 juillet 2005 susvisé.

Article 16 : Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l'artisanat, et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe I
Spécificités techniques et barème des bonifications
et des réfections de l'orge et du triticales

A/ Spécificités techniques :

1) Pour l'orge :

Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

2) Pour le triticales :

Le prix de base du triticales s'entend pour un triticales rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

B/ Barème des bonifications et des réfections :

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour l'orge et le triticales selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.

Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfection la plus forte est appliquée.

Annexe II

Modalités pratiques de règlement de la prime de magasinage

Le règlement des frais de magasinage d'entretien et de conservation des céréales au profit des organismes collecteurs et stockeurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.

Les organismes collecteurs et stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des primes visées à l'article 11 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant des mémoires correspondants, à raison de 10% pour chaque mois de retard.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Soughas de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2004-1274 du 31 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Soughas,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Soughas,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Zaghouan le 21 août 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Soughas de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rhima 2 de la délégation de Hajeb Laayoun, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-16 du 3 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Rhima 2,

Vu l'arrêté du 7 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Rhima 2,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 4 décembre 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rhima 2 de la délégation de Hajeb Laayoun, au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chouayhia de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2004-1285 du 31 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Chouayhia,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chouayhia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 4 décembre 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Chouayhia de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2007-1403 du 11 juin 2007, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'agence nationale de protection de l'environnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 88-1784 du 18 octobre 1988, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de protection de l'environnement, tel que modifié et complété par le décret n° 93-335 du 8 février 1993 et le décret n° 93-1434 du 23 juin 1993,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2004-2229 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale de protection de l'environnement,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2007-446 du 6 mars 2007, fixant l'organigramme de l'agence nationale de protection de l'environnement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret est relatif à la fixation des conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels suivants, au sein de l'agence nationale de protection de l'environnement :

- chef de bureau,
- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur,
- chef de département,

Art. 2. - Les emplois fonctionnels de chef de bureau, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de chef de département au sein de l'agence nationale de protection de l'environnement, ainsi que leur intérim, sont attribués par décision du directeur général de l'agence, et ce, après l'accord de l'autorité de tutelle.

Art. 3. - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

- Le candidat doit être titulaire,
- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'agence.
- Le dossier du candidat ne doit pas contenir des sanctions disciplinaires de deuxième degré.
- Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de bureau	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de deux ans au moins. - Etre titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de cinq ans au moins. - Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de sept ans au moins.
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes: - Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de deux ans au moins. - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de 5 ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de bureau durant trois ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise. - Etre titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de sept ans au moins et titulaire dans la catégorie huit du collège cadres, ou avoir exercé la fonction de chef de bureau durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de dix ans au moins, ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de douze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de quinze ans au moins, ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise.
Chef département	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - Etre titulaire d'un mastère ou d'un mastère spécialisé, ou d'un diplôme équivalent, et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de dix sept ans au moins, ou avoir exercé la fonction de directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le mastère ou le mastère spécialisé. - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une ancienneté à l'agence ou dans le secteur public de vingt ans au moins, ou avoir exercé la fonction de directeur durant cinq ans au moins, tout en ayant le diplôme de la maîtrise.

Art. 4. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de bureau, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de chef de département, visés à l'article 2 du présent décret, s'effectue par décision du directeur général et après l'accord du ministère de la tutelle, sur la base d'un rapport écrit présenté par le chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.

Art. 6. - Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question continue à bénéficier, durant une année, des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a occupé tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré ou d'une suspension des fonctions pour faute grave.

- et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 7. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué par décision du directeur général de l'agence pour une

durée d'une année renouvelable une seule fois, aux agents remplissant les conditions de nomination aux postes fonctionnels tels que définies à l'article 3 du présent décret.

Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

La période d'intérim dans l'emploi fonctionnel n'est pas prise en considération dans la condition d'ancienneté exigée dans l'article 3 pour l'attribution des emplois fonctionnels.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'agence nationale de protection de l'environnement.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels concernés entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.

Art. 8. - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels cités à l'article 2 ci-dessus, nonobstant les conditions prévues par le présent décret.

Art. 9. - Le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1404 du 11 juin 2007, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 72-22 du 10 mars 1972, portant création de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou au collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 73-173 du 16 avril 1973, portant organisation et fonctionnement de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, tel que modifié par le décret n° 88-2050 du 19 décembre 1988,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de la formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 99-2514 du 8 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métier, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité du tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1825 du 26 juin 2006, relatif à l'approbation de l'organigramme de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'attribution des emplois fonctionnels de chef de service, chef de département, sous-directeur, directeur et directeur central, est prise par décision du président-directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières conformément à la réglementation en vigueur.

L'attribution de la fonction de directeur général adjoint, est effectuée par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général et après approbation des autorités de tutelle.

Art. 2 - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier, sont attribués selon les conditions suivantes :

1 - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

2 - Le candidat doit remplir les conditions minimales fixées au tableau ci-après, ainsi que les conditions particulières de l'emploi concerné :

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience minimale de deux années dans l'entreprise ou dans ses filiales (dont un minimum de 50 % du capital est détenu par l'Entreprise). 2-Ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience de cinq années au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales. 3- Ou être titulaire d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience de douze ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales.

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Chef département	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1-Etre titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service pendant quatre ans au moins ou une ancienneté de huit ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales. 2 - Ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service pendant cinq ans au moins ou une ancienneté de onze ans dans l'entreprise ou dans ses filiales. 3- Ou être titulaire d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service pendant dix ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de département pendant trois ans au moins ou exercé la fonction de chef de service pendant neuf ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales ou avoir une ancienneté de onze ans au moins dans l'entreprise. 2 - Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de département pendant quatre ans au moins ou exercé la fonction de chef de service pendant onze ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales ou avoir une ancienneté de seize ans au moins dans l'entreprise.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1-Etre titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur pendant quatre ans au moins ou exercé la fonction de chef de département pendant neuf ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales. 2- Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur pendant cinq ans au moins ou exercé la fonction de chef de département pendant onze ans au moins dans l'entreprise ou dans ses filiales.

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Directeur central	Le candidat doit être titulaire au moins d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur pendant quatre ans au moins dans l'entreprise.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus au présent décret bénéficient des indemnités et avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'entreprise.

Art. 4. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de service, chef de département, sous-directeur, directeur et directeur central s'effectue sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.

Le retrait de la fonction entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a occupé et ce, durant une année tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, à condition que :

1 - Le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du 2ème degré ou d'une suspension des fonctions pour faute professionnelle grave.

2 - L'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Au cas où cette condition d'ancienneté n'est pas remplie, l'agent concerné bénéficie des indemnités et des avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur pour une période d'une année tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi de directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 6. - Nonobstant les conditions prévues par le présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels de chef de service, chef de département, sous-directeur, directeur et directeur central à la date de la publication du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels cités à l'article 2 ci-dessus.

Les agents chargés d'emplois fonctionnels non prévus par le présent décret, conservent les indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 7. - La nomination par intérim aux emplois fonctionnels est attribuée pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim perçoit les indemnités et les avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question. Toutefois, les agents chargés d'un intérim à titre de remplacement temporaire continuent à bénéficier uniquement des indemnités et des avantages afférents à leur fonction initiale.

Art. 8. - Le retrait d'emplois fonctionnels par intérim s'effectue sur la base d'une décision du président-directeur général de l'entreprise.

Le retrait de ces emplois par intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Art. 9. - Les agents bénéficiant actuellement de rangs fonctionnels conservent, à titre transitoire, les avantages et indemnités qui leur sont accordés, et ce, jusqu'à leur nomination à des emplois fonctionnels équivalents à leurs rangs ou immédiatement supérieurs.

Art. 10. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain des zones de Bir M'cherga ville et Bir M'cherga gare de la commune de Bir M'cherga, gouvernorat de Zaghuan.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Bir M'cherga,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement urbain de la localité de Bir M'cherga (gouvernorat de Zaghuan), approuvé par le

décret n° 89-1541 du 6 octobre 1989 et révisé par l'arrêté du 18 décembre 1999,

Vu la délibération du conseil municipal de Bir M'cherga réuni le 15 février 2007.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain des zones de Bir M'cherga ville et Bir M'cherga gare de la commune de Bir M'cherga, gouvernorat de Zaghuan, sont délimitées par les lignes fermées (A, B, C, D, E, F) en ce qui concerne la zone de Bir M'cherga ville et (A, B, C, D, E, F, G) en ce qui concerne la zone de Bir M'cherga gare, indiquées respectivement par la couleur jaune et la couleur verte sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans les tableaux suivants :

Zone de Bir M'cherga ville :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	505.280	358.000
B	505.680	357.460
C	505.300	356.740
D	504.600	356.690
E	504.080	357.100
F	504.120	357.580

Zone de Bir M'cherga gare :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	510.460	358.380
B	511.000	357.580
C	510.795	357.000
D	512.100	355.810
E	512.000	355.140
F	511.060	354.720
G	510.600	356.520

Art. 2. - Le président de la commune de Bir M'cherga est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Souassi, gouvernorat de Mahdia.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Souassi,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Souassi, approuvé par le décret n° 77-741 du 12 septembre 1977 et révisé par le décret n° 89-1806 du 23 novembre 1989 et par l'arrêté du 14 novembre 2002,

Vu la délibération du conseil municipal de Souassi réuni le 30 novembre 2006.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Souassi, gouvernorat de Mahdia sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en Km	Y : en Km
A	559.980	228.480
B	559.840	228.330
C	559.720	228.500
D	559.220	228.250
E	558.580	228.190
F	558.120	227.850
G	557.940	227.620
H	557.820	226.960
I	558.050	226.640
J	557.840	226.500
K	557.990	226.370
L	558.900	226.480
M	559.500	226.720
N	559.620	226.180
O	559.740	226.190
P	560.000	226.780
Q	560.000	227.170
R	559.890	227.980

Art. 2. - Le président de la commune de Souassi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Moknine, gouvernorat de Monastir.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Moknine,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Moknine, approuvé par l'arrêté du 29 juin 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Moknine réuni le 29 mai 2006.

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Moknine, gouvernorat de Monastir, sont délimitées par les deux lignes fermées (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, Z2, A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L', M', N', O', P', Q', R', S', T', U', V', W', X', Y', Z', Z1', Z2', A'', B'') et (C'', D'', E'', F'', G'', H'', I'', J'', K'', L'', M'', N'', O'') indiquées par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	591.175	261.765
B	593.580	260.776
C	593.683	259.830
D	593.480	259.390
E	592.821	259.313

Points	X	Y
F	592.925	259.963
G	592.838	260.266
H	592.742	260.331
I	592.225	260.307
J	592.231	259.892
K	592.319	259.962
L	592.354	259.910
M	592.461	259.924
N	592.536	259.423
O	592.423	259.422
P	592.168	259.840
Q	591.842	259.674
R	591.537	259.618
S	592.054	259.403
T	592.428	259.295
U	592.608	259.308
V	592.369	259.232
W	592.393	259.127
X	592.012	259.155
Y	592.045	258.973
Z	592.042	258.747
Z1	592.226	258.792
Z2	592.150	258.394
A'	592.435	258.272
B'	592.382	258.080
C'	592.144	258.103
D'	591.962	257.652
E'	591.871	257.608
F'	591.538	258.152
G'	590.964	257.782
H'	590.603	257.745
I'	590.655	256.883
J'	589.384	256.650
K'	588.026	259.178
L'	588.115	259.360
MI'	588.414	259.581
N'	589.086	259.603
O'	589.094	259.645
P'	589.403	259.712
Q'	589.546	259.793
R'	589.762	259.968
S'	589.858	260.120
T'	589.960	260.203

Points	X	Y
U'	590.002	260.149
V'	590.084	260.213
W'	590.019	260.286
X'	590.188	260.446
Y'	590.235	260.399
Z'	590.264	260.422
Z1'	590.310	260.354
Z2'	590.391	260.420
A''	590.335	260.535
B''	590.930	261.015
C''	593.060	258.890
D''	593.245	258.844
E''	593.735	258.827
F''	593.776	258.745
G''	593.768	258.636
H''	593.486	258.638
I''	593.465	258.719
J''	593.422	258.718
K''	593.386	258.676
L''	593.216	258.676
MI''	593.150	258.726
N''	593.086	258.679
O''	593.005	258.761

Art. 2. - Le président de la commune de Moknine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juin 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khelifa, gouvernorat de Sfax.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Sfax,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Bir Ali Ben Khelifa, approuvé par le décret n° 79-727 du 14 août 1979 et révisé par le décret n° 93-1846 du 7 septembre 1993,

Vu la délibération du conseil municipal de Bir Ali Ben Khelifa réuni le 19 février 2007,

Vu la délibération du conseil régional de Sfax réuni le 23 mars 2007,

Arrête :

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Bir Ali Ben Khelifa, gouvernorat de Sfax sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	519020.8	160674.8
B	518932.8	160044.1
C	518395.5	160031.8
D	518184.6	159867.1
E	518151.0	158727.0
F	517376.0	158764.0
G	517969.0	157853.0
H	517176.6	157852.1
I	516888.3	160133.3
J	516419.5	160216.5
K	516491.3	160611.3
L	516968.4	160786.4

Art. 2. - Le gouverneur de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

**Décret n° 2007-1405 du 11 juin 2007, portant
approbation du statut particulier du personnel du
centre de recherches, d'études, de documentation
et d'information sur la femme.**

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme,
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général
des agents des offices, des établissements publics à
caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi
n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août
1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3
mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n°
2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 92-121 du 29 décembre 1992, portant
création du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme,

la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier
de réparation des préjudices des accidents de travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public,

Vu la loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un
régime de congé de création au profit des agents du secteur
public,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un
régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des
deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des
établissements publics à caractère industriel et commercial et
des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ainsi que
l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété notamment
le décret n° 2004-1326 du juin 2004,

Vu le décret n° 93- 1986 du 27 septembre 1993, fixant
l'organisation administrative et financière et les modalités
de fonctionnement du centre de recherches, d'études, de
documentation et d'information sur la femme, tel que
modifié par le décret n° 99-205 du 31 mars 1999,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et
complété par le décret n° 97- 775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 97-522 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d'application du régime spécial de travail à mi temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 2006- 3275 du 18 décembre 2006, fixant les modalités et les procédures d'octroi du congé de création au profit des agents du secteur public,

Vu le décret 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel du centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme, annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2. - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 11 juin 2007, portant approbation du barème des incapacités permanentes.

Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 131 inséré par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le barème des incapacités permanentes annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

BAREME D'ÉVALUATION MEDICO-LEGALE DES INCAPACITES PERMANENTES DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

INTRODUCTION

La loi n° : 2005-86 du 15 Août 2005, portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, a prévu dans son chapitre II, que l'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation, comprend :

- Les frais de soins imputables à l'accident
- La perte de revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail
- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente.
- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès

L'article 131 prévoit que le taux d'incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d'un barème fixé par un arrêté.

Ce barème vise à fournir les éléments d'estimation du préjudice corporel consécutif aux seuls accidents de la circulation.

Ce barème, bien qu'il s'impose au médecin expert ne présente qu'un caractère indicatif.

1) L'INCAPACITE PERMANENTE :

L'incapacité permanente est définie par l'article 131 de la loi n° : 2005-86, comme étant la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après consolidation, exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenue de l'accident.

Rappelons que la réduction de la capacité fonctionnelle correspond à la réduction de la capacité physiologique, c'est à dire du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel de la personne qui a été blessée.

Le champ d'application de cette capacité est celui de la vie quotidienne, il s'agit donc d'une incapacité générale faite d'une gêne, d'une difficulté ou d'une impossibilité dans les actes de la vie courante, la vie de toute personne dans chacune de ses composantes diurnes et nocturnes. Le concept d'incapacité permanente se réfère donc à une difficulté d'être.

Ainsi donc, se référant aux nouvelles normes internationales des atteintes à la personne distinguant les niveaux lésionnel, fonctionnel et situationnel, on peut dire que l'incapacité permanente situe le niveau fonctionnel, elle est le déficit fonctionnel permanent.

2) CONSOLIDATION MEDICO-LEGALE :

Il importe de rappeler que l'incapacité permanente ne peut être déterminée qu'après consolidation médico-légale.

La consolidation médico-légale est le moment, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de la maladie traumatique, où les lésions se stabilisent et prennent un caractère définitif tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour prévenir une aggravation ou traiter un état séquellaire.

A l'inverse, la « guérison » est le retour à l'état antérieur à l'accident, elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.

3) INCAPACITES MULTIPLES

En cas d'incapacités multiples, la règle doit être de procéder à une évaluation globale de l'incapacité permanente en tenant compte du caractère synergique ou non des incapacités constatées.

Cette évaluation globale ne saurait être la simple somme arithmétique des incapacités en cause. De même, l'usage des formules mathématiques (Balthazard ...) ne peut être qu'un élément parmi d'autres dans l'appréciation du taux global d'incapacité ; l'emploi de ces formules ne doit en aucun cas être considéré comme impératif.

L'évaluation de la capacité restante doit toujours être, dans ces cas difficiles, un moyen de contrôle du caractère réaliste de l'estimation du taux d'incapacité.

4) INFIRMITES ANTERIEURES

Lorsque existait avant l'accident un état pathologique (infirmité, maladie chronique ou séquelles d'un accident antérieur) qui réduisait la capacité physiologique du sujet, l'expert doit le préciser, le décrire et éventuellement évaluer le déficit fonctionnel antérieur à l'accident actuel.

- Si cet état antérieur ne concerne pas la même fonction que celle dont l'intégrité se trouve réduite par l'accident, l'expert ne doit pas calculer sur la capacité restante le taux d'incapacité évaluant les séquelles de l'accident ; il fixe ce taux sans tenir compte de l'état antérieur.
- Si au contraire l'état antérieur et les séquelles actuelles concernent la même fonction, l'expert évalue la capacité restante avant l'accident puis intègre cette donnée dans son évaluation du taux d'incapacité. L'usage de formules mathématiques (Gabrielli...) n'a ici encore, aucun caractère impératif.

1/Fonction Neuropsychique

Ces fonctions sont multiples puisqu'elles comprennent non seulement l'ensemble des fonctions intellectuelles et la plupart des fonctions sensorielles, mais également la commande et la coordination de toutes les fonctions.

L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire qu'après un délai suffisamment long, afin de juger leur permanence et des adaptations aux handicaps.

1-1 /Définition

La fonction neuropsychique a une double dimension, l'une cognitive et l'autre affective, intervenant chacune dans la totalité des activités personnelles d'un sujet.

Quelle que soit la nature de la souffrance en cause, lésionnelle ou émotionnelle, l'expert doit analyser chacune de ces composantes.

Les séquelles des traumatismes crâniens graves : sont maintenant mieux connues depuis que la neuropsychologie s'est intéressée à l'évaluation des victimes de lésions cérébrales, ou cérébrospinales. Deux points méritent cependant d'être rappelés :

- L'encéphale ne peut être assimilé à un ensemble de structures spécialisées, indépendantes les unes des autres, dont l'évaluation analytique, fonction par fonction serait suffisante pour appréhender les séquelles laissées par un accident. Si la spécialisation fonctionnelle de certaines régions du cerveau permet d'établir une corrélation anatomo-clinique entre certaines lésions et certaines manifestations, l'ensemble de l'encéphale se trouve néanmoins toujours engagé dans chacune de ses activités.

- Les lésions encéphaliques étant diffuses et/ou multiples chez les traumatisés crâniens, seule une évaluation globale peut refléter la réalité d'une diminution de la capacité de la fonction neuropsychique chez ces blessés.

L'évaluation de la fonction neuropsychique concerne également tous les troubles psychiques ou psychopathologiques qui apparaissent au décours d'un accident, qu'il y ait ou non traumatisme crânien, mais qui peuvent aussi résulter d'une maladie psychique évolutive non traumatique. Les troubles apparents ou allégués doivent être restitués dans une étude de la

biographie, des conduites « instinctives » (activités générales, sommeil, comportement alimentaire, sexualité), de la régulation thymique et des traits de la personnalité. Le rôle de certains médicaments, notamment psychotropes doit être pris en compte.

C'est dire que la séparation artificielle entre le champ d'investigation neurologique, dans le domaine neuropsychologique, et le champ d'investigation psychiatrique, doit conduire à mettre en place une méthode d'investigation simple. La mesure du taux d'incapacité doit reposer sur une étude fonctionnelle analytique des déficits, mais aussi sur une évaluation globale de la fonction neuropsychique.

Les problèmes d'imputabilité, et notamment d'état antérieur, parfois particulièrement difficiles, doivent être résolus préalablement à toute tentative d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle. Certaines affections et certains troubles décrits ne sont jamais, ou exceptionnellement, d'origine traumatique.

1-2/Perte de la fonction = 99%

- Absence totale de toute vie de relation, même s'il persiste une vie végétative = 99% (état végétatif chronique, par exemple)

- Altération massive des fonctions intellectuelles supérieures = 90% (la fonction motrice étant préservée).

1-3/Critères d'appréciation d'une altération de la fonction neuropsychique

Ces critères sont accessibles par un examen neurologique et psychiatrique systématique. Cet examen suppose un sens aiguisé de l'observation, une bonne qualité d'écoute et une technique d'entretien chevronnée. Il ne peut se limiter à un questionnaire type « check-list », nécessairement orienté et potentiellement inducteur. Un véritable examen n'est pas non plus un enregistrement de doléances ; il doit être une évaluation clinique globale et systématique de la fonction neuropsychique, se référant à des critères fiables et consensuels.

Quelle que soit la technique d'examen, elle doit permettre d'établir une liste de signes ou symptômes positifs et négatifs, pour aboutir à leur classification en d'éventuels syndromes et à l'identification d'une ou de plusieurs unités. C'est à dire un ou plusieurs diagnostics.

La classification internationale type CIM 10 et la « critérologie statistique type DSM IV », sont des références utiles pour la discussion, mais beaucoup trop réductrices pour guider l'examen.

L'expert doit réaliser un examen clinique rigoureux d'abord psychiatrique, puis neuropsychologique. Les tests sont à interpréter en fonction des lésions initiales et de l'évolution clinique. L'interprétation contradictoire de plusieurs tests, réalisés par des praticiens expérimentés, représente souvent une aide précieuse pour l'évaluation de l'incapacité fonctionnelle, mais résout rarement les problèmes d'imputabilité.

L'exploration du niveau des acquis pré-traumatiques doit être systématiquement détaillée et documentée (livret scolaire, cursus professionnel, éléments d'aptitude, activités de loisir ...). Dans les cas difficiles, l'expert peut s'aider d'un avis spécialisé.

1-3-1/ Les fonctions supérieures :

La vigilance et l'orientation dans le temps et dans l'espace doivent être appréciées, de même que la mémoire d'évocation (et notamment la mémoire d'évocation différée) et de fixation, immédiate et de travail, l'attention tant spontanée que volontaire.

Pour apprécier la qualité du langage, il faut étudier la compréhension et l'expression, c'est-à-dire l'articulation, le ton (monotone, angoissé...), le débit (lent, hésitant, logorrhéique...), le comportement (cris, vociférations...), la forme et le contenu tant du point de vue du vocabulaire que sémantique. Les trois modes (oral, écrit et gestuel) doivent être explorés, de même que les modalités de calcul.

Le jugement est une notion complexe s'appliquant à la qualité de toute activité intellectuelle, appréciée sous l'angle de la raison. Il nécessite le concours de l'attention, de la réflexion, du sens critique, de la mémoire, du sens éthique et des possibilités intellectuelles.

L'abstraction est la capacité de passer aux symboles et d'établir des raisonnements crédibles et fiables à partir de la réalité.

1-3-2/ Les fonctions thymiques et instinctives :

L'humeur est la disposition affective fondamentale riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur.

Le sommeil s'apprécie par sa durée, mais aussi par l'heure du coucher, l'heure de l'endormissement, les réveils précoces, les rêves pathologiques, les cauchemars, les terreurs nocturnes ... et la sensation subjective de la qualité du repos.

Les troubles de conduites alimentaires oscillent de l'anorexie à la boulimie ... sans oublier la toxicomanie et l'alcoolisme.

Il faut rechercher les variations de la libido et de l'activité sexuelle, lorsque les troubles font partie intégrante de la pathologie neuropsychique, ils sont appréciés avec elle, alors que lorsqu'ils sont importants ou prépondérants, ils sont appréciés séparément, dans le cadre de l'analyse du dommage sexuel.

1-3-3/ Les fonctions relationnelles intra familiales :

Il faut apprécier l'autonomie dans la vie quotidienne et les capacités à agir pour soi et pour les autres de façon harmonieuse dans un souci de collaboration efficace :

- Toilette.
- Habillage.
- Changement des vêtements et de sous-vêtements.
- Choix des vêtements.
- Intérêt pour le travail scolaire des enfants.
- Liens affectifs avec les parents, frères et sœurs, etc.

1-3-4/ Les fonctions sociales :

La sociabilité est la capacité d'un individu à nouer des rapports positifs avec les autres. Elle implique les échanges, l'amitié, les activités de loisir et l'ébauche d'une vie collective. Son corollaire est l'adaptation, fonction de la stabilité :

- Activités de loisir.
- Centres d'intérêt.
- Pratiques sportives.

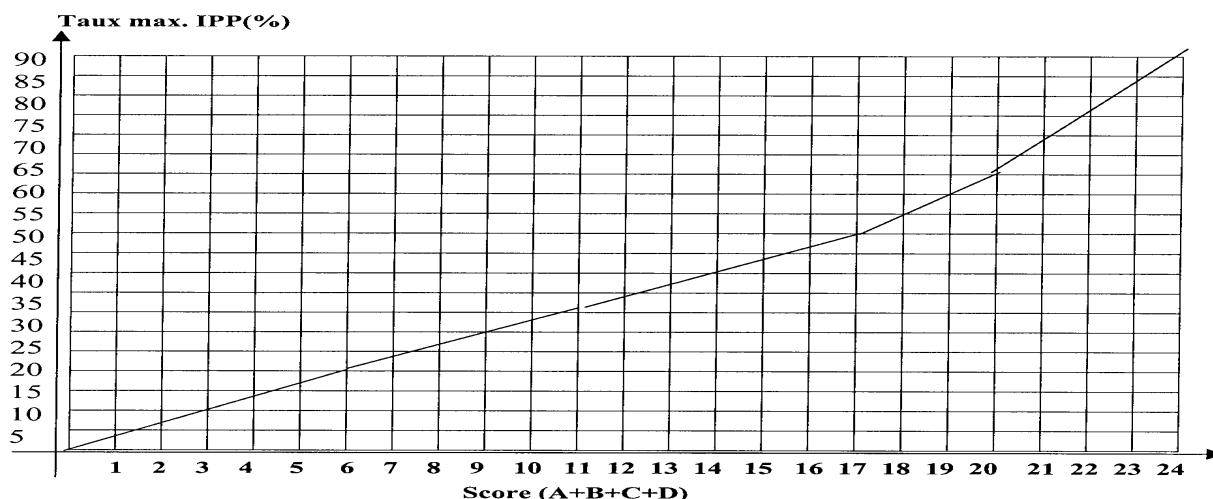
1-4/ Eléments d'orientation

Les compétences neuropsychiques peuvent se décomposer en deux grandes catégories (à chaque fonction est attribuée une note de 0 à 6).

1- LES CAPACITES PERSONNELLES
qui comprennent :
A- Les fonctions supérieures
B- Les fonctions thymiques et instinctives
2- LES COMPORTEMENTS RELATIONNELS
qui comprennent :
C- Les fonctions relationnelles intra-familiales
D- Les fonctions sociales

per

0- Absence de troubles
1- Déterioration très légère
2- Déterioration légère
3- Déterioration modérée
4- Déterioration moyenne
5- Déterioration grave
6- Déterioration totale ou quasi totale



1-5/ Tableaux cliniques

1-5-1/ Séquelles neurologiques majeures :

Séquelles des grands traumatismes crâniens avec coma prolongé pendant 15 jours ou plus, comportant des lésions de la base du cerveau et du tronc cérébral, éventuellement associées à un ou plusieurs foyers de contusion hémisphérique.

1-5-1-1/ Les comas chroniques :

Les états végétatifs chroniques, caractérisés par l'existence d'une autonomie végétative mais l'absence de toute vie de relation, l'existence de mouvements automatiques des yeux et de la face, l'alternance de cycles veille-sommeil, une hypertonie diffuse à l'examen neurologique avec parfois rétractions musculo-tendineuses conditionnant des attitudes vicieuses.

L'affirmation de la perte de toute vie relationnelle impose des examens cliniques particulièrement minutieux, afin de ne pas la confondre avec les états de vie réduite.

La chronicité ne peut être affirmée avant un délai d'un an

Le taux d'incapacité permanente partielle :99%

1-5-1-2/ Les états de vie réduite :

Ils comportent des possibilités relationnelles, à des degrés variables et des séquelles neurologiques intéressant les quatre membres.

- soit des états akinéto-hypertoniques majeurs avec faciès figé inexpressif, compréhension intermittente d'ordres simples, émission de quelques phonèmes sur un fond de mutisme habituel, hypertonie bilatérale avec souvent raideurs articulaires, état grabataire.....**non inférieur à 95%**

- soit un meilleur état de conscience, avec possibilités d'attention et d'expression verbale, mais hypertonie des quatre membres et rétraction, maintenant l'état grabataire permanent**90 à 95 %**

- soit un état de conscience normal mais avec bradypsychie plus ou moins importante, une grande fatigabilité intellectuelle, un déficit mnésique majeur, une efficacité mentale très réduite.

Les séquelles neurologiques associées aux quatre membres (mais souvent de façon inégalement répartie) une hypertonicité pyramidale, une ataxie cérébelleuse, un déficit plus ou moins marqué des sensibilités.

La station debout et la marche sont impossibles, le blessé est confiné dans un fauteuil roulant qu'il ne manœuvre pas lui-même ; il n'a aucune activité spontanée.....**85 à 90%**

1-5-2/ Déficiences sensitivomotrices d'origine médullaire et centrale :

Tétraplégies et paraplégies constituent toujours des entités cliniques complexes associant des atteintes de la fonction de locomotion, de la fonction urinaire, des fonctions génito-sexuelles, de la fonction respiratoire et des troubles rachidiens. Les taux proposés ci-dessous correspondent à une évaluation globale des conséquences de la lésion. Mais l'expert doit décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits composant ces entités cliniques d'autant plus qu'ils sont fonction du niveau lésionnel.

1-5-2-1/ D'origine médullaire

Tétraplégie haute complète.....	non inférieur à 95%
Tétraplégie basse complète (au dessous de C6).....	90 à 95%
Tétraparésie : marche possible, préhension possible, maladroite, selon le périmètre de marche et l'importance des troubles urinaires et génito-sexuels.....	45 à 75%
Paraplégie complète : selon le niveau de l'atteinte médullaire qui conditionne d'éventuelles difficultés à la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels.....	70 à 85%
Paraparésie : marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ; selon l'importance des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs associés.....	20 à 50%
Syndrome de Brown-Séquard ; selon l'importance des troubles moteurs, sensitifs et génito-sphinctériens.....	15 à 50%

1-5-2-2/ D'origine hémisphérique, cérébelleuse, ou secondaires à une atteinte du tronc cérébral :

-Quadriplégie complète.....	non inférieur à 95%
-Quadriplégie incomplète : l'évaluation du taux se fera par comparaison avec des déficits similaires et en fonction du degré d'autonomie.....	45 à 75%
-Hémiplégie majeure : station debout impossible, membre supérieur inutilisable, déficit cognitif important (dont aphasie).....	90%
-Hémiplégie spastique : marche possible avec cannes, membre supérieur inutilisable, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant :	
- dominant.....	70%
- non dominant.....	60%
-Hémiplégie spastique : marche possible sans cannes, membre supérieur utilisable avec maladresse, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant :	
- dominant.....	60%
- non dominant.....	50%
-Hémi-parésie spastique : avec main modérément maladroite sans déficit sensitif :	
- dominant.....	35%
- non dominant.....	25%
-Monoplégie brachiale : sans atteinte du membre inférieur, main inutilisable	
- dominant.....	50%
- non dominant.....	40%
-Monoplégie brachiale : sans atteinte du membre inférieur, main très maladroite :	
- dominant.....	40%
- non dominant.....	30%
-Monoplégie brachiale : sans atteinte du membre inférieur, main modérément maladroite :	
- dominant.....	30%
- non dominant.....	20%
-Monoparésie du membre inférieur : selon la gêne à la marche.....	20 à 30%

-Syndrome cérébelleux majeur : atteinte bilatérale, marche quasi impossible, préhension inefficace, importante dysarthrie.....	80 à 85%
-Syndrome cérébelleux incomplet : atteinte unilatérale, sans répercussion sur la locomotion, préhension maladroite du côté atteint, dysarthrie absente ou discrète, selon le côté dominant.....	15 à 30%
-Troubles du mouvement, du tonus, de l'attitude (tremblements, dyskinésies, dystonies), isolés ou au premier plan ; en fonction des perturbations fonctionnelles.....	10 à 30%
-Déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel (gêne à la marche par atteinte cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités) ; selon l'importance.....	10 à 30%

1-5-3/ Déficits sensitivomoteurs d'origine périphérique :

1-5-3-1/ la face : Se référer au chapitre du dommage facial.

1-5-3-2/ les membres supérieurs : Se référer au chapitre de la fonction de préhension

1-5-3-3/ les membres inférieurs : Se référer au chapitre de la fonction de Locomotion

1-5-3-4/ les douleurs de déafférentation :

Qu'elles soient ou qu'elles accompagnent un déficit sensitivo-moteur, elles devront être prises en compte

- | | |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe, • Soit par un taux d'incapacité spécifique | 5 à 10% |
|---|---------|

1-5-3-5/ Le syndrome de la queue de cheval

Suivant l'importance des troubles moteurs, sensitifs et génito-sphinctériens.....	15 à 50%
---	----------

1-5-4/ Déficits neurosensoriels :

Il convient de se reporter aux spécialités concernées, en particulier l'ophtalmologie et l'oto-rhino-laryngologie.

1-5-5/ Les troubles du langage et de la communication :

Les troubles aphasiques d'origine traumatique n'ont pas de systématisation relativement précise sauf s'ils résultent de lésions des gros vaisseaux à destinée cérébrale. Néanmoins, les troubles de la compréhension sont d'autant plus importants qu'il y a des lésions temporales et des troubles de l'expression orale qui prédominent nettement lorsqu'il existe des lésions frontales. Une aphasie peut être induite par des lésions du thalamus. Les troubles de la compréhension ont des conséquences beaucoup plus graves sur la vie de relation que les troubles de l'expression.

Les troubles évidents de la compréhension et de l'expression du langage oral et écrit ne peuvent être méconnus. Un trouble mineur du langage peut être sous-estimé (manque de mots, diminution de la fluence verbale, quelques paraphasies, quelques difficultés de compréhension des ordres complexes ou de situations abstraites), justifiant une étude orthophonique spécifique, tout comme certains troubles dissociés, du calcul par exemple.

Un délai de **dix huit à vingt quatre mois** est nécessaire pour l'évaluation définitive des séquelles. Les troubles d'origine purement motrice seront abordés au chapitre des fonctions sensorielles.

MANQUE DU MOT (DISCRET), AUCUNE DIFFICULTE DE COMPREHENSION
Absence de troubles du langage intérieur mais altération de la performance linguistique
Fonctions intellectuelles conservées.....5 à 15%

APHASIE DE TYPE ANTERIEUR (BROCA)

- manque de mot, réduction plus ou moins importante de l'expression, quelques paraphrasies ;difficultés arthriques, agrammatisme modéré, sans agraphie ni trouble notable de la compréhension.....15 à 35%

Avec en plus :

- agraphie, anarthrie, difficultés de compréhension.....jusqu'à 50%

APHASIE DE TYPE POSTERIEUR (WERNICKE)

- paraphrasies, ébauche de jargon, dysyntaxie ;troubles modérés de la compréhension,jargon conséquent.....40 à 50%

- troubles importants de la compréhension orale ou écrite ; alexie.....50 à 60%

APHASIE GLOBALE.....50 à 70%

1-5-6/ Les troubles frontaux :

Le syndrome frontal est une séquelle post-traumatique particulièrement fréquente en raison de la disposition anatomique des lobes frontaux qui expose cette partie de l'encéphale aux contusions directes et aux contrecoups. Un dysfonctionnement frontal peut également être observé lors de l'atteinte des voies se projetant sur les aires frontales, par exemple celles provenant des noyaux gris. Le tableau clinique associe généralement une réduction importante de l'activité motrice, une réduction de l'expression verbale spontanée, avec une perte de l'organisation du discours, la perte de la stratégie des activités séquentielles, l'indifférence ou l'euphorie naïve, avec souvent des éléments de désinhibition. Le dysfonctionnement frontal peut avoir deux présentations opposées, l'une marquée par la désinhibition des conduites motrices, sociales, sexuelles, sphinctériennes, l'autre dominée par un apragmatisme majeur. Tous les degrés entre ces deux formes caricaturales sont possibles, mais c'est le plus souvent la présentation apragmatique qui risque d'être minorée par l'absence même de demande du sujet. Il est nécessaire d'insister sur le rôle essentiel de l'interrogatoire de l'entourage pour suspecter un tel dysfonctionnement. Dans les formes modérées, le comportement du sujet, stimulé pendant la consultation, peut contraster avec la réalité de la vie quotidienne. En effet, si le sujet est parfois capable d'assumer les activités élémentaires de la vie quotidienne, il ne peut programmer, coordonner et organiser ces activités entre elles au cours de la journée. Des épreuves cliniques permettent d'attester des perturbations mises en évidence par l'interrogatoire dans différents domaines: la communication orale et écrite, les activités gestuelles, l'attention et la mémoire, les capacités d'initiative et d'apprentissage, la flexibilité mentale, le calcul et la résolution de problèmes arithmétiques, le jugement et l'autocritique. En pratique, l'expert doit disposer d'un bilan neuropsychologique complet.

FORME LEGERE A MODEREE

- troubles de la mémoire (discrets), difficultés d'apprentissage

- lenteur globale, diminution de l'initiative

- activités restant adaptées

- autonomie totale.....15 à 20%

FORME MOYENNE, mêmes symptômes que précédemment avec en plus

- labilité émotionnelle, dysthymie

- tendance à l'hyperactivité, logorrhée ou au contraire apragmatisme et langage pauvre

- diminution des capacités de programmation et de planification.....20 à 35%

FORME IMPORTANTE, avec en plus des signes précédents

- troubles du caractère et du comportement.....35 à 50%

FORME SEVERE, avec en plus des signes précédents

- altération des conduites instinctives

- apragmatisme

- troubles du jugement

- troubles de l'humeur.....50 à 70%

FORME TRES SEVERE, avec en plus des signes précédents

- troubles du contrôle sphinctérien

- troubles des conduites instinctives

- perte de l'autonomie.....70 à 90%

1-5-7/ Les troubles de la mémoire :

Les troubles de la mémoire constituent une doléance fréquente des blessés et de leur entourage. Il peut s'agir :

- D'une amnésie post traumatique, correspondant à la période de coma et/ou de confusion mentale.

- D'une amnésie rétrograde dont la durée est à préciser.

- D'une amnésie antérograde, représentant l'incapacité totale ou relative à acquérir de nouveaux souvenirs, c'est-à-dire l'impossibilité ou la difficulté d'apprendre.

- De troubles dissociés de la mémoire, plus ou moins importants, qui se manifestent par des difficultés d'apprentissage et de rappel, liés à un défaut d'attention et de concentration ; dans ces situations, la mémoire reste intacte ; ces troubles attentionnels peuvent être observés au cours des lésions frontales, mais aussi au cours des états anxieux et dépressifs.

TRES DISCRET DEF AUT M NESIQUE

- petite lenteur de compréhension

- pas de troubles du jugement

- pas de perte du sens symbolique.....2 à 5%

FORME LEGERE :

- difficultés en mémoire immédiate

- lenteur dans l'apprentissage

- pas d'amnésie rétrograde, orientation temporospatiale parfaite.....10 à 15%

FORME MODEREE :

- amnésie antérograde partielle

- apprentissage déficient

- difficultés à évoquer certains souvenirs anciens

- ralentissement au quotidien et sur les capacités à étudier.....15 à 30%

FORME SEVERE : type amnésie korsakovienne ou hippocampique

- amnésie antérograde marquée parfois massive (quasi oubli à mesure)

- mémoire à court terme plus ou moins altérée

- amnésie rétrograde souvent étendue

- désorientation temporospatiale

- parfois fabulations, fausses reconnaissances.....30 à 60%

1-5-8/ Syndrome visuo-constructif de l'hémisphère mineur :

Le syndrome de l'hémisphère mineur s'observe après lésion du cortex pariétal ou frontal, parfois lors des lésions sous corticales (notamment thalamiques) intéressant l'hémisphère droit (ou plus précisément l'hémisphère non dominant).

Ce syndrome associe d'une façon plus ou moins marquée :

- une négligence spatiale unilatérale, qui perturbe le comportement d'un patient dont l'activité n'est pas compromise par une hémiparésie ou un déficit sensitif gauche (trois aspects : visuelle, motrice, de représentation) ;

- une apraxie constructive, c'est-à-dire l'incapacité à manipuler les objets dans l'espace et à rendre compte de l'espace dans les activités graphiques ;

- des troubles de la lenteur de l'écriture, du calcul, de type spatial ;

- des troubles de la mémoire topographique (mémoire des lieux, des trajets) et de l'orientation spatiale ;

- des troubles du schéma corporel ;

- des troubles de la reconnaissance des visages familiers (prosopagnosie) ;

- une anosognosie.

L'anosognosie : il s'agit d'une attitude du sujet qui est dans l'incapacité d'admettre l'existence de troubles et fait preuve d'une indifférence relative ou de conduites inadaptées compte tenu des troubles qui le frappent.

FORME LEGERE

- hémiparésie gauche limitée spécifiquement dans les doubles tâches

- troubles constructifs limités

- absence ou présence de troubles discrets du schéma corporel

- et/ou de la mémoire topographique.....15 à 30%

FORME MODEREE

- négligence visuelle (isolée)

- troubles visuo-constructifs.....30 à 45%

FORME MAJEURE : Retardement fonctionnel important, compte tenu de l'anosognosie et des difficultés à mettre en place des stratégies.....45 à 60%

1-5-9/ Agnosie visuelle

L'agnosie visuelle désigne l'impossibilité d'identifier, par la vue, les objets, les images ou les couleurs, alors que la perception est suffisante et qu'il n'y a pas d'affaiblissement démentiel. La cécité corticale en représente la forme majeure.

AGNOSIE VISUELLE DES OBJETS OU DES IMAGES

*Forme modérée incomplète.....20 à 40%

*Forme majeure.....50 à 70%

ALEXIE AGNOSIQUE (Alexie pure sans agraphie).....20 à 40%

1-5-10/ Syndrome démentiel

Le terme de démence conserve, par sa définition, un certain nombre d'ambiguïtés, faisant trop référence implicitement à un mécanisme (le processus qui va déterminer un dysfonctionnement cérébral d'aggravation progressive), et par conséquent à une maladie causale (en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, étiologie la plus fréquente des atteintes démentielles).

Il faut lui préférer le concept de « syndrome démentiel », cadre séméiologique permettant d'accepter l'ensemble des étiologies.

Le syndrome démentiel est caractérisé par la perturbation de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension du calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement.

Un syndrome démentiel entraîne une altération manifeste du fonctionnement intellectuel et interfère habituellement avec les activités de la vie de tous les jours. Les manifestations de cette altération varient considérablement selon le contexte social ou culturel du sujet, son âge, et le délai écoulé depuis son apparition.

Les démences post traumatiques isolées sont exceptionnelles. Elles ne doivent pas être confondues avec certaines névroses graves, avec inhibition et apragmatisme. Ces états démentiels s'observent plutôt en association avec des séquelles neurologiques diffuses, dans le cadre des séquelles neurologiques majeures des grands traumatismes crâniens.

L'évaluation et la discussion du lien de causalité avec l'accident sont difficiles, nécessitant l'aide d'un spécialiste en neurologie et/ou en psychiatrie.

On n'admettra le caractère post traumatique de la démence, que lorsqu'il existe une concordance anatomo-clinique claire, entre le siège du traumatisme, son importance et la symptomatologie. Une bonne connaissance de l'état antérieur clinique et, le cas échéant paraclinique, est un élément essentiel à la discussion médico-légale. Il faut déceler par une enquête méthodique, toutes les altérations des fonctions supérieures, conduisant à une perte plus ou moins complète d'autonomie, au sein du milieu socioprofessionnel et familial.

Il est habituellement rencontré en cas de lésions cérébrales multiples et bilatérales, consécutives à un traumatisme crânien grave.

Les taux peuvent atteindre jusqu'à 90%

1-5-11/ Affections névrotiques

1-5-11-1/ Le syndrome subjectif ou post commotionnel des traumatisés crâniens :

Fréquent mais de gravité très inégale ; il ne survient qu'après les traumatismes crâniens ayant comporté une perte de connaissance ou, au moins, une altération de la conscience, de plus ou moins longue durée (quelques minutes à quelques heures). Il n'y a pas de proportionnalité entre l'importance de la commotion cérébrale initiale et celle du syndrome post commotionnel. La symptomatologie est exclusivement subjective. Elle peut comprendre :

- Des céphalées inconstantes.
- Des sensations vertigineuses sans caractère giratoire, lors des changements de position.
- Une fatigabilité intellectuelle avec troubles de l'attention et de la concentration.
- Des troubles de la mémoire des faits récents.
- Des troubles du caractère avec irritabilité.
- Des troubles du sommeil.
- Une fatigabilité visuelle.
- Une intolérance aux bruits.

Les caractères séméiologiques de ces symptômes fonctionnels et leurs modalités évolutives doivent être précisés par un interrogatoire minutieux, qui complète et affine leur description spontanée, et qui seul permet de les authentifier et donc d'affirmer le diagnostic.

Les examens paracliniques (EEG, scanner, examens ophtalmologiques et vestibulaires) sont, en règle, normaux ; ils ne sont donc, le plus souvent, d'aucune utilité pour le diagnostic.

Si l'existence réelle et l'imputabilité du syndrome sont admises, le taux d'incapacité est évalué selon le nombre, l'importance, la périodicité des troubles et l'influence du traitement de :.....2 à 8%

1-5-11-2/ La névrose traumatique (Etat de stress post traumatique, névrose d'effroi)

Elle succède à des manifestations psychiques provoquées par l'effraction soudaine, imprévisible et subite, d'un événement traumatisant, débordant les capacités de défense de l'individu.

Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.

L'événement doit avoir été mémorisé.

La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d'évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Traitée précocement, la névrose traumatique guérit avec retour à l'état antérieur, sans laisser de séquelles constitutives d'une incapacité permanente. L'appréciation d'une névrose traumatique ne peut être envisagée qu'après environ deux ans d'évolution.

-Labilité émotionnelle

-Emotivité

-Réactions inadaptées à certains stimuli.....5 à 10%

-Persistance de cauchemars avec réminiscences, et vécu diurne de moments où l'événement traumatique s'impose au sujet, en dehors de toute évocation par un tiers, le sujet ne parvenant pas à chasser de son esprit l'événement traumatique (à différencier du simple mauvais souvenir)10 à 20%

-Syndrome de répétition (réactions de sursaut, cauchemars, envahissement diurne des pensées etc....), modification de la personnalité (état permanent d'alerte, syndrome d'évitement, perte des intérêts, régression narcissique, repli sur soi et irritabilité). Symptômes névrotiques non spécifiques (asthénie, anxiété généralisée, troubles psychosomatiques, perturbation du comportement type crise de nerfs, tentative de suicide, accès de boulimie ou d'anorexie etc....), troubles neurovégétatifs.....20 à 25%

1-5-11-3/ La dépression chronique résistante

Il est nécessaire de faire un diagnostic positif, les simples allégations étant insuffisantes. Il faut vérifier qu'un traitement à doses efficaces a été prescrit pendant suffisamment longtemps. Il faut dissocier la constatation des symptômes (et l'analyse de leur intensité) des conséquences sur la vie quotidienne, qui doivent guider l'évaluation du taux d'incapacité fonctionnelle.

Les symptômes les plus fréquents sont: baisse de l'élan vital; repli sur soi, désintérêt, perte des initiatives, irritabilité, troubles du sommeil, ralentissement idéique et moteur, tristesse foncière, incapacité à se projeter dans l'avenir, troubles de l'alimentation, sentiment de dévalorisation ou d'hostilité ambiante...

- Chute isolée de l'élan vital.....5 à 10%

- Chute de l'élan vital, avec troubles du sommeil, et lenteur idéomotrice.....10 à 20%

- Troubles dépressifs importants, ralentissement idéomoteur important.....20 à 30%

1-5-11-4/ Autres états névrotiques :

Les affections névrotiques très structurées et très invalidantes, comme la névrose obsessionnelle sévère, ne sont jamais d'origine traumatique.

1-5-12/ Affections psychotiques :

Elles ne sont jamais d'origine traumatique.

1-5-13/ Les épilepsies

Tous les types d'épilepsie peuvent avoir un caractère post traumatique à l'exception du petit mal épileptique, l'épilepsie myoclonique et les crises généralisées au réveil.

Le délai minimal de survenue d'une épilepsie post traumatique est de sept jours après le traumatisme (toute crise survenant avant ce délai est considérée comme faisant partie de la maladie traumatique). La majorité des épilepsies post traumatiques se révèlent dans les trois ans qui suivent l'accident.

L'épilepsie peut être stabilisée sous traitement médical, mais son aggravation reste toujours possible (augmentation de la fréquence des crises, modification de la symptomatologie, survenue d'un état de mal).

- Le diagnostic médico-légal des épilepsies post traumatiques est souvent difficile ; car :
 - Il faut authentifier l'épilepsie : crises épileptiques répétées. Il faut éliminer les syncopes, crises nevropathiques, convulsions d'autres origines. Une seule crise ne suffit pas, surtout si la symptomatologie est douteuse ou non concordante avec une lésion cérébrale éventuelle. Une seule crise suffit, si l'épilepsie est focalisée sur une lésion post traumatique reconnue.
 - Il faut préciser le caractère des crises ::
 - Crises partielles : simples, complexes
 - Crises généralisées.
 - Il faut apprécier les données électro-encéphalographiques ; tout en sachant qu'un EEG normal n'élimine pas le diagnostic.
- Etablir la relation de causalité entre cette épilepsie et le traumatisme :
 - Facteurs anamnestiques : absence d'antécédents épileptiques de tout type
 - Facteurs liés au traumatisme causal :
 - Plaie crânio-cérébrale ouverte : plaie pénétrante avec effraction de la dure-mère, fracture ou embarrure.
 - Lésion cérébrale (contusion hémorragique) ou péricérébrale (hématomes intracrâniens)
 - Association de deux signes des signes suivants (ROGER) :
 - ✓ Amnésie post traumatique de plus de 24 heures.
 - ✓ Crises comitiales précoces.
 - ✓ Fracture du crâne avec embarrure.
 - ✓ Une infection Cérébro-méningée dans les suites du traumatisme.
- La consolidation ne peut être envisagée qu'après une mise en route d'un traitement valable (types de médicaments, doses, durée).

Le taux d'incapacité permanente est fonction du type des crises, de leur fréquence et leur horaire, de l'efficacité du traitement et de ses effets secondaires éventuels.

Epilepsie bien maîtrisée par un traitement continu, en fonction des effets secondaires.....	8 à 15%
Epilepsie assez bien maîtrisée, avec cependant crises épisodiques, malgré un traitement, en fonction de la fréquence des crises et des effets secondaires du traitement.....	15 à 25%
Epilepsie mal contrôlée, avec crises fréquentes (une par semaine ou plus), malgré un traitement médicamenteux important avec effets secondaires gênants.....	25 à 40%
Crises fréquentes interdisant une activité régulière.....	40 à 50%

1-5-14/ L'hydrocéphalie à pression normale

L'hydrocéphalie à pression normale peut compliquer un saignement méningé traumatique ou une intervention intracrânienne, réalisant une dilatation chronique des cavités ventriculaires encéphaliques, par trouble de la circulation/résorption du liquide céphalorachidien.

Elle détermine une triade symptomatique assez caractéristique, associant en proportion variable, des troubles de la marche et de l'adaptation posturale, des troubles sphinctériens (essentiellement de type mictionnel) et un syndrome démentiel.

Les troubles neuropsychologiques sont assez proches du cadre séméiologique d'un syndrome frontal réduit, avec indifférence, apragmatisme, labilité attentionnelle, troubles mnésiques antérogrades, difficultés de programmation et d'exécution.

L'existence d'une atteinte intellectuelle globale ou d'un déficit avéré des fonctions cognitives instrumentales (aphasie, apraxie, agnosie), doit faire remettre en cause le diagnostic.

La mise en place précoce d'une dérivation de liquide céphalorachidien peut faire disparaître les troubles, mais la réversibilité du déficit intellectuel peut être incomplète, justifiant une évaluation au titre de l'incapacité fonctionnelle, qui doit être appréciée par référence à cette perte fonctionnelle.

Le taux d'incapacité doit être apprécié en fonction du déficit neurologique. La mise en place d'une dérivation n'occasionne, par elle-même, aucune incapacité, mais les contraintes de surveillance peuvent justifier un taux de.....5 à 10%

1-5-15/ Les syndromes parkinsoniens post traumatiques :

Il est exceptionnel de pouvoir établir une relation de causalité entre un traumatisme crânien et un syndrome parkinsonien constaté après l'accident (hémorragie dans la région des noyaux gris centraux visible au scanner, unilatéralité du syndrome extrapyramidal, association habituelle à d'autres signes neurologiques).

Le taux d'incapacité varie en fonction de l'importance des signes extrapyramidaux et du retentissement sur la fonction motrice.....20 à 50%

1-5-16/ Séquelles osseuses crâniennes et tégumentaires du cuir chevelu:

1-5-16-1/ Séquelles osseuses :

-Embarrures crâniennes persistantes selon le degré d'enfoncement.....2 à 5%
 -Perte de substance osseuse étendue (avec battement dure-mérien et impulsion à la toux).....2 à 10%
 -Perte de substance osseuse réparée par plastie mal tolérée.....2 à 5%
 -Volet cicatrisé en mauvaise position.....2 à 5%

1-5-16-2/ Séquelles tégumentaires du cuir chevelu :

-Scalp ou brûlure du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses.....2 à 5%

2/Fonction Motrice

2-1/ Fonction de préhension

2-1-1/ Définition

La préhension (du latin prehendere) est l'action d'atteindre et de saisir tout objet afin de le reconnaître, le déplacer, l'orienter et/ou l'utiliser.

Cette fonction est essentiellement assurée par la main, mais nécessite, pour être efficiente, non seulement l'intégrité anatomique et fonctionnelle de la main, mais encore celle de l'ensemble du membre supérieur. Membre qui joue un rôle primordial dans la vie de relation, aussi bien au niveau de la quête de l'information qu'à celui de l'action. Son atteinte est lourde de conséquences fonctionnelles

2-1-2/ Critères d'appréciation

Les critères d'appréciation de l'incapacité fonctionnelle résultent d'une analyse séméologique précise, qui comporte la mesure des amplitudes articulaires, et celle des périmètres des membres. Ces éléments ne sont cependant que des éléments analytiques, à la recherche d'une évaluation plus globale de l'incapacité fonctionnelle, et la diminution du périmètre d'un membre, où la limitation des angles d'amplitude ne constituent pas, en soi, une incapacité fonctionnelle. Les manœuvres d'appréciation globale de l'incapacité fonctionnelle vont tenter de mettre le patient en situation de réaliser des gestes précis : porter sa main à différents endroits (vertex, nuque, lombes...) et le confronter à des situations de préhension de différents objets, testant les différentes prises, mais aussi les limitations de préhension liées aux limitations des différentes articulations. L'analyse des possibilités d'écriture est importante. L'estimation de la valeur fonctionnelle perdue et des capacités restantes n'est possible qu'à condition de procéder à l'examen clinique exhaustif du patient.

- On peut proposer les séquences suivantes :

2-1-2-1/ Recueil des doléances spontanées

- Douleur, raideur, manque de force, maladresse, etc. concernant l'exécution des mouvements.
- Gêne, difficultés ou impossibilité d'exécuter les actes de la vie courante (un acte nécessitant une succession et un enchaînement des gestes).

2-1-2-2/ Examen analytique des membres supérieurs

Cet examen a pour but de constater les signes pathologiques objectifs expliquant les altérations de la fonction. Il se composera :

- du bilan articulaire : mesure des amplitudes de tous les mouvements de toutes les articulations du membre supérieur ;
- du bilan musculaire, selon les normes du testing international pour mesurer la force d'exécution des mouvements ;
- du bilan trophique : prise des mensurations périmétriques ;
- de l'étude de la précision des gestes, dont les défauts ne pourront être rapportés à leur cause qu'au prix d'un examen neurologique complet (étude des différentes sensibilités – du tonus – de la réflexivité – de la coordination..., etc.).

2-1-2-3/ Examen fonctionnel global de la main

Il s'agit de l'étude des différentes sortes de prises et contre-prises.

Les possibilités de prises ne peuvent s'illustrer que dans la demande d'exécution d'actes de la vie courante.

LES PRISES :

- La prise digito-palmaire ou prise en crochet : seule prise ne faisant pas intervenir le pouce.

Prises de force

- La prise digito-thénarienne : prise et serrage d'une pince ou d'un sécateur grâce aux 4 doigts longs contre le 1^{er} métacarpien.
- La prise globale plate permet de serrer un livre.
- La prise cylindrique : le grip de l'outil : permet le serrage par les 4 derniers doigts et le verrouillage par le pouce fléchi.
- La prise sphérique : pouce en extension et abduction avec verrouillage par l'auriculaire d'une bouteille, d'une sphère de 8cm de diamètre.

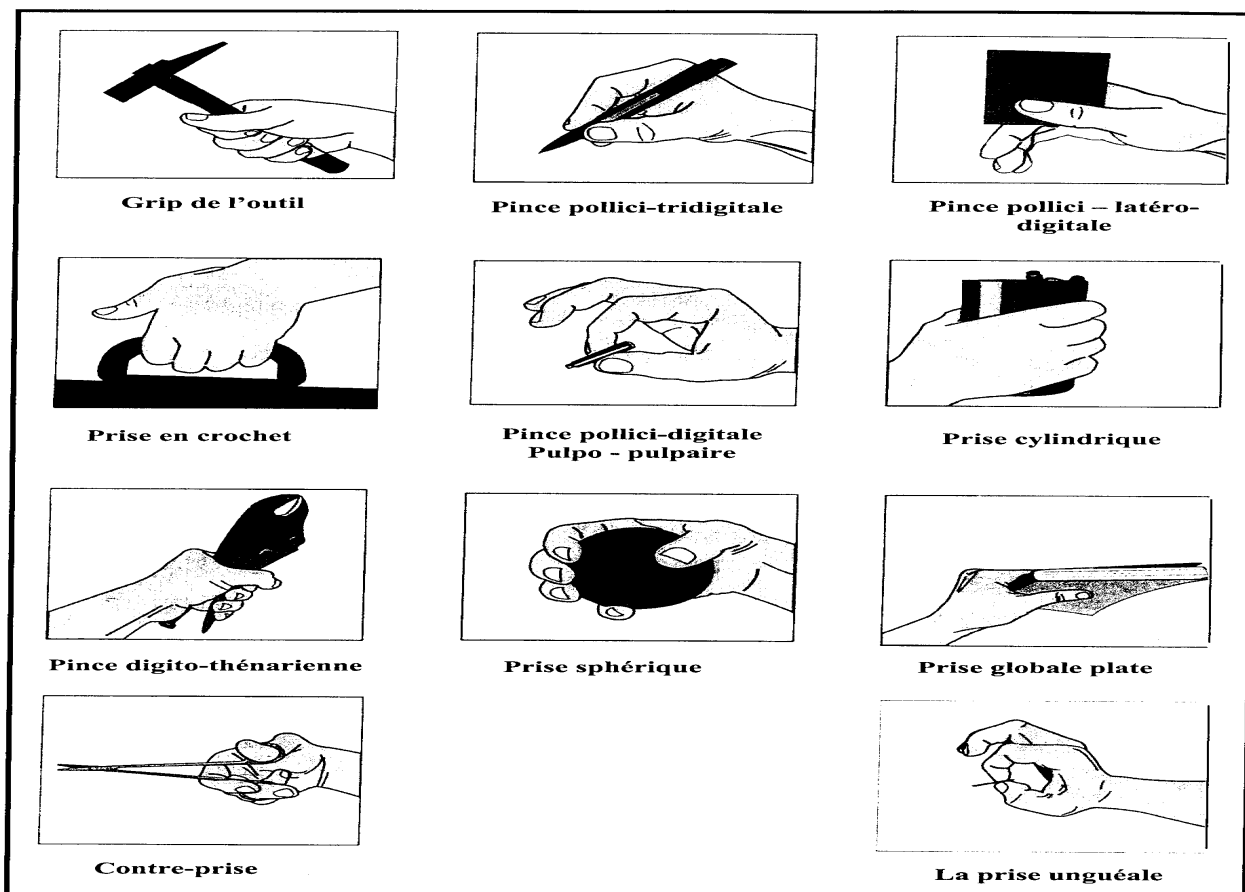
Pincettes de précision

- La pince pollici-tridigitale ou tripode entre la pulpe du pouce et celle de l'index et du médus (stylo, crayon) permettant une meilleure exploration de l'objet et une fixation plus précise.
- La pince pollici-latéro digitale
- La pince pollici-digitale pulpo-pulpaire : prise pulpaire : prise d'une feuille de papier, d'un stylo, entre la pulpe du pouce et celle de l'index ou éventuellement du médus.
- La prise unguéale : prise d'une épingle ou d'une trombone avec l'extrémité de la pulpe et l'ongle de chacun des 2doigts concernés (pouce – index ou pouce médus)

LES CONTRE-PRISES :

- Les mouvements d'extension des doigts préparent le geste de serrage : la pression d'un doigt en extension ou l'ouverture d'une paire de ciseau entre pouce et médus.

Pincettes Et Prises Fondamentales



2-1-2-4/ Bilan fonctionnel global du membre supérieur

Il n'est possible qu'en demandant au sujet d'effectuer ou de tenter d'effectuer l'ensemble des actes de la vie courante concernant :

- L'habillage, le déshabillage, l'ajustement des vêtements (boutons, cravate).
- Le chaussage (nouer les lacets).
- Les actes de la toilette : utiliser les installations de toilette (ouvrir et fermer les robinets) et les objets de toilette (gants de toilette –peigne- brosse à dents- rasoir...)
- L'alimentation : saisir une bouteille, la déboucher et se servir, couper les aliments, peler un fruit.
- L'utilisation des couverts.
- La communication : utilisation du téléphone, écriture.
- Le franchissement des obstacles domestiques : ouvrir et fermer les portes.
- S'enquérir sur les possibilités de conduite automobile.

2-1-2-5/ Aides techniques. Appareillage.

Certaines atteintes peuvent faire envisager la prescription d'aides techniques ou d'appareillages, dont il convient d'apprécier objectivement le bénéfice (souvent modeste) qu'ils sont susceptibles d'apporter :

- Orthèses et attelles.
- Bracelets métacarpiens et leurs outils.
- Prothèses : esthétique, crochet, myoélectrique.

Ainsi, au terme de cet examen complexe, l'expert sera en mesure :

- D'apprécier la réalité et la nature des déficiences.
- De les rapporter à leurs causes.
- D'en apprécier l'importance.

La main est un remarquable outil de préhension, mais également un organe d'expression et présente de ce fait une grande valeur symbolique.

2-2-2-6/ Les signes d'accompagnement

- Osseux : cals exubérants, saillants...déformations, points douloureux localisés, pseudarthroses : selon le retentissement fonctionnel.
- Musculaires : amyotrophie mesurée à chaque segment du membre, comparativement avec le côté opposé (en tenant compte de la différence physiologique entre le côté dominant et l'autre côté), rétraction musculaire.
- Cutanés : cicatrices rétractiles, fixées aux plans sous-jacents, limitant parfois l'amplitude des mouvements ; foyer d'infection chronique avec fistule ; fragilité cutanée...
- Vasculaires : troubles vasomoteurs, refroidissement, cyanose.
- Algodystrophies : caractérisées par des signes cliniques (douleur, œdème, troubles trophiques musculaires et cutanés) radiologiques (ostéoporose mouchetée, loin de l'interligne articulaire) et scintigraphiques (hyperfixation) ; elles ont une évolution en principe lentement régressive en 1an à 18mois, cela doit conduire à retarder la fixation de la date de consolidation.

2-1-3/ Eléments d'orientation

Jusqu'à 10 % Diminution légère de la force, ou de la précision, ou de l'amplitude d'un ou plusieurs mouvements, entraînant une gêne dans la réalisation du geste sans l'empêcher.

Préhension normale, parfois douloureuse ou gêne très légère lors de certaines situations.....	0 à 3%
Préhension parfois douloureuse, s'accompagnant d'une légère limitation des gestes fins ou d'une légère diminution de la force ou du champ gestuel extrême.....	3 à 6%
Préhension un peu limitée dans certains gestes qui demeurent possibles à exécuter mais avec une gêne en fin d'amplitude et douleurs.....	6 à 9%

10 à 30 % Diminution moyenne de la force, ou de la précision, ou du champ, empêchant l'exécution naturelle de certains actes qui restent néanmoins possibles au prix d'une modification et adaptation gestuelle.

Diminution modérée de la capacité de préhension ou gêne douloureuse, empêchant l'exécution de quelques gestes particuliers.....	10 à 15%
Diminution de la préhension associant gêne, douleur et limitations des gestes usuels.....	15 à 25 %
Diminution assez importante de la capacité de préhension avec douleur et/ou limitation notable de la force et/ou de la précision et/ou du champ, nécessitant des adaptations gestuelles.....	25 à 30 %

30 à 50 % Diminution importante de la force, ou de la précision, ou du champ des gestes quotidiens, pouvant nécessiter pour leur réalisation l'adjonction d'aides techniques.

Diminution importante de la capacité de préhension d'un membre ou assez importante des deux membres.....	30 à 40 %
Diminution très importante de la capacité de préhension d'un membre ou importante des deux membres supérieurs.....	40 à 50 %

50 à 65 % Perte totale de la fonction d'un membre supérieur ou atteinte bilatérale importante, restreignant les gestes de la vie quotidienne, selon aides techniques.

65 à 85 % Perte quasi totale de la fonction des membres supérieurs, s'accompagnant de douleurs ou d'attitudes vicieuses.

Perte quasi-totale de la capacité de préhension par atteinte bilatérale importante des membres supérieurs.....	65 à 80%
Perte totale de la fonction des membres supérieurs, s'accompagnant de douleurs et/ou d'attitudes vicieuses.....	80 à 85%

2-1-4/ Tableaux cliniques

2-1-4-1/ Amputations

L'incapacité permanente doit être évaluée six mois à un an après d'éventuelles interventions palliatives ou la mise en place d'une prothèse et plus tardivement encore en cas de réimplantation ou de transfert.

L'appréciation de l'incapacité se fonde sur :

- *Le niveau d'amputation* : bien que la main ait un rôle prépondérant dans la fonction de préhension, le niveau d'amputation peut faire varier l'incapacité, en raison des possibilités d'utilisation du moignon.
- *L'état du moignon d'amputation* : même si les conséquences sur les possibilités d'éventuel appareillage sont moins déterminantes qu'au membre inférieur, la présence d'une cicatrice vicieuse, ou d'un névrome douloureux, peut conduire à augmenter le retentissement fonctionnel.
- *La suppléance fonctionnelle prothétique* : la suppléance prothétique au niveau de la main est possible, par l'intermédiaire d'une préhension grossière, pollici-pluri-digitale, qui n'est cependant envisageable que pour des amputations très distales du membre supérieur, et

souvent très incomplète. Le plus souvent, après quelques années, les prothèses les plus utilisées chez les amputés unilatéraux sont, soit le bracelet porte-outils, soit surtout les prothèses de suppléance esthétique, sans valeur fonctionnelle réelle autre que d'appoint. Les prothèses myoélectriques permettent un gain fonctionnel appréciable dans certains gestes, mais elles ont des limites, tant pour les préhensions fines que pour la préhension forte. Sur le plan pratique, elles sont utilisées, et de façon très imparfaite, par des blessés présentant des atteintes bilatérales des membres supérieurs. Dans la pratique, la suppléance prothétique ne peut amener à minorer de plus de 1/5 le taux d'incapacité fonctionnelle correspondant à l'amputation. Les réimplantations et les transferts doivent être évalués en fonction du résultat fonctionnel obtenu, très variable, notamment en fonction du niveau de l'atteinte. Les réimplantations hautes ne permettent qu'exceptionnellement des récupérations fonctionnelles réelles.

2-1-4-1-1/ Epaule

	Dominant	Non-dominant
Désarticulation inter scapulo-thoracique (gêne fonctionnelle majeure liée à la perte du membre supérieur et aux répercussions thoraco-respiratoires et vertébrales)	65 à 70 %	55 à 60 %

2-1-4-1-2/ Bras

	Dominant	Non-dominant
Selon le siège de l'amputation et de la mobilité résiduelle de l'épaule	60 à 65 %	50 à 55 %

2-1-4-1-3/ Avant-bras

	Dominant	Non-dominant
Selon la qualité du coude et le siège de l'amputation	45 à 55 %	35 à 45 %

2-1-4-1-4/ Main

	Dominant	Non-dominant
Selon la qualité du moignon et du coude et la suppléance prothétique	40 à 50%	30 à 40%

2-1-4-1-5/ Doigts

	Dominant	Non-dominant
Perte totale de la fonction d'un doigt par amputation ou ankylose		
Le pouce :		
Les 2phalanges et le 1 ^{er} métacarpien	22 à 25%	18 à 20 %
Les 2 phalanges	15%	12%
L'index	8 %	6%
Le médius	8 %	6 %
L'annulaire	6 %	4 %
L'auriculaire	8 %	6 %
Perte de la fonction de plusieurs doigts :		
Le pouce et l'index	30 %	25 %
Le pouce et le médius	32 %	26 %
Le pouce, l'index et le médius	35 %	28 %
L'annulaire et l'auriculaire	15 %	12 %
Les 4 derniers doigts excepté le pouce :		
Amputation transmétacarpienne	20 %	15 %
Conservation métacarpienne	15 %	12 %
Perte de la fonction d'un segment de doigt :		
Phalangette (P2) du pouce	8 %	6 %
Phalangette (P3) de l'index ou de l'annulaire	3 %	2 %
Phalangette (P3) du médius ou de l'auriculaire	4 %	3 %
P2 et P3 de l'index ou de l'annulaire	4 %	3 %
P2 et P3 du médius ou de l'auriculaire	6 %	4 %
Réimplantations digitales : les bons résultats correspondent à une perte de 10 à 20% de la valeur fonctionnelle du doigt, compte tenu de la persistance constante de douleurs et d'hypersensibilité au froid. Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits de sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut être supérieur à celui de la perte digitale.		

2-1-4-2/ Ankyloses Articulaires

2-1-4-2-1/ Epaule

	Dominant	Non-dominant
Ankylose de l'épaule, sans mobilité de l'omoplate, bras collé au corps	30%	25%
Ankylose de l'épaule avec mobilité de l'omoplate (abduction ne dépassant pas 60°)	20 à 25 %	15 à 20 %

2-1-4-2-2/ Coude

	Dominant	Non-dominant
Ankylose ou raideur serrée avec mobilité de 10 à 15° autour de 90° (amplitude minimale de fonction)		
Prono-supination conservée	20 à 25 %	15 à 20 %
Perte de la prono-supination	30 %	25 %

2-1-4-2-3/ Poignet

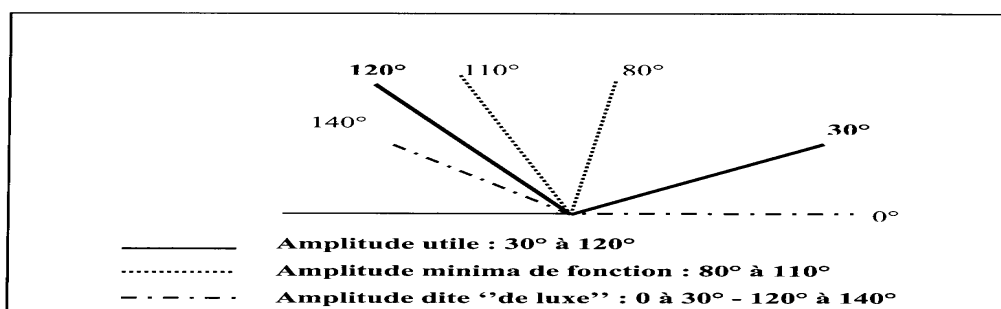
	Dominant	Non-dominant
Ankylose du poignet en position de fonction (extension à 15°, pas d'inclinaison latérale)		
Sans blocage de la prono-supination	10 %	8 %
Avec blocage de la prono-supination	18 à 20 %	15 à 18 %

2-1-4-3/ Raideurs articulaires

2-1-4-3-1/ Raideur de l'épaule

	Dominant	Non-dominant
Antépulsion et abduction limitées à 85°	15 à 20 %	10 à 15 %
Antépulsion et abduction entre 130° et 180°	5 à 10 %	3 à 8 %
Déficit isolé de la rotation externe (gêne pour peindre, écrire au tableau)	3 à 5 %	1 à 3 %
Déficit de la rotation interne (gêne pour porter la main en arrière pour la toilette du siège)	6 à 8 %	4 à 6 %

2-1-4-3-2/ Raideur du coude



Le secteur de mobilité utile de l'articulation du coude en flexion extension est de 30 à 120°. La pronation et la supination se mesurent de part et d'autre de la position intermédiaire, le bras le long du corps, le coude étant fléchi à 90° et le pouce au zénith (le bord cubital de la main regardant le sol). Dans ces conditions la pronation atteint l'amplitude de 85° et la supination 90°.

	Dominant	Non-dominant
Déficit isolé de la flexion/extension		
Dans le secteur utile (30°-120°)	Jusqu'à 10%	Jusqu'à 8 %
Dans le secteur dit « de luxe » (hors secteur utile)	Jusqu'à 3 %	Jusqu'à 2 %
Déficit isolé de la prono-supination (le secteur utile est le plus souvent déplacé dans le sens de la pronation)		
Pronation < 40°, supination < 30°, bonne compensation de l'épaule	6 à 12 %	6 à 10 %
Pronation de 40° à 60°		
Supination de 30° à 50° suivant les rotations de l'épaule	5 à 8 %	3 à 6 %
Pronation de 60° à 85°		
Supination de 50° à 90°	Jusqu'à 5 %	Jusqu'à 3%

L'évaluation des raideurs combinées du coude ne se fera pas par une addition des chiffres proposés mais par leur combinaison raisonnée.

2-1-4-3-3/ Raideur du poignet

	Dominant	Non-dominant
Diminution isolée de la flexion	Jusqu'à 6 %	Jusqu'à 5%
Diminution isolée de l'extension	Jusqu'à 7 %	Jusqu'à 6 %
Raideur combinée avec atteinte de la flexion, de l'extension et des inflexions radiale et cubitale (en notant que la main bote radiale, plus fréquente que la main bote cubitale, est moins gênante fonctionnellement)	7 à 10 %	6 à 8 %
Raideur combinée avec atteinte de la prono-supination	10 à 15 %	8 à 12 %

2-1-4-3-4/ Raideur des doigts

	Dominant	Non-dominant
Raideurs articulaires des 4 derniers doigts		
Métacarpophalangienne secteur de mobilité optimum : 20 à 80° pour II et III, 30 à 90° pour IV et V, taux en fonction de la mobilité restante	Jusqu'à 4 %	Jusqu'à 3 %
Articulations P1/P2, secteur de mobilité optimum : 20° à 80° pour II et III, 30° à 90° pour IV et V (gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts)	Jusqu'à 3 %	Jusqu'à 2 %
Articulations P2/P3	Jusqu'à 2 %	Jusqu'à 2 %
Raideurs articulaires du pouce :		
Articulation trapézo-métacarpienne	Jusqu'à 8 %	Jusqu'à 6 %
Articulation métacarpophalangienne	Jusqu'à 6 %	Jusqu'à 4 %
Articulation interphalangienne	Jusqu'à 2%	Jusqu'à 2 %
Raideur moyenne des articulations de la main	Jusqu'à 25 %	Jusqu'à 15%

Les lésions tendineuses des doigts sont détectées par les mouvements actifs et peuvent être assimilées à des raideurs.

2-1-4-4/ Instabilités

2-1-4-4-1/ Epaule

	Dominant	Non-dominant
Epaule ballante (suivant les possibilités d'adaptation par la contraction musculaire)	20 à 30 %	15 à 25 %
Instabilité de l'épaule, en fonction de la fréquence des épisodes et de la répercussion fonctionnelle	6 à 10 %	5 à 8 %

2-1-4-4-2/ Coude

	Dominant	Non-dominant
Coude ballant	30 %	25 %
Coude instable	15%	10%

2-1-4-5/ Atteintes neurologiques périphériques

2-1-4-5-1/ Déficit sensitif des doigts

Le défaut de sensibilité est d'autant plus gênant que l'activité manuelle est plus élaborée.

- Sensibilité tactile thermo algique de protection seule conservée : perte de 50% de la valeur du doigt.
- Sensibilité discriminative médiocre : perte de 10 à 20% de la valeur fonctionnelle du doigt.
- Anesthésie complète : perte de 75% de la valeur fonctionnelle du doigt.

Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits des sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut pas être supérieur à celui de la perte digitale.

2-1-4-5-2/ Paralysie du nerf radial

Dans sa forme moyenne, par atteinte du nerf radial dans la gouttière de torsion de l'humérus, la paralysie radiale génère une main tombante en col de cygne, avec une incidence sur la préhension forte, du fait de défaut de fixation du poignet, et de la gêne à l'ouverture du pouce et des doigts, avec une incidence sur la préhension fine liée à l'absence d'antagoniste des fléchisseurs, rendant difficile la stabilisation de l'objet par manque de contre appui.

	Dominant	Non-dominant
Paralysie totale du nerf radial dans sa forme haute	40 %	30 %
Paralysie totale du nerf radial dans sa forme moyenne	30 %	20 %
Paralysie basse, au poignet, avec déficit modéré des extenseurs du poignet et des doigts	12 %	8 %
Après chirurgie palliative, ou avec le port d'une orthèse, les taux peuvent être ramenés à	15 à 20 %	10 à 15 %

2-1-4-5-3/ Paralysie du nerf cubital (ulnaire)

Marquée par une griffe cubitale de la main, plus marquée au niveau des 4^{ème} et 5^{ème} doigts, et moins marquée sur les 2^{ème} et 3^{ème} doigts avec une atrophie des interosseux qui a un retentissement important sur la prise de force, et un déficit de la qualité de la pince pouce/index. Le déficit de flexion de l'auriculaire gêne le verrouillage satisfaisant de la prise de force.

Il existe par ailleurs une atteinte sensitive du bord interne de la main qui est une zone d'appui.

	Dominant	Non-dominant
Paralysie cubitale à l'avant-bras ou au poignet	20 %	15 %

2-1-4-5-4/ Paralysie du nerf médian

L'atteinte au niveau de l'avant-bras génère une paralysie de la pronation. Au niveau du poignet elle génère une parésie de la flexion et de l'inflexion radiale, et au niveau du pouce, une paralysie de la flexion inter-phalangienne et de la flexion métacarpo-phalangienne, une paralysie de l'opposition du pouce et de son abduction ; au niveau des 4 derniers doigts, une paralysie de l'inter-phalangienne, totale sur les 2^{ème} et 3^{ème} doigts et partielle sur les 4^{ème} et 5^{ème}, ainsi qu'une paralysie de la flexion métacarpophalangienne.

Le déficit sensitif atteint, habituellement la moitié externe de la paume de la main et les collatéraux des 4 premiers doigts.

La gêne fonctionnelle est très importante par déficit de la flexion des doigts, dans les formes hautes, et constamment par le déficit de l'opposition du pouce et par le déficit sensitif des premiers doigts.

	Dominant	Non-dominant
Paralysie totale (forme haute)	35 %	25 %
Paralysie totale (forme basse)	25 %	18 %
Quand l'opposition du pouce est possible, par innervation mixte de l'opposant par le médian et le cubital	10 %	6 %

2-1-4-5-5/ Paralysie du nerf médio-ulnaire

Il existe une griffe des quatre derniers doigts si la paralysie est basse, une main plate si la paralysie est haute, avec un déficit sensitif sur l'ensemble de la main et un déficit important de la fonction de la préhension avec des possibilités palliatives réduites.

	Dominant	Non-dominant
Atteinte médio-ulnaire	40 %	35 %

2-1-4-5-6/ Paralysie du nerf circonflexe

	Dominant	Non-dominant
Paralysie totale du nerf circonflexe (axillaire)	15 %	10 %

2-1-4-5-7/ Paralysie du nerf musculo-cutané

	Dominant	Non-dominant
Paralysie totale du nerf musculo-cutané	10 %	8 %

2-1-4-5-8/ Paralysie du nerf thoracique long

Ce type de paralysie entraîne le décollement et la bascule de l'omoplate lors de la poussée en avant contre une résistance.

	Dominant	Non-dominant
Paralysie totale du thoracique long	6 %	4 %

2-1-4-5-9/ Paralysie du nerf accessoire (spinal)

Ce type de paralysie entraîne un déficit du trapèze et du sterno-cléido-mastoïdien, gênant le soulèvement du moignon de l'épaule et la rotation de la tête.

	Dominant	Non-dominant
Paralysie du nerf accessoire	6 à 8 %	4 à 6 %

2-1-4-5-10 Paralysie du plexus brachial

	Dominant	Non-dominant
Paralysie complète du plexus brachial	60 %	50 %
Syndrome radiculaire supérieur	25 %	20 %
Syndrome radiculaire moyen	30 %	25 %
Syndrome radiculaire inférieur	45 %	40 %

2-2/Fonction de locomotion

2-2-1/ Définition : Capacité à se déplacer.

2-2-2/ Perte de la fonction = La perte totale de la fonction des deux membres inférieurs est évaluée par un taux d'incapacité permanente de **80%**

2-2-3/ Critères d'appréciation

L'appréciation de l'incapacité fonctionnelle résultant des atteintes de la fonction de locomotion doit commencer par une analyse séméiologique fine, analytique, qui va mettre en évidence les amplitudes articulaires, les éventuelles instabilités, la force segmentaire, l'amyotrophie, les réflexes ostéotendineux, la sensibilité sous ses différentes formes, les troubles trophiques et vasculaires.

Dans l'expertise des séquelles traumatiques des membres inférieurs, l'évaluation du taux d'incapacité permanente n'est pas faite par référence au type lésionnel (par exemple fracture de la rotule ou rupture méniscale..), mais en analysant les conséquences fonctionnelles des séquelles, c'est-à-dire les perturbations qu'elles induisent sur la station debout et sur la marche (déficit de la flexion du genou, instabilité du genou...).

Les données objectives de l'examen, et l'analyse des doléances à la lueur de ces constatations objectives, vont permettre d'apprécier la réelle atteinte de la fonction de locomotion,

c'est-à-dire le retentissement fonctionnel des lésions sur la station debout, la marche et les mouvements complexes.

2-2-3-1/ La station debout

- Possible-Impossible-Avec appui(aide humaine ou technique).
- Elargissement du polygone de sustentation.
- Rotation des pieds, flexum du genou et des hanches, inclinaison antérieure du tronc.

2-2-3-2/ La marche

Caractères de la marche

- Avec ou sans boiterie ;
- Etude du pas :
 - attaque du pas, pied à plat, talonnier... , désaxé, bord interne ou externe,
 - déroulement hanche, genou, pieds,
 - coordination musculaire ;
- Cinétique de la marche :
 - normale, à petit pas, saccadée, naturelle ou pensée,
 - facilité de la marche ou non... avec ou sans chaussures...
 - stabilité de la marche ;
- Vitesse :
 - petit pas, normale, accélérée,
 - piétinement, trottement et course ;
- Boiterie :
 - discrète, légère, marquée,
 - permanente ou non,
 - fonction du terrain, du chaussage,
 - de l'aide technique.

Adaptabilité

- Complète, partielle, limitée, douloureuse ;
- En fonction du terrain :
 - lisse ou irrégulier, caillouteux, ferme ou souple,
 - plat ou incliné, escaliers,
 - avec revêtement ou sans... ;
- Périmètre de marche ;
- A l'effort –marche prolongée, nécessité de pauses, durée, assis ou non..., fatigabilité ;
- En fonction des douleurs plus ou moins vives.

Douleurs

- Type (brûlures, torsion, crampes, fourmillements, ...)
- Irradiations
- Permanence
- Circonstances d'apparition
- Traitement
- Répercussions :
 - limitation du périmètre de marche de la locomotion elle-même,
 - conduite d'évitement (terrain irrégulier...),
 - recours à une aide technique.

2-2-3-3/Les mouvements complexes

Accroupissement complet, limité, avec bascule sur le membre inférieur non blessé, avec douleurs, avec appui ou non, difficulté pour se relever, besoin d'aide humaine, douleur ou non.

Agenouillement complet, limité, sur le membre inférieur non blessé, avec appui sur les mains pour le relevage, durée de maintien, possibilité ou non de s'asseoir sur les talons, besoin d'aide pour se relever, douleurs.

Marche sur les talons, sur la pointe des pieds.

Saut à cloche-pied, station monopodale, course sur place.

2-2-3-4/Aides techniques et contraintes thérapeutiques**Nécessité absolue, partielle, permanente ou non**

- Recours à l'intérieur du domicile, à l'extérieur ;
- Fonction du terrain où se fait le déplacement ;
- Fonction de la longueur du déplacement envisagé ;
- En vue d'une meilleure assurance psychologique ;
- En vue de soulager les douleurs...

Type

- Cannes : simples, anglaises, axillaires ;
- Orthèses et prothèses : type, efficacité et/ou tolérance) ;
- Déambulateur : tripode, quadripode ;
- Fauteuil roulant manuel ou électrique, avec ou sans aide humaine.

Contraintes thérapeutiques

- Médicaments, orthèses, prothèses, chaussures orthopédiques ;
- Soins locaux (durillons, ulcères..).

Apport des aides techniques et thérapeutiques

- Sur la qualité de la marche, du déplacement ;
- Sur son adaptabilité et sa durabilité ;
- Sur les douleurs.

2-2-3-5/ Signes d'accompagnement (cf. membre supérieur)

En cas de séquelles complexes des membres inférieurs, les taux indiqués ci-dessous ne doivent pas être additionnés mais combinés pour aboutir à un taux global qui évalue l'état fonctionnel du membre.

2-2-4/ Eléments d'orientation

jusqu'à 10 %	Marche non limitée, mouvements complexes peu limités. Pas d'aide technique.
	Marche normale, parfois douloureuse, sans boiterie, gêne légère dans les mouvements complexes extrêmes, pas d'aide technique.....jusqu'à 3 %
	Marche gênée sur certains terrains, parfois douloureuse, ou légère boiterie, légère limitation de certains mouvements complexes, pas d'aide technique.....3 à 6 %
	Marche un peu limitée, même sur terrain plat, parfois douloureuse, légère boiterie, limitation de certains mouvements complexes, pas d'aide technique.....6 à 9 %

10 à 30 %	Marche et mouvements complexes limités. Aides techniques : 1 ou 2 cannes, orthèse.
	Marche parfois limitée et/ou douloureuse, s'accompagnant de boiterie ou d'instabilité légère, mouvements complexes limités.....10 à 15 %
	Marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie, mouvements complexes difficiles, nécessité d'une canne.....15 à 25 %
	Marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie, mouvements complexes limités, nécessité de deux cannes ou d'une orthèse pour la marche.....25 à 30 %

30 à 60 %	Marche limitée. Mouvements complexes très limités. Aides techniques : 2 cannes ou orthèse ou prothèse.
	Marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie et/ou instabilité, mouvements complexes fortement limités, nécessité de deux cannes, ou d'orthèse, ou d'une prothèse bien tolérée.....30 à 40 %
	Marche limitée et/ou douloureuse, lente et mal assurée, mouvements complexes pratiquement impossibles. Aides techniques : 2 cannes, ou orthèse, ou prothèse moyennement tolérée.....40 à 50 %
	Marche très limitée, station debout possible, mouvements complexes impossibles. Aides techniques : orthèse ou prothèse mal tolérées. Utilisation épisodique du déambulateur, voire du fauteuil roulant.....50 à 60 %

60 à 80 %	Marche et mouvements complexes impossibles. Aides techniques : fauteuil roulant.
	Marche utile impossible, mouvement complexes impossibles, utilisation habituelle du fauteuil roulant, le tout étant modulé selon la qualité de l'usage du fauteuil roulant.....60 à 70 %
	Marche et mouvements complexes impossibles, Usage extrêmement limité ou impossible du fauteuil roulant.....70 à 80 %

2-2-5/ Tableaux cliniques

2-2-5-1/Amputations

Les éléments d'appréciation de l'incapacité se fondent sur :

- **Le niveau d'amputation :**
 - l'utilisation de la prothèse est d'autant plus facile que la fonction de flexion/extension du genou est restituée ;
 - les amputations de l'arrière pied (Chopart, Pirogoff..) ont des conséquences fonctionnelles bien plus importantes que les amputations de l'avant-pied (transmétatarsienne, des articulations de Lisfranc...), d'autant que le tendon d'Achille entraîne une bascule du pied et un appui distal de très mauvaise qualité.
- **La qualité du moignon d'amputation :**

La qualité du moignon est un élément fondamental de l'appréciation des séquelles. Selon ses qualités ou ses vices, il permet l'adaptation d'un appareillage bien supporté ou au contraire il peut être source de conflit, gênant la suppléance prothétique, ce qui compromet la fonction. Les éléments suivants doivent être analysés :

 - La forme du moignon, ovale ou arrondie, bien matelassée, ou au contraire conique, protégeant mal l'extrémité osseuse.
 - L'état des téguments, souples, avec une cicatrice bien placée, non adhérente ou altérée, avec une cicatrice fixée, des lésions irritatives, voire des ulcérations.
 - L'absence d'attitude vicieuse par déséquilibre musculaire, et donc la rectitude des axes segmentaires.
 - La mobilité de l'articulation sus jacente.
 - Les douleurs qui peuvent empêcher l'emboîtement de la prothèse : douleurs des névromes d'amputation, membre fantôme douloureux, causalgies...

Un moignon peut ainsi être normal, ou défectueux, ou pathologique.

- **La qualité de la suppléance fonctionnelle par l'appareillage :**

Il faut apprécier avec précision et de façon globale la possibilité de station debout et de marche, la difficulté à mouvoir la prothèse, la fatigue qui en résulte, l'importance de la boiterie et la souplesse de la démarche, la capacité d'adaptation aux terrains irréguliers, la gêne pour s'asseoir et se relever... tous éléments qui conditionnent la gêne fonctionnelle dans la vie courante. Dans l'ensemble on pourra estimer la valeur d'une prothèse à la possibilité de sa réalisation en prothèse de contact, bien meilleure que les autres moyens de fixation (appareil de suspension).

2-2-5-1-1/ Hanche

Désarticulation de hanche ou amputation haute bilatérale (la gêne fonctionnelle excède la stricte perte de la fonction de locomotion, compte tenu de la perturbation de la fonction assise, notamment) 75 à 80%

Désarticulation unilatérale de hanche, et autres désarticulations hautes (l'appareillage est nécessairement complexe, avec appui ischiatique obligatoire)..... 60 à 70%

2-2-5-1-2/ Cuisse

Amputation de cuisse :

-au ¼ supérieur : appareillage toujours difficile, avec appui ischiatique 55 à 60%

-au 1/3 moyen :

.si difficultés d'appareillage, moignon défectueux ou pathologique, importante boiterie, fatigabilité..... 50 à 60%

.si appareillage satisfaisant, bien adapté et bien toléré, hanche mobile..... 45%

2-2-5-1-3/ Jambe

Amputation de jambe :

.taux modulé suivant le niveau d'amputation (les amputations hautes entraînent une perte de la force d'extension, les amputations basses un appareillage moins bien supporté), la mobilité du genou, l'état du moignon et les difficultés d'appareillage.....

.amputation du tiers moyen, bon appareillage, genou mobile 35 à 45%

.amputation du tiers moyen, bon appareillage, genou mobile 35%

2-2-5-1-4/ Pied

Amputation de l'arrière pied (Syme, Chopart)..... 25 à 35%

Désarticulation tarso-métatarsienne (Lisfranc)..... 20%

Amputation transo-métatarsienne..... 18 à 20%

L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.

-amputation de tous les orteils..... 15%

-premier orteil :

. amputation de deux phalanges avec le métatarsien..... 12%

. amputation de deux phalanges..... 8 à 10 %

. amputation de la phalange..... 4%

-autres orteils :

. amputation d'un orteil..... 2%

. 2^{ème} ou 5^{ème} orteil avec leur métatarsien..... 6%

. 3^{ème} ou 4^{ème} orteil avec leur métatarsien..... 3%

En cas de perte de plusieurs orteils, on fera la somme des divers taux sans que le taux global puisse dépasser le taux de 15%.

2-2-5-2/Séquelles des fractures du bassin

Les fractures extra-articulaires (aile iliaque, branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes) n'ont pas habituellement de retentissement sur la statique pelvienne ni sur la marche.

Parfois persistent des douleurs locales lors des mouvements d'abduction des cuisses, ou de la position assise..... jusqu'à 5 %

Les fractures isolées du sacrum, sans atteintes des articulations sacro-iliaques, laissent parfois persister des séquelles douloureuses rebelles de la région sacrée..... jusqu'à 5 %

Les coccygodynies après fracture ou entorse sacro-coccygienne, souvent rebelles et péniblement ressenties (douleurs en position assise et à la défécation) 5 à 8 %

Les disjonctions pubiennes laissent parfois persister des séquelles douloureuses locales..... jusqu'à 5 %

Les disjonctions des sacro-iliaques, en fonction de la douleur et de la gêne fonctionnelle 5 à 20%

Les traumatismes du bassin ont parfois des répercussions sur les articulations sacro-iliaques, soit par disjonction, soit par lésion propre, avec ou sans lésions associées de l'arc antérieur. Il peut en résulter une bascule, une rotation, une ascension d'un hémibassin, altérant la statique pelvienne et vertébrale et laissant habituellement persister des séquelles douloureuses de la région lombo-sacrée..... 10 à 15 %

En cas de lésion isolée sacro-iliaque, source de douleurs en position assise et à la marche, le taux peut être évalué, selon la gêne 5 à 10 %

2-2-5-3/ Ankyloses articulaires

2-2-5-3-1/ Hanche

Ankylose de la hanche en bonne position.....	25%
Ankylose de la hanche en position vicieuse : flexum, adduction, rotation interne ou externe.....	35 à 40%

2-2-5-3-2/ Genou

Ankylose du genou en bonne position(rectitude ou flexion de 10° qui raccourcit le membre et permet un meilleur passage du pas).....	25 à 30%
---	----------

2-2-5-3-3/ Cheville et pied

Ankylose du pied et des orteils en mauvaise position	30%
Ankylose de l'arrière-pied, tibiotarsienne et sous astragaliennne, avec raideur de l'avant-pied et des orteils.....	20 à 25%
Ankylose du cou-de-pied en bonne position(à angle droit chez l'homme, en léger équinisme chez la femme), non douloureuse, avant-pied souple, orteils mobiles	10 à 12%
Ankylose du gros orteil sans enraidissement des orteils voisins.....	7 à 8%

2-2-5-4/ Raideurs articulaires

2-2-5-4-1/ Hanche

Limitation importante et douloureuse des mouvements de la hanche, avec souvent attitude vicieuse en adduction et rotation.....	jusqu'à 30%
Limitation moyenne(environ de moitié) des mouvements de la hanche, selon l'importance des douleurs	jusqu'à 20%
Limitation peu importante, douleurs intermittentes, fatigabilité(séquelles légères)	5 à 10%

2-2-5-4-2/ Genou

Déficit de flexion léger (flexion possible jusqu'à 110°).....	jusqu'à 5 %
Déficit de flexion important (flexion de 30° à 90°).....	5 à 15 %
Déficit de flexion très important (flexion n'atteignant pas 30°).....	15 à 20 %
Déficit d'extension, inférieur à 5°.....	jusqu'à 5 %
Déficit d'extension, entre 5 et 10°.....	5 à 8 %
Déficit d'extension, entre 10 et 20°.....	8 à 12 %
Déficit d'extension, supérieur à 20°(rare).....	jusqu'à 20 %

2-2-5-4-3/ Cheville et pied

Déficit de la flexion-extension du cou-de-pied fréquent après fracture malléolaire ou rupture du tendon d'Achille. L'angle favorable se situe à 15° de part et d'autre de 90° :	
-perte de la flexion dorsale seule, pied à angle droit, avant pied souple.....	jusqu'à 5 %
-perte de la flexion dorsale et limitation de la flexion d'un tiers.....	5 à 8 %
-pied en équin de plus de 10°, mais conservant une flexion plantaire de 10 à 15°...0	à 12 %
Troubles statiques du pied :	
-pied en varus.....	7 %
-pied en valgus.....	5%
Enraidissement marqué des articulations métatarsophalangiennes des quatre derniers orteils.....	10%

2-2-5-5/Raccourcissement, décalage et modification des axes

RACCOURCISSEMENT :

-jusqu'à 10 mm, compensé par une talonnette, n'entraîne pas d'incapacité..... 0%
-entre 10 et 50 mm, il est générateur d'une incapacité dont le taux peut être évalué..... jusqu'à 10%
-Au delà de 50 mm, il est générateur de désordre important, et le taux d'incapacité qui en résulte est évalué à10 à 15 %
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repère osseux(par exemple : épine iliaque antérosupérieure –malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.

DECALAGE (VICE DE ROTATION) :

-Une rotation interne supérieure à 15° peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la hanche sus-jacente, par défaut de couverture de la tête fémorale.
-Une rotation externe supérieure à 20° peut retentir sur le genou (compartiment postéro-externe).
Il en résulte une incapacité permanente de.....5 à 8 %

MODIFICATION D'AXES :

-Genu varum post-traumatique : douleurs au niveau du compartiment interne..... jusqu'à 10%
-Genu valgum post-traumatique : douleurs au niveau du compartiment externe..... jusqu'à 8%
Cal vicieux articulaire, générateur d'arthrose..... jusqu'à 8%

2-2-5-6/ Instabilité

2-2-5-6-1/ Genou

Laxité antérieure isolée

-avec ressaut antéro-externe typique reproduisant la gêne alléguée..... 5 à 10%
-sans ressaut jusqu'à 5%

Laxité postérieure isolée bien tolérée jusqu'à 5%

Laxité chronique mixte périphérique et antéro-postérieure.....5 à 15%

Laxité chronique grave à la limite de l'arthrodèse20%

Genou ballant appareillé y compris le raccourcissement(par exemple, après ablation de prothèse).....30%

La Patella (rotule) et les syndromes rotuliens ou fémoro-patellaires

La pathologie post-traumatique de la patella doit être différenciée de celle de la dysplasie congénitale de l'appareil extenseur(luxation récidivante de la patella). Les luxations vraies traumatiques sont rares ; l'IPP est à évaluer selon les capacités résiduelles du genou.

Le syndrome fémoro-patellaire se définit par une douleur antérieure avec instabilité survenant à la descente des escaliers et par une douleur à la position assise prolongée : le signe de Smillie reproduit la gêne alléguée.

.post-contusif jusqu'à 3%
.après fracture de la patella(fracture ostéochondrale exceptée)..... jusqu'à 8%

Rupture de l'appareil extenseur, lésion du tendon rotulien ou du tendon quadricipital ou de leurs insertions ; l'évaluation de l'IPP sera fonction du flexum actif persistant..... jusqu'à 8%

2-2-5-6-2/ Cheville

Laxité chronique du cou-de-pied avec instabilité, entorse à répétition, gêne importante à la marche..... 6 à 12%

2-2-5-7 Prothèses et ligamentoplasties

Ligamentoplastie du genou, en fonction de la laxité résiduelle jusqu'à 5%

Prothèse totale de hanche : l'évaluation de l'incapacité permanente liée aux limitations articulaires souvent minimes, et surtout aux contraintes physiques et psychologiques qui restreignent l'activité.....10 à 15%

Les prothèses du genou ont des résultats fonctionnels souvent de moins bonne qualité ; le déficit physiologique s'ajoutant aux contraintes de la prothèse justifie des taux d'incapacité souvent compris entre :15 à 20%

2-2-5-8/ Atteintes neurologiques périphériques

2-2-5-8-1/ Paralyse du nerf sciatique

Au dessus de la bifurcation entre le nerf fibulaire commun (n.sciatique poplité externe) et le nerf tibial (n.sciatique poplité interne)

- forme haute.....45%
- forme basse (fibulaire commun + tibial).....35%

2-2-5-8-2/ Paralyse du nerf fibulaire commun (n.SPE)

- Paralyse totale.....20%
- Selon la compensation ,par appareillage ou transplantation...10 à 15%

2-2-5-8-3 Paralyse du nerf tibial (n.SPI)

Paralyse du nerf tibial.....25%

2-2-5-8-4/ Paralyse du nerf fémoral (n.crural)

- Paralyse du nerf fémoral (n.crural).....30%
- Selon la compensation ou appareillage.....15 à 20%

2-2-5-8-5/ Paralyse du nerf obturateur

Paralyse du nerf obturateur.....jusqu'à 5%

2-2-5-8-6/ Nerf cutané latéral de la cuisse (n.fémoro-cutané)

Névralgie.....jusqu'à 5%

3/ Fonction de soutien

3-1/ Définition

Le squelette axial et la musculature qui lui est associée (axiale et abdominale notamment), assurent le maintien global du corps, par exemple en position érigée.

3-2/ Perte de la fonction

La fonction de soutien est souvent altérée dans le sens d'une limitation de la mobilité rachidienne, et d'une déhiscence de la paroi abdominale.

Enfin, l'altération de la fonction de soutien (douleur et/ou raideur) peut avoir un retentissement sur l'équilibration

3-3/ Critères d'appréciation

3-1-1/ Les troubles de la mobilité et de la statique rachidienne

La statique vertébrale doit être appréciée, de dos et de profil, en position debout (avec et sans correction d'une éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs), en position assise. Cette étude permettra d'apprécier une scoliose dont les courbures seront décrites par le niveau et la latéralité de leur sommet, ainsi que par leur angulation et/ou leur rayon de courbure, mais aussi les modifications des courbures physiques (lordose cervicale et lombaire, cyphose dorsale). Les examens radiographiques peuvent utilement confirmer les constatations cliniques.

La mobilité vertébrale sera étudiée principalement :

- pour le rachis cervical, où il est essentiel de disposer d'une bonne décontraction musculaire pour juger de la mobilité ; les différents mouvements (flexion, extension, rotation, inclinaison, circumduction...) seront étudiés en fonction de

leur amplitude (mesurée en angle, par référence aux distances séparant divers repères), de leur harmonie, et des éventuels réveils douloureux. La limitation des mouvements du cou ne peut être appréciée que par un examen prudent et surtout patient. Il faut comparer les mouvements spontanés (pendant l'entretien, lors du déshabillage et du rhabillage), les mouvements actifs exécutés sur ordre, et les mouvements passifs. Tenir compte de certaines divergences, de contrastes suspects, de la variabilité d'un moment à l'autre, de la tension des muscles de la nuque...

- pour le rachis lombaire, les mouvements de flexion du tronc se font, dans un premier temps, par les articulations coxo-fémorales, puis au niveau du rachis lombaire. L'indice de Shober reste un bon indicateur de la souplesse lombaire (il peut être considéré comme normal au-dessus de 10/14). La distance mains/sol est aussi un indicateur utile. Les mouvements d'extension, de rotation et d'inflexion doivent être étudiés, bassin bloqué (par exemple en position assise).

La musculature para-vertébrale doit faire l'objet d'une étude précise, à la recherche de zones électivement douloureuses et de contractures musculaires. L'épaississement du tissu cellulaire sous-cutané peut également objectiver une allégation douloureuse.

Une éventuelle contention (collier cervical, corset lombaire, lombostat...) doit être précisée.

L'analyse des douleurs doit faire l'objet d'une écoute bienveillante, aussi peu inductive que possible, permettant de faire préciser le type et le siège des douleurs, les circonstances d'apparition, la durée et le rythme de survenue, les traitements éventuellement suivis et leur efficacité... avant et après le fait générateur. Les données de l'examen clinique doivent être appréciées dans les mêmes conditions précisées pour le rachis cervical.

Les complications neurologiques sont abordées dans les chapitres consacrés à la fonction motrice.

3-1-2/ Les déficiences de la paroi abdominale

L'examen clinique devra mettre en évidence :

- Les cicatrices chirurgicales ou traumatiques, en décrivant leur siège, leurs dimensions, leur trophicité ;
- L'état de la paroi musculaire, en précisant sa tonicité et sa trophicité générales, les caractéristiques de ses éventuelles déhiscences, ainsi que l'état des orifices herniaires

L'interrogatoire recherchera essentiellement

- Les douleurs dont le type, le siège, les circonstances d'apparition seront précisés ;
- Les troubles du transit éventuels (cf. chapitre 7 – Fonction métabolique) ;
- Les traitements entrepris (ceinture abdominale, traitement chirurgical : plastie, prothèse...).

3-2/ Eléments d'orientation

Jusqu'à 10% Raideur segmentaire modérée ou légère et épisodique, douleurs intermittentes, déclenchées par des causes précises, obligeant à renoncer parfois à certaines activités ou aux efforts importants ou prolongés, nécessitant la prise épisodique d'antalgiques ou d'anti-inflammatoires, ou le port intermittent d'aides techniques

- Raideur segmentaire légère, épisodique, douleurs intermittentes ne nécessitant pas la prise régulière de traitement ni d'aide technique, ne restreignant pas l'activité habituelle.....jusqu'à 3%

- Raideur segmentaire légère ou modérée, imposant certaines précautions, justifiant la prise épisodique de médicaments, et/ou le port très intermittent d'aides techniques (collier cervical, corset ...) 3 à 5%

- Raideur segmentaire importante et/ou douloureuse, imposant l'arrêt de certaines activités justifiant la prise fréquente de médicaments et/ou le port intermittent d'aides techniques.....5 à 10%

10 à 25% : Raideur segmentaire importante et douloureuse, restreignant l'ensemble des activités, requérant des précautions justifiant un traitement régulier et/ou le port d'orthèses.

- Raideur segmentaire importante et douloureuse, ou étagée, restreignant les activités habituelles, justifiant la prise régulière de médicaments et/ou le port habituel d'aides techniques 10 à 15%

- Raideur étendue, importante, douloureuse, restreignant les activités habituelles, nécessitant la prise constante de médicaments et l'usage habituel d'orthèses rigides 15 à 20%

- Des taux plus élevés peuvent être envisagés dans des situations exceptionnelles d'atteintes globales du rachis (qui peuvent faire envisager des taux qui peuvent atteindre, sans dépasser 25%) ou de complications neurologiques occasionnant un retentissement sur la fonction locomotrice.

Le taux global doit alors se référer à la grille de référence.

3-3/ Tableaux cliniques

1. Rachis cervical
2. Rachis dorsolombaire
3. Paroi abdominale

3-3-1/ Rachis cervical

Douleurs épisodiques ne nécessitant pas de traitement, s'accompagnant d'une légère raideur dans les mouvements extrêmes	jusqu'à 3%
Douleurs régulières justifiant la prise intermittente de médicaments, ou l'usage occasionnel d'un collier avec raideur segmentaire modérée	3 à 5%
Raideur cervicale importante et douloureuse, justifiant la prise régulière d'un traitement, limitant certaines activités	5 à 10%
Ankylose du rachis cervical	15%

Contusion bénigne survenant sur un rachis arthrosique cliniquement muet jusqu'à l'accident : si la dolorisation du rachis peut parfois s'expliquer par le traumatisme, la raideur rachidienne est le plus souvent le fait de l'arthrose d'installation progressive. Il doit en être tenu compte dans l'évaluation de l'incapacité imputable au traumatisme.

Nevralgie cervico-brachiale authentifiée (et en dehors de toute atteinte motrice évaluée distinctement) :	
• survenue épisodique	Jusqu'à 3%
• survenue régulière, intensité modérée	3 à 5%
• survenue fréquente / plusieurs épisodes par an, justifiant un arrêt des activités habituelles de quelques jours au moins, et un traitement	5 à 10%
• chronique et intense, justifiant un traitement continu	Jusqu'à 15%

2-3-3-2/ Rachis dorsolombaire

Dorsolombalgies épisodiques ne nécessitant pas de traitement, avec discrète raideur de la flexion	jusqu'à 3%
Dorsolombalgies régulières, justifiant la prise intermittente de médicaments, et/ou le port épisodique d'une contention, avec raideur modérée (indice de Shober > 10/13)	3 à 5%
Dorsolombalgies constantes, justifiant un traitement continu (médicaments ou contention) avec raideur forte (indice de Shober < 10/13, distance mains/sol supérieure à 30 cm)	5 à 10%
Enraidissement majeur et douloureux	jusqu'à 15%

Nevralgies intercostales, crurales et sciatiques	
Irradiation douloureuse intercostale	3 à 5%
Irradiation douloureuse, notamment crurale et sciatique, (en dehors de toute atteinte motrice dont le retentissement doit être analysé séparément) :	
• survenue épisodique	Jusqu'à 3%
• survenue régulière, intensité modérée	3 à 5%
• survenue fréquente (plusieurs épisodes par an, justifiant un arrêt des activités habituelles de plusieurs jours et un traitement)	5 à 10%
• chronique et intense, justifiant un traitement continu	jusqu'à 15%

2-3-3-3/ Paroi abdominale

Cicatrice de bonne qualité souple et indolore	0%
Cicatrice douloureuse, rétractile ou chéloïde, avec douleurs intermittentes ne nécessitant pas de traitement	jusqu'à 3%
Cicatrice douloureuse justifiant un traitement épisodique ou le port d'une ceinture	3 à 5%
Eventration inférieure à 10 cm, imposant le port régulier d'une ceinture, interdisant certains efforts	5 à 10%

Eventration importante supérieure à 10 cm, restreignant les activités habituelles imposant le port d'une ceinture	10 à 15%
Eventration définitive importante de 10 à 20 cm, avec troubles du transit intestinal.....	10 à 20%

Les retentissements digestifs (voir chapitre 7 – Fonction métabolique) et respiratoire (voir chapitre 6 – Appareil respiratoire) doivent être analysés distinctement.

La fonction visuelle est une fonction sensorielle qui comprend le sens lumineux, la vision des couleurs, l'acuité visuelle et le champ de vision.

4-1-2/ Troubles de l'acuité visuelle

L'examen doit déterminer les acuités centrales de loin (à l'aide des optotypes habituels : échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin à 5 mètres) et de près (échelle de Parinaud à distance normale en vision de près après correction éventuelle de la presbytie).

L'examen peut être complété par l'étude des potentiels évoqués visuels, en particulier en cas de discordance entre les signes fonctionnels allégués et les constatations de l'examen clinique (simulation).

Il est admis que toute vision supérieure à 7/10 après correction correspond à une efficacité visuelle normale : elle n'entraîne pas de gêne fonctionnelle réelle constitutive d'une incapacité.

Le taux d'incapacité permanente peut être éventuellement réduit en cas de correction par des moyens compensatoires (un trouble de la réfraction qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique ne sera pas considéré comme une déficience oculaire génératrice d'incapacité).

Les troubles de la réfraction post-traumatique sont rares. L'étude de l'imputabilité doit tenir compte d'un état antérieur.

- ♦ La perte de la vision des deux yeux (cécité) : **85 %.**
- ♦ La perte de la vision d'un oeil (borgne) : **25 %.**

En cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité est de **28%** pour tenir compte de la gêne fonctionnelle liée à la prothèse.

La mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du préjudice esthétique.

Les taux de réduction fonctionnelle sont fournis par les tableaux 1 et 2 suivants.

Tableau 1 : vision de loin

	10/10	09/10	08/10	07/10	06/10	05/10	04/10	03/10	02/10	01/10	01/20	<1/20	Cécité
10/10	0	0	0	1	2	3	4	7	12	16	20	23	25
09/10	0	0	0	2	3	4	5	8	14	18	21	24	26
08/10	0	0	0	3	4	5	6	9	15	20	23	25	28
07/10	1	2	3	4	5	6	7	10	16	22	25	28	30
06/10	2	3	4	5	6	7	9	12	18	25	29	32	35
05/10	3	4	5	6	7	8	10	15	20	30	33	35	40
04/10	4	5	6	7	9	10	11	18	23	35	38	40	45
03/10	7	8	9	10	12	15	18	20	30	40	45	50	55
02/10	12	14	15	16	18	20	23	30	40	50	55	60	65
01/10	16	18	20	22	25	30	35	40	50	65	68	70	78
01/20	20	21	23	25	29	33	38	45	55	68	75	78	80
<1/20	23	24	25	28	32	35	40	50	60	70	78	80	82
Cécité	25	26	28	30	35	40	45	55	65	78	80	82	85

Tableau 2 : vision de près

	P1, 5	P2	P3	P4	P5	P6	P8	P10	P14	P20	<P20	Cécité
P1, 5	0	0	2	3	6	8	10	13	16	20	23	25
P2	0	0	4	5	8	10	14	16	18	22	25	28
P3	2	4	8	9	12	16	20	22	25	28	32	35
P4	3	5	9	11	15	20	25	27	30	36	40	42
P5	6	8	12	15	20	26	30	33	36	42	46	50
P6	8	10	16	20	26	30	32	37	42	46	50	55
P8	10	14	20	25	30	32	40	46	52	58	62	65
P9	13	16	22	27	33	37	46	50	58	64	67	70
P10	16	18	25	30	36	42	52	58	65	70	72	76
P14	20	22	28	36	42	46	58	64	70	75	78	80
<P20	23	25	32	40	46	50	62	67	72	78	80	82
Cécité	25	28	35	42	50	55	65	70	76	80	82	85

L'utilisation du tableau 2 ne sera nécessaire que dans les cas d'importante dissociation entre les incapacités visuelles de loin et de près. Il conviendra alors de prendre la moyenne arithmétique des deux déficits pour obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination du déficit fonctionnel.

4-1-3 Rétrécissement du champ visuel

L'examen se fait à l'aide de la coupole de Goldmann ou de tout autre type de périmètre (actuellement les champs visuels sont automatisés, assistés par ordinateur et réalisent des périmètres le plus souvent statiques, parfois cinétiques). La technique utilisée doit être précisée.

Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et donc constitutives d'incapacité.

Le champ visuel doit être étudié binoculairement les deux yeux ouverts.

La superposition du tracé sur le schéma 1 ci-dessous donne le taux d'incapacité.

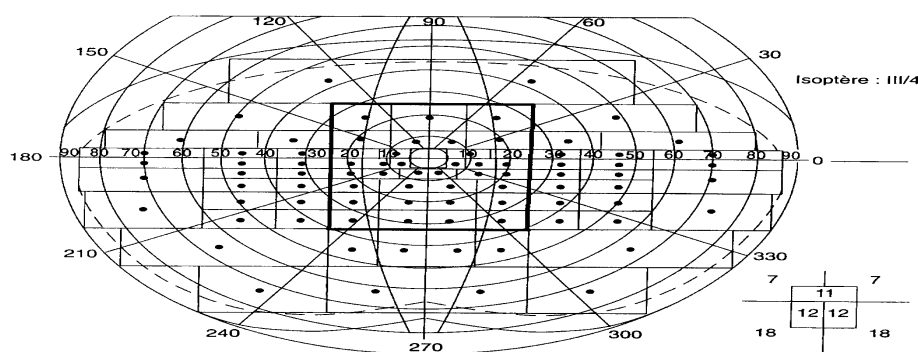


Schéma 1 : Approche de l'indemnisation du champ visuel

[La ligne brisée représente la limite du champ visuel binoculaire normal pour l'isoptère III/4].

Chaque point correspond à une lacune non perçue et à 1 % d'I.P.P.

On procède par addition de points. Le rectangle en marge correspond au champ central.

En cas d'atteinte du champ visuel central, l'examen pourra être complété par un test d'Amster ou équivalent.

4-1-3-1/Hémianopsies

➤ **L'hémianopsie latérale homonyme complète** correspond à la perte de la moitié du champ visuel. Elle entraîne donc une gêne supérieure à la perte de la vision d'un œil seul. Elle justifie selon la valeur de l'épargne maculaire les taux suivants :

- avec épargne maculaire : **42 %**
- avec perte de la vision centrale : si l'épargne maculaire est partielle, calculer le déficit de l'acuité centrale « tableau 1 » puis la rapporter à la capacité visuelle restante post-hémianopsique (85-42 : 43 %) et l'ajouter au taux de 42 %.

Exemple : AV de 3/10 OD et de 4/10 OG : le taux d'I.P.P est de 15 % : imputer sur la capacité visuelle post-hémianopsique (85-42 : 43 %), soit : 6 % à ajouter à 42 % résultant de l'hémianopsie : I.P.P oculaire résultant de l'hémianopsie et de la baisse de la vision est de 48 %.

➤ Hémianopsie altitudinale :

- supérieure (schéma 1) : **jusqu'à 25 %**
- inférieure (schéma 1) : **jusqu'à 60 %**

➤ **Double hémianopsie latérale complète et bitemporale** en fonction du schéma et de la vision centrale : **jusqu'à 85 %**.

➤ **Hémianopsie à type de négligence** : champ visuel normal au périmètre. La réalité de la négligence visuelle ainsi que les conséquences fonctionnelles seront appréciées par le neurologue (les I.P.P peuvent être identiques à celles d'une hémianopsie).

4-1-3-2/ Quadranopsies (schéma 1)

- quadranopsie supérieure : **jusqu'à 14 %**
- quadranopsie inférieure : **jusqu'à 30 %**

4-1-3-3/ Rétrécissements concentriques

Ils sont souvent le fait de manifestations anorganiques et ne justifient alors pas d'I.P.P.

Il est nécessaire d'utiliser de multiples épreuves de contrôle et de confronter le tableau clinique à l'imagerie et à l'examen neurologique.

Il ne faut cependant pas méconnaître les rétrécissements campimétriques bilatéraux organiques résultant de doubles hémianopsies ou liés à des rétinites pigmentaires.

4-13-4/ Scotomes centraux et para-centraux

En cas de perte de la vision centrale : utiliser les tableaux 1 et 2 de l'acuité visuelle.

Les scotomes paracentraux et juxta-centraux avec acuité visuelle conservée :

- touchant un seul œil : **jusqu'à 5 %**
- touchant les deux yeux : le taux est à apprécier en fonction de leur étendue précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire et de leur retentissement sur la lecture de près : **jusqu'à 20 %**

Les scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênent fortement la lecture car situés au même endroit sur chaque œil : **jusqu'à 15%**

4-1-4/ Syndromes oculomoteurs

4-1-4-1/ Hétérophorie

L'incapacité correspond à une gêne fonctionnelle avec sensation de diplopie transitoire ou de flou visuel apparaissant aux efforts prolongés, corrigibles par un effort pénible et conscient.

L'exophorie de près avec insuffisance de convergence est la forme la plus souvent rencontrée. Elle se manifeste essentiellement en vision de près (ou à mi-distance). Classiquement, il s'agit d'une sensation de diplopie transitoire ou de flou visuel apparaissant aux efforts prolongés (lecture ou écran) et s'accompagnant de céphalées frontales obligeant à l'interruption momentanée de l'activité.

L'hétérophorie peut souvent être améliorée par un traitement orthoptique convenablement conduit. L'état séquellaire ne sera apprécié que six mois après la fin des tentatives thérapeutiques.

Décompensation non réductible d'une hétérophorie suivant la gêne : **1 à 5 %**

Paralysie complète de la convergence : **5 %**

4-1-4-2/ Paralysies de fonction de regard

- paralysie vers le haut..... **3 à 5 %**
- paralysie vers le bas..... **10 à 15 %**
- paralysie latérale..... **8 à 12 %**
- paralysie de la convergence..... **jusqu'à 5 %**

4-1-4-3/ Déficiences de la motricité intrinsèque

- paralysie de l'accommodation bilatérale **12 %**
- paralysie de l'accommodation unilatérale..... **5 %**
- mydriase areactive..... **5 %**
- aniridie totale..... **10 %**
- syndrome de Claude Bernard-Horner complet..... **10 %**

4-1-4-4/ Diplopie

En cas de paralysie oculomotrice, le déficit oculomoteur ne peut être évalué que 18 à 24 mois après, qu'il y ait eu ou non traitement chirurgical ou orthoptique.

En cas de séquelles orbitaires, ce déficit sera évalué au moins six mois après la fin du traitement.

L'incapacité pour diplopie est fonction du secteur concerné de l'excentricité du champ de diplopie par rapport à la position primaire du regard et du résultat fonctionnel obtenu avec éventuelle correction prismatique selon le schéma 2 :

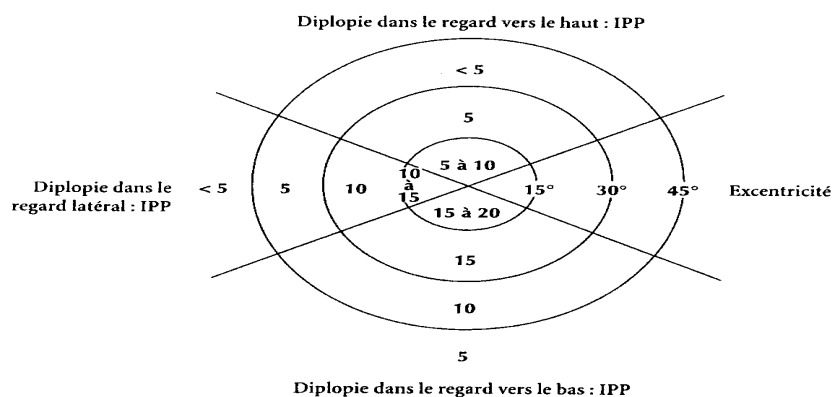


Schéma 2 : Diplopie

L'étude des champs de diplopie et d'aplopie doit être effectuée sans manœuvre de dissociation. Par exemple, on demande au sujet de fixer un objet et on note le champ de double vision.

Diplopie dans les positions hautes du regard..... **2 à 10 %**

Diplopie dans la partie inférieure du champ..... **5 à 20 %**

Diplopie dans le champ latéral..... **2 à 15 %**

Diplopie dans toutes les positions du regard sans neutralisation et obligeant à occlure un oeil en permanence..... **23 %**

4-1-5/ Séquelles des lésions du Cristallin : APHAKIES

Le retentissement fonctionnel de l'aphakie est variable suivant l'équipement optique de compensation (lunettes, lentilles de contact ou implantation d'un cristallin artificiel).

L'évaluation de l'I.P.P prendra en compte le mode d'équipement optique, l'uni ou la bilatéralité, l'âge, la perte éventuelle d'acuité visuelle.

Compensation optique assurée par un cristallin artificiel (pseudophakie) : IPP de **5 %** (pour la perte de l'accommodation) auquel s'ajoutent la baisse éventuelle d'acuité visuelle et d'autres troubles associés (Larmoiement, photophobie...).

Chez l'enfant jusqu'à 16 ans, l'I.P.P de base est de **8 %** pour tenir compte du retentissement de la perte de l'accommodation sur la vision binoculaire.

Compensation optique assurée par lunettes ou lentilles de contact (Aphakie), le taux de base est plus élevé car à la perte d'accommodation s'ajoute l'aniseiconie (taille différente des images reçues par le cerveau, qui ne peuvent être fusionnées qu'au dessous de 8% d'inégalité de taille de ces images).

L'I.P.P de base est :

Aphakie unilatérale, si l'acuité de l'œil opéré est inférieure à celle de l'œil sain**10%**

Aphakie unilatérale si l'acuité de l'œil opéré est supérieure à celle de l'œil sain **15%**

Aphakie bilatérale **22 %**

Le taux est majoré en fonction de la perte éventuelle d'acuité visuelle et d'autres séquelles associées sans cependant pouvoir dépasser 25 % pour une lésion unilatérale.

4-1-6/ Annexes de l'œil

Oblitération unilatérale des voies lacrymales.....	5%
Oblitération bilatérale des voies lacrymales	10%
Larmoiement, photophobie, ectropion, entropion.....	1 à 5%
Cicatrices vicieuses (symblépharon, ankyloblépharon).....	0 à 5%
Ptosis (suivant le déficit campimétrique).....	5 à 10%
Blépharospasme.....	0 à 5%
Alacrymie.....	7%
Manifestations hyperalgiques et dysesthésiques au niveau des terminaisons orbitaires	3 à 5%

4-2/ LES SEQUELLES ORL

4-2-1/ Dommage auditif

4-2-1-1/ Déficit auditif

Sa détermination repose sur un bilan clinique complet et sur un bilan para-clinique qui doit comporter au minimum, une impédancemétrie complète (tympantométrie avec recherche du seuil des réflexes stapédiens), une audiométrie tonale subjective liminaire et une audiométrie vocale.

Si besoin est :

- La qualité du champ auditif au-delà du 8000 Hz sera appréciée par l'audiométrie des hautes fréquences ;
- La réalité du déficit pourra être confirmée par des tests objectifs (oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs précoces).

Les hypoacusies post-traumatiques ne sont plus évolutives au-delà de 12 mois.

- **Surdité complète bilatérale..... 60%**
- **Surdité complète unilatérale.....14%**

- **Pertes auditives partielles :**

L'évaluation se fait en deux temps :

- a) Evaluation de la perte auditive moyenne (PAM) par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesuré en décibels sur le 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, en affectant des coefficients de pondération de 2, 4, 3 et 1. La somme est divisée par 10. On se reporte au tableau 1, à double entrée, pour l'appréciation des taux.

PAM en dB	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 et +
0-19	0	2	4	6	8	10	12	14
20-29	2	4	6	8	10	12	14	18
30-39	4	6	8	10	12	15	20	25
40-49	6	8	10	12	15	20	25	30
50-59	8	10	12	15	20	25	30	35
60-69	10	12	15	20	25	30	40	45
70-79	12	14	20	25	30	40	50	55
80 et +	14	18	25	30	35	45	55	60

Tableau 1 : Taux d'incapacité permanente partielle en fonction de la perte auditive

- b) Confrontation de ce taux brut aux résultats d'une audiométrie vocale pour apprécier d'éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier) qui aggravent la gêne fonctionnelle. Le tableau 2 propose les taux de majoration qui peuvent éventuellement être discutés par rapport aux résultats de l'audiométrie tonale liminaire.

% discrimination	100%	90%	80%	70%	60%	< 50%
100%	0	0	1	2	3	4
90%	0	0	1	2	3	4
80%	1	1	2	3	4	5
70%	2	2	3	4	5	6
60%	3	3	4	5	6	7
< 50 %	4	4	5	6	7	8

Tableau 2 : Majoration des taux d'IPP en fonction du pourcentage de discrimination.

Tenir compte de l'amélioration fonctionnelle d'un appareillage auditif qui peut réduire le taux d'incapacité d'au moins 25%.

4-2-1-2/ Lésions tympaniques

- Une perforation tympanique sèche n'entraîne pas par elle-même d'incapacité sauf incidence sur l'audition ;
- **Une otorrhée persistante.....2 à 4 %**
(Taux qui s'ajoute à celui de l'hypoacousie)

4-2-1-3/ Sténose du conduit auditif externe

Elle est génératrice de bouchons, d'infections.

- **Sténose du conduit.....1 à 3%**

4-2-1-4/ Acouphènes et hyperacousies douloureuses

Leur intensité ressentie n'est pas dépendante de l'importance du déficit auditif. Aucun test ne permet d'objectiver ce trouble. L'expert pourra cependant recourir à une acouphénométrie subjective et à des tests reconnus : questionnaire « DET » (mesure de DETresse psychologique), questionnaire « SEV » (échelle subjective de SEVérité).

Dans la plupart des cas, il se produit en 12 à 18 mois un phénomène d'habituation cérébrale. On peut alors proposer un **taux allant jusqu'à 3%**. Lorsque le retentissement psychoaffectif est sévère, la détermination du taux d'incapacité doit se faire dans un cadre multidisciplinaire.

4-2-2/ Troubles de l'équilibration

L'expert doit procéder à un interrogatoire méthodique et à un examen clinique complet à la recherche notamment d'une hypotension orthostatique.

Ce type de troubles sera exploré au mieux par une vidéonystagmographie (étude de l'oculomotricité, du réflexe vestibulo-oculaire angulaire, et du réflexe vestibulo-oculaire linéaire). La posturographie dynamique computerisée permet une approche globale de la stratégie d'équilibration d'un sujet. Elle est d'un grand intérêt dans le dépistage des simulations.

L'exploration de l'équilibration est indissociable de celle de l'audition.

Dans certains cas, un avis neurologique ou ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.

L'essentiel pour l'appréciation de la gêne fonctionnelle n'est pas la mise en évidence d'une lésion, mais la qualité de la stratégie de compensation développée par le sujet.

- **Vertige paroxystique positionnel bénin.....jusqu'à 4%**
- **Atteinte vestibulaire périphérique unilatérale (selon la qualité de la compensation).....3 à 8%**
- **Atteinte vestibulaire destructive périphérique bilatérale10 à 20%**
- **Atteinte déficitaire otolithique.....3 à 5%**
- **Syndrome central authentique et objectivé :**

Ce diagnostic doit impérativement être confirmé dans un cadre multidisciplinaire : oto-neuro-ophtalmologique. Il ne peut être proposé un taux spécifiquement ORL.

4-2-3/ Dommage vocal

- **Aphonie.....25 %**
- **Dysphonie partielle isolée.....jusqu'à 10%**

Les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire seront évalués séparément.

Souligner l'importance du retentissement professionnel de la dysphonie chez les professionnels de la voix : enseignants, chanteurs, etc.

4-2-4/ Dommage olfactif

L'exploration de ce sens ne fait appel actuellement qu'à des tests subjectifs de perception et de reconnaissance d'odeur. Ces explorations doivent être effectuées sur chaque fosse nasale séparée. Un déficit de ce type peut, ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet.

- **Anosmie :.....8%**
- **Hyposmie :3 à 5%**

L'existence de **parosmies peut justifier un taux spécifique supplémentaire de 2%**. Le retentissement sur le goût ne s'ajoute pas aux taux proposés ci-dessus.

4-2-5/ Dommage nasal

4-2-5-1/ Gêne respiratoire

Seule une rhinomanométrie peut permettre une évaluation plus proche de la réalité.

- **Diminution unilatérale de la perméabilité nasale.....jusqu'à 3%**
- **Diminution bilatérale de la perméabilité nasale.....jusqu'à 6%**

4-2-5-2/ Perforation septale

- **Perforation septale persistante.....jusqu'à 3%**

4-2-5-3/ Sinusite

- Sinusite chronique post-traumatique (selon l'uni ou la bilatéralité)...jusqu'à 8%

4-2-6/ Dommages faciaux

4-2-6-1/ Paralyse faciale

- Paralyse faciale unilatérale complète et totale.....20%
- Paralyse faciale unilatérale incomplète (parésie).....2 à 10%
- Paralyse faciale unilatérale partielle (facial supérieur, facial inférieur)...2 à 10%
- Paralyse faciale bilatérale.....40%

4-2-6-2/ Hémispasme facial

Selon l'importance de la contracture et la fréquence des crises spastiques).....10 à 15%

4-2-6-2/ Dommages laryngés et trachéaux

En cas de trachéotomie définitive, de trachéomalacie, de sténose trachéale ou de sténose laryngée, le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué en fonction du retentissement sur la respiration (importance de l'insuffisance respiratoire chronique), la déglutition et la phonation.

- Sténose trachéale bien tolérée, sans limitation fonctionnelle pour la vie courante et avec une surveillance espacée.....jusqu'à 5%
- Sténose trachéale bien tolérée, avec une endoprothèse, justifiant une surveillance régulière, et en fonction du retentissement respiratoire.....5 à 10 %
- En cas de retentissement respiratoire sévère, le taux de d'incapacité permanente partielle doit être évalué en fonction de ce retentissement.

4-2-8/ Dommages Gustatifs

- Agueusie.....5%

5/ Appareil cardio-vasculaire

L'évaluation du déficit imputable à un traumatisme de l'appareil cardio-vasculaire doit se baser d'abord, quelles que soient la nature et l'origine de la lésion en question, sur les manifestations fonctionnelles dont il est possible de graduer l'importance en se référant à la classification NYHA (New York Heart Association).

Classification NYHA :

Classe I : Patient asymptomatique, activité physique ne provoque pas de gêne

Classe II : Gêne modérée, patient asymptomatique au repos. L'effort physique normal occasionne des symptômes d'efforts +++ (dyspnée)

Classe III : Gêne prononcée apparaissant pour un effort modeste et entravant l'activité ordinaire

Classe IV : Gêne permanente au repos et majorée au moindre effort

La gêne fonctionnelle peut être due à la douleur et à la dyspnée selon des degrés divers. Ce barème tient compte de la gêne fonctionnelle résultante quelle qu'en soit l'origine.

Le bilan fonctionnel est validé par un examen clinique et par l'analyse de l'ensemble des examens paracliniques déjà pratiqués (ECG, échographie trans-thoracique voire trans-oesophagienne, Holter, Doppler, épreuve d'effort, cathétérisme...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs. Il conviendra à l'expert de tenir compte, au cours de l'évaluation des séquelles, des contraintes thérapeutiques et de la surveillance que celles-ci imposent.

5-1/ Séquelles myocardiques :

- Gêne fonctionnelle légère du fait de douleurs post-traumatiques, bonne tolérance à l'effort. Aucun signe de dysfonction myocardique ou d'ischémie à l'effortjusqu'à 5%.
- Idem avec contraintes thérapeutiques et surveillance5 à 8%.
- Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (classe fonctionnelle I), aucun signe de dysfonction ou d'ischémie myocardique, contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique régulière8 à 15%.
- Gêne fonctionnelle alléguée pour des efforts importants, signes de dysfonction myocardique (écho-doppler, cathétérisme....) contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique rapprochée.....15 à 25%.
- Gêne fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages) (classe fonctionnelle II), confirmée par l'ECG d'effort et/ou par l'existence de signes de dysfonction myocardique, contre-indication pour des efforts physiquement contraignants; contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée.....25 à 35%
- Gêne fonctionnelle entravant l'activité ordinaire (marche rapide, classe fonctionnelle II ou III), altération franche des paramètres échographiques ou à l'écho-doppler, intolérance à l'effort avec anomalies à l'ECG d'effort.....35 à 40%
- Idem, avec contrainte thérapeutique importante (quadri- ou pento-thérapie) et/ou troubles du rythme symptomatiques et documentés.....40 à 50%
- Gêne fonctionnelle pour des efforts modestes (classes fonctionnelles III et III+) associée à des manifestations d'insuffisance myocardique (œdème pulmonaire) ou à des complications vasculaires périphériques ou à des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite.....50 à 70%
- Symptomatologie fonctionnelle majeure même au repos (classe fonctionnelle IV) confirmée par les données cliniques (déshabillage, examen clinique) et paracliniques, contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations fréquentes.....60 à 90%.

En cas de transplantation cardiaque :

L'éventualité d'une transplantation cardiaque prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement étroite du patient. Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immunosuppresseurs, le taux d'incapacité permanente peut varier de25 à 30%.

5-2/ Les valvulopathies post-traumatiques :

Contraintes liées à la nécessité du traitement anticoagulant, de la prophylaxie anti-bactérienne et d'une surveillance cardiologiquejusqu'à 10%

En cas de retentissement fonctionnel lié à la valvulopathie, ajouter un taux d'incapacité permanente selon le degré de la gêne en se référant au tableau ci-dessus.

5-3/ Atteintes péricardiques :

En cas de gêne fonctionnelle, prévoir une incapacité permanente partielle selon la gêne fonctionnelle liée à ces atteintes (voir tableau cité au paragraphe 1).

5-4/ Les prothèses :

L'attribution d'une incapacité permanente en cas de pose d'une prothèse est justifiée par les contraintes thérapeutiques (prise de médicaments) et de surveillance (contrôles médicaux répétés, hygiène de vie...). Cette analyse s'applique à toute forme de prothèse (valvulaire, vasculaire ou d'endoprothèse). Il en va de même de l'éventualité d'un stimulateur ou d'un défibrillateur automatique implantable. Ce taux peut varier de5 à 20%.

En cas de gêne fonctionnelle, prévoir une incapacité permanente partielle selon la gêne fonctionnelle liée à ces atteintes (voir tableau cité au paragraphe 1).

5-5/ Séquelles pariétales :

Séquelles pariétales douloureuses persistantes de thoracotomie et de sternotomie.....**jusqu'à 8%**

5-6/ Séquelles vasculaires :

5-6-1/ Séquelles artérielles :

Une incapacité permanente est attribuée en cas de pose d'une prothèse, justifiée par les contraintes thérapeutiques éventuelles (prise de médicaments) et de surveillance (contrôles médicaux répétés, hygiène de vie...).

En cas de déficit fonctionnel du fait de l'atteinte artérielle dont il faut d'abord vérifier le degré d'imputabilité au traumatisme, le taux d'incapacité permanente sera chiffré selon la gêne fonctionnelle résiduelle :

- En cas d'atteinte vasculaire cérébrale, il faut apprécier le retentissement cérébral.
- En cas de claudication, apprécier son degré (intensité, bilatéralité...).

Pour les amputations, se référer au chapitre « appareil locomoteur ».

5-6-2/ Séquelles veineuses :

Il s'agit de séquelles objectives de phlébite (dont il faut vérifier l'imputabilité). Les séquelles peuvent être appréciées de la manière suivante :

- Sensation de jambe lourde, pas de restriction de l'activité, œdème allégué en fin de journée. Pas de troubles trophiques objectifs.....**jusqu'à 5 %**
- Gêne à la marche prolongée. Œdème permanent mesurable nécessitant de façon définitive le port d'un bas de contention, dermite ocre.....**5 à 10 %**
- Idem avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement anti-coagulant, filtre cave.....)**10 à 20 %**
- En cas de bilatéralité..... **jusqu'à 30%**
- Nécessité d'un traitement anticoagulant permanent.....**jusqu'à 10%**

Les séquelles permanentes et objectives d'une embolie pulmonaire seront appréciées selon le retentissement fonctionnel respiratoire.

6/ Appareil respiratoire

L'estimation de l'incapacité permanente liée aux séquelles respiratoires d'un traumatisme doit se baser sur l'importance de la gêne fonctionnelle résiduelle occasionnée.

L'insuffisance respiratoire s'apprécie à distance d'un épisode aigu selon :

- L'importance de la dyspnée qu'il est possible de graduer en se référant à l'échelle des dyspnées de Sadoul.

Classification de la dyspnée selon Sadoul (5 stades)

Stade 1: dyspnée pour des efforts importants

Stade 2 : dyspnée apparaissant à la montée d'un étage, ou à la marche rapide ou à la marche en légère cote

Stade 3 : dyspnée à la marche normale sur terrain plat

Stade 4 : dyspnée à la marche lente

Stade 5 : dyspnée au moindre effort, à l'habillage, à la parole.

- L'examen clinique.
- L'analyse des résultats des examens para-cliniques déjà pratiqués (imagerie, endoscopie, gazométrie...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs (VEMS/CV, CPT, Sa O₂...).

6-1/ Insuffisance respiratoire chronique :

L'évaluation doit tenir compte de l'état antérieur de la fonction respiratoire. En cas de discordance entre les plaintes respiratoires et les paramètres fonctionnels de repos normaux, un test de marche de 6 minutes peut être effectué et/ou une épreuve d'effort peut être pratiquée en l'absence de contre-indication.

L'incapacité permanente varie selon l'échelle suivante :

- Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure de l'une des épreuves fonctionnellesjusqu'à **10%**

- Dyspnée à la montée d'un étage, à la marche rapide ou en légère pente avec CV ou CPT ou VEMS entre 70 et 80% **10 à 20%**

- Dyspnée à la marche sur terrain plat avec CV ou CPT entre 60 et 70% ou bien VEMS entre 60 et 70% **20 à 30%**

- Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec CV ou CPT entre 50 et 60% ou VEMS entre 40 et 60% ou hypoxémie de repos (PaO_2 entre 60 et 70 mm Hg)**30 à 60%**

- Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec CV ou CPT inférieure à 50 % ou VEMS inférieur à 40 % ou hypoxémie inférieure à 60 mm Hg associée ou non à un trouble de la capnie (PaCO_2), avec éventuelle contrainte d'une oxygénothérapie de longue durée (>16 h/ jour) ou d'une trachéotomie ou d'une assistance ventilatoire intermittente**60 à 90%**

6-2/ Asthme :

Il peut entraîner un handicap alors que la fonction respiratoire inter-critique reste normale. Il s'agit d'asthme intermittent:

- ne nécessitant pas de traitement de fond..... **jusqu'à 5%**
- nécessitant un traitement de fond**5 à 10%**

Si anomalie persistante de l'exploration fonctionnelle respiratoire, le taux d'incapacité sera estimé selon la sévérité de l'insuffisance respiratoire persistante.

6-3/ Séquelles pariétales:

- Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie ou de fractures de côtes ou du sternum sans gêne respiratoire.....**jusqu'à 8%**

Si déformation thoracique résiduelle et gêne respiratoire permanente, le taux d'incapacité sera estimé selon la sévérité de l'insuffisance respiratoire (voir taux mentionnés au paragraphe 1) et majoré selon l'importance des douleurs résiduelles.

6-4/ Séquelles pleurales isolées :

Le retentissement fonctionnel lié aux séquelles pleurales (douloureuses et respiratoires) isolées justifie l'attribution d'une incapacité permanente allant **jusqu'à 10%**.

6-5/ Séquelles diaphragmatiques :

La baisse de la mobilité d'une coupole entraîne une gêne respiratoire en général légère à modérée, entraînant une incapacité permanente estimée..... **jusqu'à 8%**.

L'apparition de troubles fonctionnels (digestifs, respiratoires, douleurs...) en rapport avec une hernie diaphragmatique post-traumatique non corrigée est de nature à entraîner une incapacité permanente estimée entre**8 à 12%**.

6-6/ Sténose trachéale (basse) et/ou bronchique :

L'incapacité permanente partielle sera estimée selon l'insuffisance respiratoire résultante. Le taux d'incapacité sera majoré de 5% en cas d'épisodes de surinfections et de contraintes thérapeutiques particulières liées à la sténose (nécessité de dilatations répétées).

6-7/ Exérèses pulmonaires :

Les séquelles seront appréciées en fonction de l'insuffisance respiratoire résiduelle et les conséquences du traitement nécessaire (chirurgie d'exérèse segmentaire, lobaire ou d'un poumon entier), de l'importance des douleurs thoraciques et des symptômes rattachés à l'étiologie ainsi que des contraintes liées aux traitements nécessaires.

L'importance des conséquences fonctionnelles (douloureuses et/ou respiratoires) résiduelles permettra d'estimer le taux d'incapacité permanente partielle (voir plus haut).

A titre indicatif,

. Exérèse segmentaire avec des conséquences fonctionnelles (douloureuses et/ou respiratoires) légères.....**5 à 10%**

. Exérèse lobaire avec des conséquences fonctionnelles (douloureuses et/ou respiratoires) modérées à moyennes,**15 à 20%**

. Exérèse d'un poumon avec des conséquences fonctionnelles (douloureuses et/ou respiratoires) importantes.....**40 à 50%**

7/ Fonction métabolique Nutrition et Métabolisme

7-1/ Définition :

Ensemble de processus par lesquels l'organisme utilise les aliments pour assurer sa vie, sa croissance, le fonctionnement normal de ses organes et de ses tissus, assure les métabolismes nécessaires à ses dépenses énergétiques.

7-2/ Perte de la fonction :

La fonction de nutrition est une fonction vitale dont la perte totale ne peut être compensée que par une nutrition parentérale exclusive, très difficile à maintenir sur le long terme. Il est cependant exceptionnel que l'atteinte isolée de la fonction métabolique puisse faire envisager un taux supérieur à 70%.

L'individualisation d'un taux est difficile, du fait d'une intrication avec d'autres tableaux cliniques majeurs, et la répercussion sur la plupart des grandes fonctions.

7-3/ Critères d'appréciation :

On peut tenter une classification fondée sur :

7-3-1/ Les signes fonctionnels :

- troubles de la mastication, avec les dysphagies ;
- troubles du transit (syndrome sub-occlusif, diarrhée, problèmes de continence) ;
- troubles de l'appétence ;
- les signes de dysfonctionnement endocriniens ;

7-3-2/ Les différentes contraintes :

- les contraintes alimentaires : qui pourront être légères avec régime, sélection alimentaire, fractionnement des repas ; plus importantes, avec alimentation liquide, semi-liquide ou pâteuse ; dans les cas extrêmes, alimentation par voie parentérale ou par voie entérale sur stomie ;
- les contraintes thérapeutiques : notamment celles liées aux hormonothérapies substitutives, type de produits utilisés, mode d'administration, nombre de prises quotidiennes, fréquence des administrations, contraintes liées à la surveillance médicale, stabilité de l'équilibre obtenu.
- Les contraintes liées à la nécessité d'une stomie : appareillée ou non, en permanence ou non, plus ou moins bien adaptée, adaptation de l'appareillage, fréquence de renouvellement de la stomie, retirée seul ou avec l'aide d'un tiers.

7-3-3/ Le retentissement sur l'état général :

- degré d'asthénie ;
- perte de poids, éventuellement en pourcentage ;
- signes de carence ;
- troubles de la régulation tensionnelle.

7-3-4/ Les Signes biologiques :

- protidémie ;
- albuminémie ;
- volume globulaire moyen ;
- folates ;
- taux de prothrombine ;
- vitamine D ;
- calcium ;
- lipides.

7-3-5/ Eléments d'orientation :

Jusqu'à 10% Signes fonctionnels permanents sans retentissement sur l'état général	
Signes fonctionnels permanents sans nécessité de sélection ou régime alimentaire.....	jusqu'à 5%
Signes fonctionnels légers à modérés, permanents avec sélection ou régime alimentaire peu contraignant, sans restriction des activités quotidiennes, sans troubles biologiques notables.....	5 à 10%

10 à 30% signes fonctionnels marqués et /ou contraintes sans altération de l'état général avec retentissement biologique objectivé.	
Troubles marqués de la manducation ou du transit :	
• nécessité d'une sélection ou d'un régime alimentaire,	
• fuites anales fréquentes et inopinées.....	10 à 15%
Nécessité d'un régime alimentaire contraignant, sans altération de l'état général, sans retentissement métabolique, stomie sans appareillage permanent ou Incontinence sphinctérienne anale.....	15 à 20%
Retentissement métabolique compensé, avec contraintes thérapeutiques importantes et/ou troubles fonctionnels marqués, sans altération de l'état général, perturbant modérément et/ou inconstamment la vie quotidienne, avec retentissement biologique objectivé.....	20 à 30%

30 à 40% Retentissement sur l'état général et/ou contraintes thérapeutiques très importantes	
Altération de l'état général, amaigrissement, asthénie, restriction de l'activité quotidienne.	
Stomie à appareillage permanent.....	30 à 40%

> à 40% Altération profonde de l'état général malgré des contraintes thérapeutiques majeures.	
Profonde altération de l'état général et des conditions de la vie quotidienne, qui est nettement perturbée. Mauvaise adaptation d'une stomie à appareillage permanent, nécessitant des soins quotidiens, un traitement et/ou des contraintes diététiques.....	40 à 60%
Altération de l'état général limitant considérablement les activités habituelles.....	70%

1. Stomatologiques et ORL
2. Digestifs
3. Hépatiques.
4. Endocriniens
5. Spléniques

La perte de chaque dent (imputable à l'accident) est évaluée par un taux d'incapacité de :

1 % pour une incisive,
1,25 % pour une prémolaire ou dent de sagesse,
1,50 % pour une canine et pour une molaire,

Pour la perte de la vitalité pulpaire d'une dent0,5 %

Le taux maximum pour une édentation totale ne pouvant pas cependant être supérieur à 30%

Après appareillage les taux ci-dessus sont réduits de moitié s'il s'agit d'une prothèse mobile,
des 2/3 en cas de prothèse fixe,

Le taux maximum pour une édentation totale appareillée ne pouvant pas être supérieur à
.....15 %

Gêne masticatoire par limitation de l'ouverture buccale

distance inter-incisive de 25 à 30mm.....5 à 8%
distance inter-incisive de 10 à 25mm.....10 à 25%
distance inter-incisive au-dessous de 10mm.....30 à 35%

Troubles de l'articulé dentaire, amputation partielle de la langue, légère modification
des modalités alimentaires.....jusqu'à 10%

Fistule salivaire définitive, en fonction de la gêne ressentie et des
précautions nécessaires.....jusqu'à 15%

Paralysie faciale, unilatérale, inférieure, en fonction de la gêne liée surtout aux fuites
salivaires.....jusqu'à 8%

Réséction digestive limitée, résection hépatique sans conséquence biologique, en fonction des signes fonctionnels habituellement mineurs, et des conséquences pariétales.....	jusqu'à 5%
Troubles digestifs légers et/ou intermittents, gêne douloureuse, pas ou peu de contraintes alimentaires, état général normal, absence d'anomalies biologiques.....	5 à 10%
Syndrome subocclusif chronique, avec troubles du transit nécessitant un régime, un fractionnement des repas, un traitement médical, conservation de l'état général examens biologiques légèrement perturbés.....	10 à 20%
Stomie bien supportée, avec un appareillage permanent (par exemple une colostomie gauche).....	5 à 20%
Iléostomie terminale définitive avec ou sans réservoir de Koch, avec débit continu.....	20 à 30%
Réséction digestive étendue, oesophagogastrectomie totale, oesophagoplastie colique, signes fonctionnels marqués, importantes contraintes alimentaires avec plus de six repas quotidiens.....	15 à 20%
Incontinence anale avec selles obtenues par toucher rectal, suppositoires ou lavement, sans fuite intermédiaire.	
Fuites fréquentes et inopinées ou épisodes répétés de débâcle diarrhéique.....	10 à 15%
Incontinence sphinctérienne totale et permanente.....	20 à 30%
Troubles du transit mal contrôlés par régime ou traitement, quatre à six selles diarrhéiques par jour, amaigrissement avec perte de 10 à 20% du poids moyen, perturbation biologique relativement importante.	
Sphincter anal artificiel : l'incapacité doit être évaluée par référence aux résultats fonctionnels obtenus.....	30 à 40%

7-5-3/ Hépatiques

Stigmate sérologiques ou biologiques d'une atteinte hépatique, sans perturbation fonctionnelle	jusqu'à 5%
Hépatite active, avec enzymes hépatiques élevées, sans signe de fibrose ou d'insuffisance hépatique, en fonction des troubles fonctionnels, du retentissement psychologique et des contraintes thérapeutiques	Jusqu'à 20%
Insuffisance hépatique, en fonction des troubles fonctionnels, du retentissement sur l'état général et des contraintes thérapeutiques ; tableau clinique de cirrhose correspond à la classe modérée du tableau ci-dessous	20 à 50%
Cirrhose évolutive, en fonction des troubles fonctionnels, du retentissement sur l'état général et des contraintes thérapeutiques ; tableau clinique de cirrhose correspond à la classe sévère du tableau ci-dessous.....	50% et plus

CLASSE	MODEREE	SEVERE
Bilirubine	de 0 à 80	supérieur à 80
Albumine	de 25 à 35	inférieur à 25
Ascite	absente ou contrôlée médicalement	incontrôlée
Signes neurologiques	absents ou minimes	modérée à sévère
Etat nutritionnel	normal ou bien conservé	altéré
INR	jusqu'à 2,5	2,5
Régénération	présente	absente

Tableau modifié et adapté à partir de la classification de CHILD pour le cas de cirrhose hépatique prouvée, inspiré du barème québécois.

Grefe hépatique, en fonction des contraintes et de la tolérance du traitement	30 à 50%
---	----------

7-5-4/ Endocriniens

7-5-4-1/ Diabète sucré post-traumatique :

Le diabète sucré se définit biologiquement par l'association d'une hyperglycémie et d'une glycosurie durables, c'est-à-dire retrouvées à plusieurs examens répétés.

Le dosage de l'hémoglobine glycosylée (Hb A 1C), reflet des moyennes glycémiques des 60 à 90 jours qui ont précédé le dosage, présente un grand intérêt pour confirmer la présence d'un diabète, suivre son évolution et sa correction sous traitement, éventuellement aussi pour aider à apprécier le moment de son apparition (ou de son aggravation). Le taux normal d'hémoglobine glycosylée est de 6 à 6,8%, un taux de 7% ou plus est pathologique.

On oppose 2 types de diabètes sucrés :

- **le diabète gras**, non insulino-dépendant, ou type 2, qui apparaît cliniquement après 40 ans, de façon insidieuse et dont la surcharge pondérale est le facteur causal essentiel des sujets génétiquement prédisposés (sans relation avec le système HLA).
- **Le diabète maigre**, insulino-dépendant, ou type 1, qui apparaît chez l'enfant ou l'adulte jeune avant 30 ans, là encore à la faveur d'une prédisposition génétique (association à certains antigènes du système HLA situés sur le chromosome 6, plus particulièrement le locus DR) ;le déclenchement de la maladie correspond à un processus auto-immun avec infiltration des îlots de Langerhans par des lymphocytes T activés et présence dans le sang d'anticorps anti-cellules des îlots. L'installation est toujours aiguë, rapide ou même brutale par un coma, avec acidocétose nécessitant l'apport d'insuline.
- **Il existe des formes intermédiaires**, par exemple le diabète métabolique qui réalise le passage d'un diabète gras à un diabète maigre insulino-dépendant ; il s'agit d'ailleurs plus souvent de « décompensations » temporaires, nécessitant un apport insulinaire de quelques semaines, avant le retour à l'état antérieur non insulino-dépendant.

L'existence du diabète sucré créé par un traumatisme, ne peut être établie de façon incontestable par aucune preuve scientifique. Elle repose donc sur des présomptions, qui peuvent être, cependant, suffisantes pour établir l'imputabilité. Les exigences médico-légales sont les suivantes :

- **L'absence d'état antérieur diabétique** : cela signifie que le sujet était totalement indemne de la maladie diabétique avant l'accident. L'existence d'une prédisposition génétique liée au système HLA n'a pas de conséquences médico-légales. Le dosage précoce de l'hémoglobine glycosylée peut, par contre, être un élément d'appréciation rétrospectif de l'état glycémique au cours des semaines qui ont précédé l'apparition clinique du diabète.
- **L'apparition brutale du diabète insulino-dépendant**, acidocétosique, dans un délai toujours bref après l'accident incriminé : quelques jours à quelques semaines, toujours moins de deux mois. La relation de cause à effet devient beaucoup plus discutable lorsque le délai d'apparition se situe entre 2 et 6 mois.
- **Le traumatisme causal** est exceptionnellement pancréatique : contusion hémorragique ou pseudo-kyste traumatique du pancréas. Il faut en effet que les 4/5 de la glande soient détruits pour qu'apparaisse le diabète insulino-dépendant. Il ne s'agit pratiquement jamais de traumatisme crânien. Le traumatisme habituellement incriminé est émotionnel : il s'est agi toujours d'une émotion très forte, avec peur intense de mourir (ou de voir mourir un proche) parfois prolongée de ruminations obsédantes les jours suivants. Cela pose le problème du rôle des facteurs psychiques dans les réactions de tolérance immunitaire ;
- **Enfin le diabète doit être durable**, persistant après plusieurs mois de traitement, et nécessitant par conséquent la poursuite définitive de ce traitement. Un recul de 6 à 12 mois suffit pour reconnaître le caractère définitif.
- **Un diabète gras** ne peut en aucun cas être considéré comme imputable à un traumatisme intercurrent : l'état antérieur de surcharge pondérale, les antécédents familiaux analogues suffisent à rejeter l'imputabilité. Il ne peut s'agir alors que d'un diabète découvert à l'occasion du traumatisme, jamais d'un diabète créé par le traumatisme lui-même. Parfois, cependant, l'accident a pu provoquer une aggravation temporaire d'un diabète latent et méconnu, avec une poussée d'acidocétose qui nécessitera pendant une courte période un apport insulinique ; puis la maladie diabétique continuera à évoluer pour son propre compte, sans incidence durable du traumatisme intercurrent.

Evaluation du taux d'incapacité permanente :

Après qu'ait été obtenue la stabilisation d'un diabète insulino-dépendant post-traumatique, on prend en compte :

- La contrainte thérapeutique, variable selon la complexité du traitement insulinique obligatoire.
- Les conséquences souvent notables sur l'activité quotidienne (restrictions qualitatives et quantitatives).
- La nécessité d'une surveillance médicale régulière, de fréquence variable selon les cas.
- L'instabilité éventuelle du diabète, ses fluctuations évolutives, génératrices lorsqu'elles existent, d'importantes restrictions de fait dans les capacités d'action du sujet.

Les taux d'incapacité proposés se situent en général entre **20 et 40% parfois plus**.

Diabète insulino-dépendant, bien équilibré, une à 2 injections d'insuline par 24H, ou insuline à la pompe, quelques fluctuations qui restent modérées, sans altération de l'état général.....20 à 30%

Diabète insulino-dépendant, mal équilibré, avec de grandes fluctuations nécessitant de nombreuses adaptations, et générant des malaises retentissant sur l'état général.....30 à 40%

Par ailleurs l'expert devra fournir des indications complémentaires sur les conséquences professionnelles (réorientation éventuelle, restrictions de capacité de travail...) et sur les complications à moyen terme et à long terme de la maladie diabétique (complications vasculaires en particulier).

7-5-4-2/ Diabète insipide

Diabète insipide, polyurie polydipsie résiduelle lorsqu'elle existe, contraintes thérapeutiques (traitement substitutif habituellement par voie nasale en une à deux prises quotidiennes), polyurie bien contrôlée, vie sociale normale jusqu'à 5%
Diabète insipide, polyurie-polydipsie résiduelle, contraintes thérapeutiques (traitement substitutif habituel par voie nasale en une à deux prises quotidiennes), résultat incomplet, parfois avec intrication d'un syndrome de type potomanie à composante psychogène..... jusqu'à 20%

7-5-4-3/ Insuffisance anté-hypophysaire

Insuffisance antéhypophysaire, six mois à un an après la mise en œuvre du traitement substitutif, en fonction de la qualité des résultats obtenus sur les signes cliniques invalidants (asthénie, frilosité, stérilité, frigidité,...), des limitations de l'activité et de l'importance des contraintes thérapeutiques 10 à 30%

7-5-4-4/ Thyroïde

Hyperthyroïdie traitée, en l'absence de manifestation fonctionnelle, et selon les contraintes de soins et de surveillance jusqu'à 10%
Hyperthyroïdie, mal contrôlée par un traitement médical, avec trouble fonctionnel persistant (nervosisme, fatigabilité, amaigrissement, perturbation de la thermorégulation, tachycardie, signes oculaires...) formes habituellement accessibles à un traitement chirurgical, en fonction des contraintes de soins et de surveillance 10 à 20%
Hyperthyroïdie avec contraintes thérapeutiques importantes, ne maîtrisant pas les troubles fonctionnels marqués, perturbant la vie quotidienne 20 à 30%
Hypothyroïdie nécessitant un traitement substitutif, sans signe fonctionnel retentissant sur la vie quotidienne jusqu'à 10%
Hypothyroïdie, en fonction des troubles fonctionnels persistants (prise de Poids, asthénie, ralentissement idéomoteur, frilosité...) et des contraintes thérapeutiques et de surveillance 10 à 20%
Hypothyroïdie avec contraintes thérapeutiques importantes, ne maîtrisant pas les troubles fonctionnels marqués, perturbant la vie quotidienne 20 à 30%

7-5-4-5/ Parathyroïde

Hypoparathyroïdie traitée par vitamine D et calcium, sans signe fonctionnel retentissant sur la vie quotidienne jusqu'à 10%
Hypoparathyroïdie, en fonction de la fréquence des crises de tétanie, des manifestations neurovégétatives, des contraintes thérapeutiques et de surveillance 10 à 20%

7-5-4-6/ Insuffisance surrénalienne

Insuffisance surrénalienne après correction par traitement corticoïde substitutif et observance d'un régime bien salé, en l'absence d'effet indésirable du traitement au long cours jusqu'à 10%
Insuffisance surrénalienne après correction par traitement corticoïde substitutif, en fonction des effets indésirables du traitement au long cours (syndrome de Cushing iatrogène), et de la surveillance 10 à 30%

7-5-5/ Spléniques

Les progrès de la chirurgie permettent actuellement un traitement conservateur dans les traumatismes de la rate : splénectomie partielle, suture, emballage dans un filet résorbable, transplantation de fragments spléniques dans l'épiploon, etc... évitent la disparition totale des fonctions spléniques.

La splénectomie totale engendre en effet un double risque, infectieux et thrombotique :

- le risque infectieux est maximum chez l'enfant avant l'âge de cinq ans (le risque est majoré dans les 2 ans qui suivent la splénectomie) et peut justifier un traitement prophylactique (pénicilline orale durant 2 à 5 ans) ;
- le risque thrombotique, en rapport avec l'hyperplaquettose, peut persister après 1 ou 2 ans après la splénectomie. Un traitement préventif anti-agrégant plaquettaire n'est indiqué que si le nombre des plaquettes est très élevé (1 million par mm³).

Méthodologie de l'expertise d'un splénectomisé :

- Etat antérieur éventuellement pathologique de la rate enlevée,
- Type d'intervention réalisée, avec ou sans conservation de l'organe ;
- Recherche d'anomalies érythrocytaires (corps de Jolly) leur présence est un stigmate d'asplénie ou d'hyposplénie. Leur absence indique la présence de tissu splénique fonctionnel.
- Numération des Plaquettes : l'hyperplaquettose initiale, qui régresse habituellement en quelques mois, peut persister définitivement (300 000 à 500 000) impliquant un risque de thrombose.

Evaluation de l'incapacité permanente. Indépendamment d'éventuelles séquelles pariétales

- Traitement conservateur, aucune anomalie clinique ni hématologique jusqu'à 5%
- Splénectomie totale, aucune anomalie clinique ni hématologique, (taux justifié par les contraintes et les précautions dans la vie courante) 8 %
- Splénectomie totale, persistance d'anomalies hématologiques légères, fatigabilité 10%
- Splénectomie totale, persistance d'anomalies hématologiques et risque de thrombose 15%

8/ Néphrologie – Urologie

Les troubles de la fonction urinaire ne feront l'objet d'une évaluation spécifique que s'ils constituent l'essentiel du déficit physiologique. Lorsque ces troubles font partie d'un ensemble pathologique consécutif à des lésions médullaires, l'évaluation du taux d'IPP se fera globalement au titre de l'entité clinique en cause.

L'évaluation des séquelles traumatiques de l'appareil urinaire se fait sur la base de la détermination de l'importance du déficit fonctionnel des reins et des voies urinaires.

8-1/ Néphrologie :

Les séquelles néphrologiques sont essentiellement en rapport avec le degré d'altération de la fonction rénale.

8-1-1/ Néphrectomie unilatérale :

Malgré l'absence de retentissement appréciable sur la fonction rénale, on admet chez le sujet de moins de 50 ans, compte tenu des précautions à prendre et des restrictions qui peuvent en résulter dans la vie courante, un taux d'incapacité permanente de **10 à 15 %**.

Après 50 ans, le taux peut être un peu plus élevé compte tenu du caractère souvent incomplet de la compensation par le rein restant. Le taux sera alors déterminé en fonction de l'insuffisance rénale relative : en général **15 à 20%**.

Néphrectomie partielle (polaire par exemple)**5 à 10%**

8-1-2/ Insuffisance rénale :

L'évaluation du taux d'incapacité permanente prendra en compte les perturbations biologiques, le retentissement sur l'état général, les modalités de régime et de traitement selon le schéma suivant :

Insuffisance rénale légère

Clairance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn

HTA égale ou inférieure à 16/9.....**jusqu'à 15%**

Insuffisance rénale modérée

Clairance de la créatinine entre 40 et 60 ml/mn

HTA avec minima égale ou inférieure à 12

Asthénie

Régime et traitement médical.....**15 à 30%**

Insuffisance rénale sévère

Clairance de la créatinine entre 15 et 40 ml/mn.....**30 à 50%**

Insuffisance rénale grave

Clairance de la créatinine inférieure à 15 ml/mn

HTA sévère (minima supérieure à 12)

Epuration extra-rénale nécessaire.....**50 à 80%**

(selon le type d'épuration et les contraintes qui en résultent)

L'insuffisance rénale traitée par greffe de rein, avec un résultat satisfaisant, justifie un taux d'incapacité permanente minimum de.....20%

Taux tenant compte du traitement immuno-suppresseur. Ce taux est modulé en fonction de l'insuffisance rénale éventuelle.

8-2/ Urologie :

L'évaluation des séquelles urologiques se fait en fonction de quatre paramètres :

- la dysurie
- la rétention urinaire
- l'incontinence urinaire
- la nécessité de dérivations urinaires.

Les taux proposés prennent en considération les complications et les contraintes thérapeutiques.

8-2-1/ Dysurie- Pollakiurie en rapport avec une sténose de l'urètre avec diminution du débit urinaire :

L'évaluation du taux d'incapacité permanente est fonction du nombre de dilatations urétrales nécessaires pratiquées par an.

- 1 à 2 dilatations par an (sténose peu sévère).....**jusqu'à 10%**
- Nécessité de 3 à 10 dilatations par an**10 à 20%**
- Nécessité de plus de 10 dilatations par an **20 à 30%**

8-2-2/- Rétention d'urines (hors pathologie médullaires ou centrales) :

- Miction par percussion sus-pubienne.....**5 à 15%**
- Auto- ou hétéro-sondage intermittent (3 à 6 fois par jour)**15 à 25%**
- Sonde à demeure avec collecteur et poche.....**20 à 30%**

La mise en place d'un stimulateur sacré implantable justifie l'attribution d'une incapacité permanente allant jusqu'à 5%, ne tenant pas compte des conséquences propres de l'acte chirurgical (cicatrice ou fibrose douloureuse, complication...).

8-2-3/- Incontinence urinaire :

- Fuites rares ne nécessitant pas de protection.....**jusqu'à 8%**
- Fuites régulières à l'effort nécessitant une protection épisodique **10 à 15%**
- Incontinence absolue nécessitant une protection permanente.....**15 à 25%**
- Sphincter artificiel (selon efficacité du traitement)**5 à 10%**
- Envies impérieuses**5 à 15%**

8-2-4/ Dérivations urinaires définitives :

Le taux d'IPP est fonction du siège et de la bilatéralité de (s) dérivation (s) pratiquée (s) :

- Cystostomie.....**25 à 35%**
- Néphrostomie unilatérale.....**15 à 20%**
- Néphrostomie bilatérale.....**30 à 40%**
- Urétérostomie transiléale ou transcolique**20 à 30%**
- Urétérostomie unilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche**15 à 20%**
- Urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche**30 à 40%**

9/ Procréation Sexualité

Les atteintes anatomiques et les troubles physiologiques du tractus génital ainsi que tout dysfonctionnement dans la réalisation de l'acte sexuel peuvent compromettre la fonction de la sexualité et de la reproduction. L'examen clinique et les investigations complémentaires permettent à l'expert, dans certaines limites, d'attester la réalité du déficit fonctionnel qui sert de base pour l'estimation du taux d'incapacité permanente.

Il est important de noter que certaines atteintes se soldent par une stérilité absolue. Les atteintes du tractus génital qui se soldent par une suppression de la fonction de la procréation entraînent un préjudice plus important chez la femme (ou l'homme) en âge de procréer.

9-1/ Ablation d'organes :

Le taux d'incapacité permanente est estimé en fonction de la nature de l'organe atteint et de la bilatéralité éventuelle de l'atteinte pour les organes pairs.

Ce taux ne tient pas compte d'un éventuel déficit de la fonction de la reproduction (stérilité).

Chez la femme :

- Mastectomie unilatérale.....**5 à 15%**
- Mastectomie bilatérale.....**15 à 20%**
- Hystérectomie (selon âge, ménopause, capacité physiologique de reproduction)**10 à 40%**
- Ovariectomie : . unilatérale.....**5 à 10%**
 . bilatérale.....**10 à 15%**

Ce taux ne tient pas compte des troubles endocriniens engendrés par l'ablation des gonades.

- Salpingectomie : . unilatérale.....**5 à 10%**
 . bilatérale.....**10 à 15%**

Chez l'homme :

- Orchidectomie : . unilatérale.....**5 à 10%**
 . bilatérale.....**10 à 15%**

Ce taux ne tient pas compte des troubles endocriniens engendrés par l'ablation des gonades.

- Amputation de la verge**10 à 50%**

Ce taux incluant l'ensemble des troubles de la fonction sexuelle et de la miction, est variable selon l'étendue de l'amputation.

9-2/ Stérilité :

Chez l'homme :

L'évaluation des séquelles nécessite une analyse approfondie et des explications détaillées des conséquences qu'il comporte. Le dommage peut être évalué par un taux d'incapacité selon le schéma suivant :

- Castration unilatérale (selon le retentissement psychologique).....**5 à 10%**
- Impuissance sexuelle, totale ou partielle : impossibilité ou difficulté de rapports sexuels quelles qu'en soient les causes, organiques (locales ou neurologiques) ou psychogènes**25 à 30%**
- Impuissance totale corrigée mécaniquement par la mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique.....**15 à 20%**
- Stérilité ou diminution de fertilité, sans impuissance sexuelle.....**25 à 30%**
- Stérilité avec Stérilité avec impuissance sexuelle (perte totale de la fonction sexuelle).....**40%**

L'expert tiendra compte pour fixer son évaluation dans le cadre des fourchettes proposées, de l'âge du blessé, du caractère plus ou moins complet du déficit, du vécu psychologique personnel et conjugal.

Chez la femme :

L'évaluation de l'incapacité résultant de séquelles gynécologiques et psychosexuelles sera faite en fonction du schéma suivant :

- Frigidité, dyspareunie ou toute autre perturbation psychosexuelle dont l'imputabilité aura pu être établie**10 à 20%**
- Stérilité selon les possibilités de traitement par les techniques modernes de procréation médicalement assistée et selon l'âge..... **15 à 30%**
- Perte totale de la fonction sexuelle (frigidity et stérilité).....**40%**
- Algies pelviennes imputables aux séquelles traumatiques.....**5 à 10%**
- Fistules vésico-vaginales, fistules recto-vaginales**10 à 30%**

Décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d'assurance maladie et ses étapes d'application.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l'étranger ;

Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance sociale en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998 ;

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension, de vieillesse, d'invalidité et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole ;

Vu la loi n° 72-02 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires ; ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-60 du 28 Juillet 1997 ;

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi des finances pour la gestion 1976 et notamment ses articles 28 et 34 ;

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-61 du 27 juillet 1997 ;

Vu la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement telle que modifiée par la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85 ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002;

Vu la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85 ;

Vu la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs telle que modifiée par la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85 ;

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, créateurs et intellectuels ;

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment ses articles 15 et 29 ;

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers ;

Vu le décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale tel que modifié par le décret n° 88-186 du 6 février 1988 ;

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs Tunisiens à l'étranger ;

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 ;

Vu décret n° 1645-97 relatif à la détermination des conditions et modalités de bénéfice de la réduction du taux de cotisations à la sécurité sociale pour les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel

Vu le décret n° 2003-894 du 21 avril 2003, fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels ;

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n°2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,

Vu l'avis du Ministre des Finances,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète

Titre I : Dispositions Générales

Article premier: L'assiette des cotisations dues au titre du régime de base d'assurance maladie, prévue à l'article 15 de la loi n° 2004-71 susvisée, est assise pour les agents en activité sur:

- les éléments permanents de la rémunération soumis à retenu pour pension, déterminés conformément à la législation en vigueur, pour les assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- l'ensemble des salaires, primes, émoluments et indemnités ou catégorie de revenu correspondante à l'activité de l'assuré social, prévus par les différents textes législatifs et réglementaires des régimes de sécurité sociale, pour les assurés sociaux affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 2 : L'assiette des cotisations visée à l'article 1er du présent décret est assise pour les bénéficiaires de pension sur le montant brut de la pension fixé conformément à la législation en vigueur.

Titre II : Les cotisations des agents en activité

Art.3 : Le taux de cotisation au titre du régime de base d'assurance maladie prévu par l'article 15 de la loi n° 2004-71 susvisée et fixé à 6,75 % est prélevé pour les assurés sociaux en activité conformément à la progressivité prévue par les dispositions du présent titre.

Chapitre 1 : Les cotisations des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale

Art. 4 : Le taux de cotisations prévu à l'article 3 du présent décret s'applique pour les assurés sociaux en activité affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime obligatoire de prévoyance sociale en application, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007 ,Le taux de cotisations est fixé à 3 % de l'assiette des cotisations prévue à l'article premier du présent décret réparti comme suit :

- 2 % au titre des cotisations en application à la date de l'entrée en vigueur du présent décret et prévu par le décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale susvisé.
- 1% au titre des cotisations supplémentaires à la charge de l'employeur.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu par le sous paragraphe 1 du présent article est relevé de 3% à 4,88%, le taux de cotisations supplémentaire fixé à 1,88% se répartit comme suit :

- 1% à la charge de l'employeur.
- 0,88% à la charge de l'employé

3) A compter du 1^{er} juillet 2009 le taux de cotisation prévu par le sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 4,88% à 6,75%, le taux de cotisations supplémentaires fixé à 1,87% se répartit comme suit :

- 1% à la charge de l'employeur.
- 0,87% à la charge de l'employé.

Art.5 : En application des dispositions de l'article 15 de la loi 2004-71 du 2 août 2004 susvisée, le taux de cotisations dues au titre des assurés sociaux en activité affiliés, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, au régime facultatif d'assurance maladie institué par la loi n° 72-2 du 15 février 1972 susvisée, fixé à 6,5% par le décret n°86-186 du 6 février 1986 y compris le taux de cotisations dues au titre du régime obligatoire de prévoyance sociale en application à la date de l'entrée en vigueur du présent décret est augmenté à 6,75% conformément aux modalités suivantes :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007 :

- le taux de cotisations à la charge de l'employeur, fixé à 2,5% à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est augmenté à 3% ;
- le taux de cotisations à la charge de l'employé, fixé à 4% à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, est diminué à 3,75%.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008 :

- le taux de cotisations à la charge de l'employeur visé au premier tiret du sous paragraphe 1er du présent article est augmenté de 3% à 3,5% ;
- le taux des cotisations à la charge de l'employé visé au deuxième tiret du premier sous paragraphe du présent article est diminué de 3,75% à 3,25%.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009 :

- le taux de cotisations à la charge de l'employeur visé au premier tiret du sous paragraphe 2 du présent article est augmenté de 3,5% à 4% ;
- le taux de cotisations à la charge de l'employé visé au deuxième tiret du sous paragraphe 2 du présent article est diminué de 3,25% à 2,75%.

Chapitre 2 : Les cotisations des affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale

Art.6 : Le taux de cotisations prévu par l'article 3 du présent décret, dû au titre du régime de base d'assurance maladie, s'applique pour les assurés sociaux en activité, affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés dans le secteur non agricole, comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux de cotisations dû, est fixé à 5,32% de l'assiette des cotisations prévue à l'article premier du présent décret, et se répartit à raison de :

- 4,75% prélevé sur le ^{taux} global des cotisations prévu par la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 susvisée.
- 0,57% au titre des cotisations supplémentaires à la charge de l'employeur.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 1^{er} du présent article est relevé de 5,32 à 6,04%, le taux des cotisations supplémentaires est supporté, en totalité, par le salarié.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 6,04% à 6,75%, le taux de cotisations supplémentaires est supporté, en totalité, par le salarié.

Art.7 : Le taux de cotisations prévu à l'article 3 du présent décret, dues , au titre du régime de base d'assurance maladie, des assurés sociaux en activité affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur agricole institué par la loi n° 81-6 du 12 février 1981 susvisée, s'applique comme suit :

- 1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux de cotisations dues est fixé à 1,58% de l'assiette des cotisations prévue au premier article du présent décret, et se répartit à raison de :
 - 0,91% prélevé sur le taux global des cotisations prévues par la loi n°81-6 du 12 février 1981 susvisée;
 - 0,67% au titre des cotisations supplémentaires à la charge de l'employeur.
- 2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 1^{er} du présent article est relevé de 1,58% à 2,88%, le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 1,3%, se répartit comme suit :
 - 0,67% à la charge de l'employeur ;
 - 0,63% à la charge du salarié.
- 3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 2,88% à 4,17%, le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 1,29%, se répartit à raison de :
 - 0,66% à la charge de l'employeur;
 - 0,63% à la charge du salarié.
- 4) A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 3 du présent article est relevé de 4,17% à 5,46%, le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 1,29%, se répartit à raison de :
 - 0,66% à la charge de l'employeur ;
 - 0,63% à la charge du salarié.
- 5) A compter du 1^{er} juillet 2011, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 4 du présent article est relevé de 5,46% à 6,75%, le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 1,29%, se répartit à raison de :
 - 0,66% à la charge de l'employeur ;
 - 0,63% à la charge du salarié.

Art.8 : Le taux de cotisations dû, au titre du régime de base d'assurance maladie, des assurés sociaux en activité, affiliés au régime de sécurité sociale dans le secteur agricole et travaillant dans quelques entreprises agricoles, institué par la loi n°89-73 du 2 septembre 1989 modifiant et complétant la loi n° 81-6 du 12 février 1981 susvisée, s'applique comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux de cotisations dues , est fixé à 2,9% de l'assiette des cotisations prévue à l'article premier du présent décret, et se répartit à raison de :

-2,28% prélevé sur le taux global des cotisations prévu par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989 susvisée,

-0,62% au titre des cotisations supplémentaires supporté en totalité par les travailleurs exerçant pour leur propre compte et par l'employeur au titre des salariés exerçant sous son autorité.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 1 du présent article est relevé de 2,9% à 4,19%, le taux d'augmentation supplémentaire, fixé à 1,29%, est supporté en totalité par les travailleurs exerçant pour leur propre compte et cette augmentation se répartit pour les travailleurs salariés à raison de 0,62% à la charge de l'employeur et 0,67% à la charge du salarié.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 4,19% à 5,47%, le taux d'augmentation supplémentaire fixé à 1,28% est supporté en totalité par les travailleurs exerçant pour leur propre compte, et cette augmentation se répartit pour les travailleurs salariés à raison de 0,62% à la charge de l'employeur et de 0,66% à la charge du salarié.

4) A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 3 du présent article est relevé de 5,47% à 6,75%, le taux d'augmentation supplémentaires fixé à 1,28% est supporté en totalité par les travailleurs établis pour leur propre compte, et cette augmentation se répartit pour les travailleurs salariés à raison de 0,62% à la charge de l'employeur et 0,66% à la charge du salarié.

Art.9 : Le taux de cotisations prévu à l'article 3 du présent décret, dû au titre du régime de base d'assurance maladie, s'applique, pour les assurés sociaux en activité affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs tunisiens à l'étranger comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux des cotisations dû, est fixé à 4,99% de l'assiette des cotisations prévue à l'article premier du présent décret, supporté par l'affilié à ce régime et se répartit à raison de :

-4,10% prélevé sur le taux global des cotisations prévu au décret n°89-107 du 10 janvier 1989 susvisé,

-0,89% au titre des cotisations supplémentaires.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux des cotisations prévu au sous paragraphe 1 du présent article est relevé de 4,99% à 5,87%, et le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 0,88%, est supporté par les affiliés à ce régime.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 5,87% à 6,75%, le taux de cotisations supplémentaires, fixé à 0,88%, est supporté par les affiliés à ce régime.

Art.10 : Le taux de cotisations prévu à l'article 15 de la loi n°2004-71 du 2 août 2004 susvisée, dû au titre du régime de base d'assurance maladie, s'applique, pour les assurés sociaux en activité affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux de cotisations dû est fixé à 3,97% de l'assiette des cotisations prévue à l'article premier du présent décret, est supporté par l'affilié à ce régime et se répartit au taux de :

-3,04% prélevé sur le taux global des cotisations prévu par le décret n°95-1166 du 3 juillet 1995 concernant le régime susvisé de sécurité sociale.

-0,93% au titre des cotisations supplémentaires.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 1 du présent article est relevé de 3,97% à 4,9%.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 4,9% à 5,83%.

4) A compter du 1^{er} juillet 2010 le taux des cotisations prévu au sous paragraphe 3 du présent article est relevé de 5,83% à 6,75%.

Art.11 : Le taux de cotisations prévu à l'article 15 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 susvisée et dû au titre de régime de base d'assurance maladie pour les assurés sociaux en activité au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et intellectuels institué par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée, s'applique comme suit :

1) A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux de cotisations dû est fixé à 3,97% de l'assiette des cotisations prévues à l'article premier du présent décret et se répartit raison de :

-3,04% prélevé sur le taux global des cotisations prévu par la loi 2002-104 du 30 décembre 2002 susvisée.

-0,93% au titre des cotisations supplémentaires.

2) A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 1 du présent article est relevé de 3,97% à 4,9%.

3) A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 2 du présent article est relevé de 4,9% à 5,83%.

4) A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux de cotisations prévu au sous paragraphe 3 du présent article est relevé de 5,83% à 6,75%.

Titre III : les cotisations des titulaires de pensions

Art.12 : Le taux de cotisations dues au titre du régime de base d'assurance maladie, défini à l'article 15 de la loi 2004-71 du 2 août 2004 susvisée, fixé à 4% sur la base de l'assiette des cotisations prévues à l'article 2 du présent décret, est prélevé, pour les titulaires de pension, conformément à la progressivité prévue par les dispositions du présent titre.

Chapitre 1 : les cotisations des titulaires de pensions affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale

Art.13 : Le taux de cotisations dues au titre du régime de base d'assurance maladie, concernant les titulaires de pensions affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime obligatoire de prévoyance sociale en application à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, s'applique comme suit :

-A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux des cotisations est fixé à 1% .

-A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux des cotisations est fixé à 2%.

-A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux des cotisations est fixé à 3%.

-A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux des cotisations est fixé à 4% .

Art.14 : Le taux des cotisations dues au titre du régime de base d'assurance maladie, s'applique, pour les titulaires de pensions affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au titre du régime facultatif d'assurance maladie, y compris le taux de cotisations dues au titre du régime obligatoire de prévoyance sociale en application à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, , comme suit :

- A compter du 1^{er} juillet 2007, le taux des cotisations est fixé à 3%.
- A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux des cotisations est fixé à 3,34%.
- A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux des cotisations est fixé à 3,67%.
- A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux de cotisations est fixé à 4%.

Chapitre 2 : les cotisations des titulaires de pensions affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale

Art.15 : Le taux des cotisations dues au titre du régime de base d'assurance maladie s'applique, pour les titulaires de pensions affiliés aux différents régimes de sécurité sociale prévus par le décret n°2007-1366 du 11 juin 2007 portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale susvisé, comme suit :

- A compter du 1^{er} juillet 2008, le taux des cotisations est fixé à 1%,
- A compter du 1^{er} juillet 2009, le taux des cotisations est fixé à 2%,
- A compter du 1^{er} juillet 2010, le taux des cotisations est fixé à 3%,
- A compter du 1^{er} juillet 2011, le taux des cotisations est fixé à 4%.

Art.16 : Le présent décret entre en vigueur à compter du premier juillet 2007, et sont abrogées dès lors toutes les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du décret 97-1645 du 25 août 1997 susvisé.

Art.17 : Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Tunis, le 18 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali



Edition : 2006

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

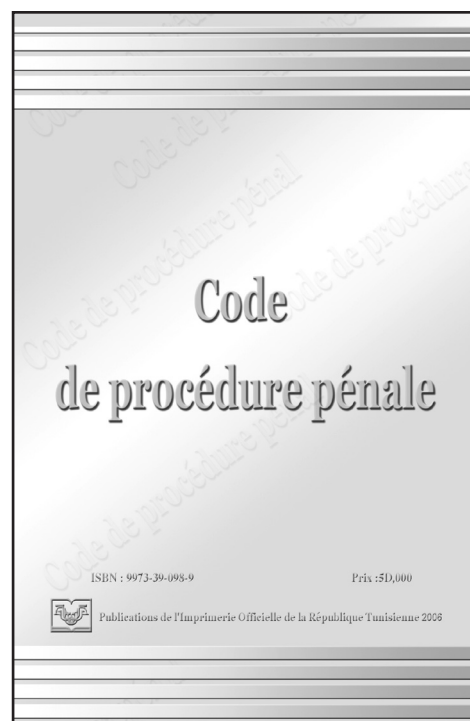
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

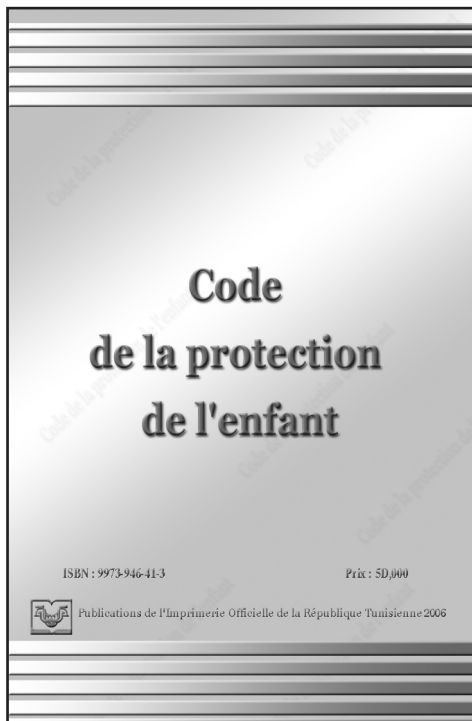


* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة



Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

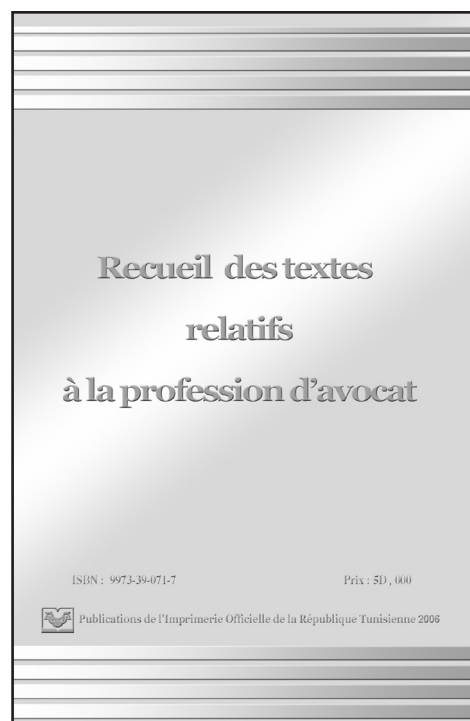
Edition : 2006

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

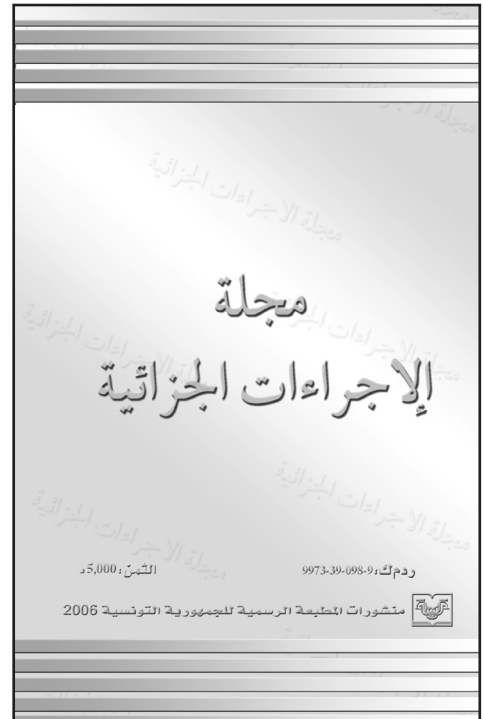
منشورات : 2006



ردمك 9973-39-095-4
عدد الصفحات : 448 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثلث : 10,000 د

منشورات : 2006

ردمك 9973-39-098-9
عدد الصفحات : 297 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثلث : 5,000 د



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثلث 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006



ردمك 9973-946-41-3
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثنى : 5,000 د

منشورات : 2006



ردمك 9973-39-071-7
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثنى : 5,000 د

* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثنى 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.